Teil III

Klinische und Persönlichkeits-Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

8 Klinische Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen

Julian Busch, Birgit Leyendecker & Rainer G. Siefen

8.1 Grundlagen aus der Transkulturellen Psychologie

8.1.1 Zielsetzung des Buchbeitrages

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund stellen eine besonders heterogene Patientengruppe in der psychiatrisch-psychologischen Versorgung dar.[1] Diese umfasst minderjährige Personen, die neben der Bewältigung universeller Entwicklungsaufgaben häufig Anpassungsleistungen aufgrund ihrer Herkunft vollbringen müssen. Im diagnostischen Prozess können der Stellenwert der Familie, die Umstände und Motive der familiären Migration, sowie die Umgangsformen mit mentalem Leiden besondere Bedeutung haben. Wie kann eine vorurteilsfreie und valide klinische Diagnostik gelingen? Idealerweise sollte das Vorliegen eines Migrationshintergrunds keinen Einfluss auf die Qualität der Diagnosestellung haben, und den Erfolg einer Behandlung nicht beeinträchtigen. Ziel dieses Buchbeitrages ist es, zur Entwicklung von Handlungskompetenz und -sicherheit in der klinischen Diagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund beizutragen. Hierzu werden zunächst Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld „Transkulturelle Psychologie" mit Bezug zur diagnostischen Situation dargestellt. Im Hauptteil werden diagnostische Prozesse, Besonderheiten und Herausforderungen im Umgang mit Minderjährigen mit Migrationshintergrund erläutert. Zusammenfassend werden 12 Leitsätze für Behandler[2], Forscher und gesundheitspolitische Akteure for-

1 Schenk et al. (2006) sowie Sauer und Brinkmann (2016, S. 8) gebrauchen die Termini *Migranten* und *Personen mit Migrationshintergrund* gleichermaßen als Oberbegriff für sowohl Personen mit eigener Zuwanderungserfahrung als auch Menschen nachfolgender Einwanderungsgenerationen. In Anlehnung an diese Ausführung und zur weiterführenden begrifflichen Trennung werden in diesem Beitrag jene Personen mit eigener Migrationserfahrung – Migranten erster Generation – als *Zugewanderte* bezeichnet.

2 Gemeint sind sowohl die männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit werden nachfolgend personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, nur in der männlichen Form angeführt.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

muliert. Schwerpunkte liegen auf dem Einsatz von Dolmetschern sowie auf der Anwendung standardisierter Diagnoseverfahren. Dazu wird eine Auswahl geeigneter klinisch-diagnostischer Verfahren für zugewanderte Minderjährige bereitgestellt. Angesichts aktueller Entwicklungen wird ergänzend auf die klinische Diagnostik bei geflüchteten Minderjährigen eingegangen.

8.1.2 Notwendigkeit kultursensitiver Diagnostik

Die internationale UN-Kinderrechtskonvention von 1989 sichert Minderjährigen unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsort Schutz und Versorgung zu (United Nations, 1989). Dies schließt das Recht auf eine angemessene Gesundheitsversorgung ein. Im Bereich der deutschsprachigen Psychotherapie stellt eine angemessene Diagnostik bereits bei deutschen Kindern eine Herausforderung dar – besonders dann, wenn sie noch sehr jung sind und diagnostische Verfahren nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Eine valide Diagnostik erfordert in den meisten Fällen daher den Einbezug der Eltern und des sozialen Kontexts. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich, wenn Kinder, Jugendliche und ihre Eltern einen Migrationshintergrund haben? Wie kann die häufig vorhandene Sprachbarriere überwunden werden? Welchen Stellenwert haben ggf. die kulturellen Unterschiede im Rahmen von Diagnostik und Behandlung? Aktuelle Bevölkerungsstatistiken verdeutlichen die zunehmende Bedeutung dieser Fragen: Mehr als ein Drittel aller in Deutschland aufwachsenden Kinder weist eine eigene oder familiäre Migration in ihrer Biographie auf. Die zahlenmäßig bedeutsamsten Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund stammen aus der Türkei (17 %), Polen (10 %) und der Russischen Föderation (7 %) (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016a). Viele Minderjährige mit Migrationshintergrund haben mindestens einen Elternteil, der bereits selbst in Deutschland aufgewachsen ist (Kalter & Schroedter, 2010) und daher mit der hiesigen Kultur und Sprache vertraut sein sollte. Jedoch gibt es durch die EU-Osterweiterung und die große Zahl von Geflüchteten seit Kurzem auch eine große neuzugewanderte Gruppe (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016b); vermutlich sind beide Elternteile dieser Kinder und Jugendlichen aufgrund ihrer kürzeren Aufenthaltsdauer bislang nur in sehr geringem Ausmaß mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut.

Die kulturelle Diversität in Deutschland hat durch Zuwanderung deutlich zugenommen. Hinzu kommen die teilweise erheblichen Unterschiede innerhalb der verschiedenen Kulturen, die maßgeblich durch Religiosität, Bildungsstand und Migrationsmotive beeinflusst sind (Leung & Cohen, 2011). So können aus Nationen wie der Türkei sowohl Familien zuwandern, deren Erfahrungen durch eine traditionell ländliche, archaische Gesellschaft geprägt sind, als auch Familien aus Großstädten, deren Lebensstil sich in vielerlei Hinsicht eher weniger von dem westlicher Industrienationen unterscheidet. In vielen Herkunftsländern leben zudem unterschiedliche Volksgruppen, die sich durch Religion, politische Orien-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

tierung oder Tradition stärker voneinander abgrenzen als Menschen in Deutschland. An die Therapeuten werden deshalb hohe Anforderungen hinsichtlich ihrer Flexibilität im Umgang mit Familien mit Migrationshintergrund sowie ihrer Selbstreflexivität in Bezug auf die eigene Kultur gestellt. Darauf weist auch die wissenschaftliche Definition von „Kultur" hin: „Kultur beschreibt ein Bündel von Einstellungen (Überzeugungen, Werten, kollektiven Wissens, Aberglaube, Stereotypen), Verhaltensweisen (Variation von Normen, Rollen, Gewohnheiten, Traditionen, Bräuchen), und Symbolen (Objekten oder Ideen, denen spezielle Bedeutung zugeschrieben wird), die von einer großen Gruppe von Menschen geteilt werden" (Shiraev & Levy, 2014, S. 27; Übersetzung durch die Autoren). Häufig verdeutlicht erst der Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen, wie viel von dem eigenen Denken und Handeln durch die eigene kulturelle Prägung beeinflusst ist.

Die Herkunftskultur kann als latente, häufig unbewusste Brille begriffen werden, durch welche die Umwelt seit der Kindheit wahrgenommen und gedeutet wird. Welche versteckten Vorurteile und negativen Einstellungen haben Menschen? Welche davon kommen – bewusst oder unbewusst – zum Ausdruck? Erfahren Kinder und ihre Eltern mit Migrationshintergrund, dass ihre Probleme nicht verstanden oder nicht ernst genommen werden? Die psychotherapeutische Diagnostik bzw. Behandlung von Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturen birgt im Besonderen die Gefahr, dass Wahrnehmungen eingeschränkt oder verfälscht werden, und dass Aussagen sowie Handlungen falsch interpretiert werden. Aus der Sicht von Familien mit Migrationshintergrund gilt dasselbe: Kinder sowie deren Eltern können Fragen und Hinweise im interkulturellen Behandlungssetting leicht missverstehen (Probst, Laditka, Moore, Harun & Powell, 2007).

8.1.3 Familien in unterschiedlichen Kulturen

So unterschiedlich die Herkunftskulturen und die individuellen Lebenssituationen zugewanderter Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien sein können – zwei Gemeinsamkeiten teilen viele von ihnen. Die erste betrifft den Stellenwert der Familie. Während in Deutschland ein individualistisches Gesellschaftssystem dominiert, stammen die meisten zugewanderten Familien aus Ländern, die eher soziozentrisch orientiert sind (Bierbrauer, 1994). Zu Letzteren zählen beispielsweise die Türkei und Syrien. In soziozentrischen Gesellschaftssystemen wird der Familie ein hoher Stellenwert beigemessen (Phalet & Schönpflug, 2001). Kinder knüpfen von Geburt an ein enges Band mit anderen Familienmitgliedern – auch über ihre Kernfamilie hinaus (Schulze, Harwood, Schoelmerich & Leyendecker, 2002). Dies hat Konsequenzen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Im Vergleich zu individualistischen Prägungen können diese Kinder Konflikte mit einem Elternteil oder anderen Familienmitgliedern als sehr viel bedrohlicher erleben. Weiterhin unterscheidet sich oftmals die Rolle der Eltern hinsichtlich ihrer Autorität zwischen den Gesellschaftssystemen. Wenn Familienmitglieder viel Verantwortung

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

füreinander übernehmen, können bei wichtigen Entscheidungen neben den Eltern andere Familienmitglieder – beispielweise Großeltern, Onkel oder Tanten – ein bedeutsames Mitspracherecht innehaben (Georgas et al., 2001).

Die klinische Praxis zeigt, dass viele zugewanderte Menschen keine oder nur wenig Erfahrung mit Psychologen haben. Dies kann kulturell bedingt sein – wenn Psychotherapie in der Herkunftskultur wenig bekannt oder verbreitet ist. Es kann aber auch mit einem niedrigen sozioökonomischen Status verbunden sein, insbesondere wenn verfügbare Therapien nicht finanzierbar waren. Wenn keine Möglichkeit zur Therapie gegeben ist, ist die Familie in stärkerem Maße für die Bearbeitung psychosozialer Probleme bedeutsam. Dabei kann es entlastend wirken, wenn die betroffene Person ihr Problem oder Erleben auf externe Ursachen zurückführt, die der Kontrolle des Einzelnen und der Familie entzogen sind (u. a. Schicksal, Gottes Willen) (Yavuz, 2008). Probleme, die als das Fehlverhalten von einzelnen Familienmitgliedern gelten, können auch mit Schande bewertet werden, die dann häufig auf die gesamte Familie zurückfällt (Sue & Sue, 1999). Ein türkisches Sprichwort lautet „Was auch immer in der Familie geschieht, bleibt das Geheimnis der Familie und sollte nicht an Außenstehende weitergegeben werden“ (Kol kırılır yen içinde, baş yarılır börk içinde kalır) – es beschreibt die Einstellung, dass psychische Probleme sowie Konflikte zwischen Familienmitgliedern ausschließlich die Familie angehen. Außenstehende werden oftmals nur dann um Rat gefragt, wenn der Leidensdruck einzelner Personen sehr groß ist und gleichzeitig innerhalb der Familie keine Lösung gefunden werden kann (Doğan, 2000). Deshalb kann es vor allem türkischstämmigen Familien schwer fallen, hiervon zu berichten. Zudem ist häufiger als in autochthonen Familien damit zu rechnen, dass es Familienmitgliedern missfällt, wenn ein Therapeut als außenstehende Person hinzugezogen wird. Wenn ein Kind oder seine Eltern Außenstehenden von ihren Schwierigkeiten berichten, können sie dies möglicherweise sehr ambivalent sehen und nicht nur erleichtert sein. Hier kann es wichtig sein, die Haltung abwesender Familienmitglieder zur Problemstellung abzuklären.

8.2 Spezifische Herausforderungen in der Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

8.2.1 Komplexität familiärer Migrationsbiographien

Die sehr unterschiedlichen Formen von Migration reichen von der Arbeitsmigration bis hin zu Vertreibung und Flucht. Einwanderung durch Familienzusammenführung gehört ebenfalls dazu (Belhadj Kouider & Petermann, 2015). Vielfältige familiäre Konstellationen resultieren, wenn einzelne Familienmitglieder zuerst

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

einwandern (etwa Arbeitsmigranten oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge), und dann weitere Familienmitglieder aus dem Herkunfts- oder aus einem Transitland durch Familienzusammenführung nachgeholt werden. Wenn ein Elternteil durch Heirat zugezogen ist, sind die Nachkommen häufig an der Herkunftskultur der Eltern orientiert. Adriaanse, Doreleijers, van Domburgh und Veling (2016) sind der Auffassung, dass Prävention und Behandlung auf der Ebene der spezifischen ethnischen Gruppenzugehörigkeit ansetzen sollten. Dies wird bei komplexen familiären Migrationsgeschichten den kulturellen und ethnischen Voraussetzungen der Kinder besser gerecht als die allgemeine Einordnung „familiärer Migrationshintergrund". Art und Ausmaß wanderungs- bzw. fluchtbedingter Belastungen werden genauer mit einer migrationsspezifischen modifizierten Anamneseerhebung erfasst. Hierzu wird die Verwendung diagnostischer Leitfäden empfohlen (z. B. „Hannover Interview Migration, Akkulturation und seelische Gesundheit", vgl. Calliess, Ünlü, Neubauer, Hoy, Machleidt & Behrens, 2009). Zu bedenken ist, dass Adaptation und Integration von zugewanderten Eltern oft viele Jahre dauern. Mindestens während dieser Zeit können sich manche von ihnen nicht so effektiv für die Gesundheits- und Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder einsetzen wie einheimische Eltern (Alba & Foner, 2015). Vor einer Überbetonung kultureller Zugehörigkeit und Migrationserfahrung warnt hingegen Achenbach (2015). In seinen empirischen Analysen konnten durch diese Faktoren bei über 70.000 Kindern aus 43 Ländern nur 0,8 bis 8,0 % der Varianz psychopathologischen Verhaltens aufgeklärt werden. Dennoch kann es für die konkrete Therapieplanung wichtig sein, zwischen migrationsbedingten und ethnokulturell zu erklärenden Aspekten von Verhaltensauffälligkeiten zu unterscheiden, selbst wenn eine Zuordnung nicht immer eindeutig möglich ist.

8.2.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen (Witt, Rassenhofer, Fegert & Plener, 2015). Nach einer Übersicht von Hebebrand, Anagnostopoulos, Eliez, Linse, Pejovic-Milovancevis und Klasen (2016) waren 26 % der in 2014 in die EU-28 eingewanderten Asylsuchenden minderjährig. Ohne ihre Eltern oder andere bisher Sorgeberechtigte kamen 14 % der Kinder und Jugendlichen; in dieser Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge waren 85 % männlich. Im März 2017 lebten 43.800 UMF in Deutschland. UMF werden als besonders vulnerable Gruppe für die Ausbildung psychopathologischer Symptome beschrieben. Sie haben mehr traumatische Erfahrungen gemacht als von den Eltern begleitete Kinder und Jugendliche (Ramel, Täljemark, Lindgren & Johansson, 2015; Witt et al., 2015). Diese Belastungen können vor, während oder nach der Migration aufgetreten sein. Die Diagnostik darf sich jedoch nicht einseitig auf diesen Aspekt fokussieren. Vielmehr müssen, wie bei allen Flüchtlingskindern, in die Diagnostik einbezogen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

werden: Entwicklungsbedingungen vor der Flucht, wirtschaftliche und soziale Situation der Familie im Herkunftsland, Bildungsbiographie sowie religiöse und kulturelle Orientierung. Zu den postmigratorischen Stressoren für UMF können ferner Probleme mit dem Aufenthaltsstatus und mit drohender Ausweisung zurück in das Herkunftsland oder andere europäische Länder gehören. Dabei variiert die legale und soziale Altersgrenze für Volljährigkeit zwischen Staaten und Kulturen. Zudem handelt es sich bei UMF um ein sehr heterogenes Klientel (Witt et al., 2015).

Nach einer schwedischen Untersuchung von Ramel et al. (2015) waren UMF in Schweden häufiger in ambulanter oder stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung als ihre einheimischen Altersgenossen – beispielsweise wegen mehr selbstverletzendem und suizidalem Verhalten. Wenn psychische Auffälligkeiten bestehen, verlaufen sie oft chronisch (Witt et al., 2015). Einerseits leiden UMF unter Heimweh sowie unter der Trennung von Angehörigen und von der Familie, andererseits können aber bereits vor der Flucht innerfamiliäre Konflikte bestanden haben (Schepker, Adam & Siefen, 2017). Häufiger als angenommen werden UMF von Angehörigen selbst – unter Inkaufnahme der erheblichen Risiken – geschickt. Die Migration soll zur Verbesserung der familiären Lebenssituation beitragen, beispielsweise durch die Rücksendung von Geld oder durch die Initiation des Familiennachzugs (Hebebrand et al., 2016; Siebenbürger, 2017; Reher & Metzner, 2016). Dennoch scheinen viele UMF resilient zu sein. Studienübergreifend konnte gefunden werden, dass bei einer Vielzahl dieser jungen Zuwanderer keine psychischen Auffälligkeiten festzustellen waren (Witt et al., 2015). Für alle jungen Flüchtlinge empfehlen Hebebrand et al. (2016) eine Stärkung ihrer Resilienz zur Minimierung des Risikos psychopathologischer Entwicklungsverläufe. Dazu trägt gerade bei UMF eine zukunftsorientierte Psychodiagnostik mit der gezielten Suche nach Ressourcen, verfügbaren Bewältigungsstrategien und Ansätzen zur Eigeninitiative bei.

8.2.3 Familiendynamiken und psychische Belastung bei zugewanderten Familien

Die Arbeitsmigration eines Elternteils mit dem Ziel, Partner und Kinder später nachzuholen, schafft eine andere Familiendynamik als die Pioniermigration eines Sohns oder einer Tochter als Flüchtling (bspw. um sich dem Militärdienst zu entziehen). Familiäre Ziele bzw. Erwartungen bezüglich der Migration können sich je nach den individuellen kulturellen Wurzeln und ethnischen Zugehörigkeiten unterscheiden (Belhadj Kouider & Petermann, 2015). Von den 2015 in Europa aufgenommenen Asylsuchenden waren 25 % Kinder und Jugendliche (Hebebrand et al., 2016). Einerseits können in gemeinsam auswandernden Familien belastende und traumatisierende Erfahrungen besser geteilt werden (z. B. direkte und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

indirekte Kriegserlebnisse, Fluchterlebnisse, soziale Belastungen im Aufnahmeland). Andererseits bedarf es oft einer sehr wohlwollenden Haltung außenstehender Gesprächspartner, um solche Themen überhaupt zu besprechen. Folgende potentielle Belastungen sollten in die Diagnostik einbezogen werden:

1. Zum postmigratorischen Stress gehören nach Gavranidou, Niemiec, Magg und Rosner (2008) familiäre Anforderungen, zu deren Bewältigung Kinder – welche die neue Sprache oft schon besser sprechen als ihre Eltern – fortlaufend beitragen müssen: Behördengänge, Dolmetschen für Eltern und andere Familienangehörige sowie die Erledigung amtlicher Korrespondenz. Das führt zu veränderten Rollenstrukturen sowie nicht selten zu Konflikten zwischen Kindern und Eltern. Diese Belastungen sind wiederum stark mit psychischen Auffälligkeiten der Kinder verknüpft (Gavranidou et al., 2008).
2. Wenn zunächst zurückgelassene Kinder später nachgeholt werden, können diese ebenfalls traumatisierenden Fluchterfahrungen ausgesetzt sein.
3. Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund hat immer eine Familienperspektive. Daher sollten auch die Eltern zu eigenen Akkulturationsproblemen befragt werden. Eltern wie Kinder erleben Postmigrationsstressoren intensiv: Asylverfahren, einen möglichen Asylklageprozess, die Unterbringung in Wohnheimen, eingeschränkten Zugang zum Gesundheitssystem. Hinzu kommen der Verlust vertrauter sozialer Kontakte und Netzwerke, Sprachschwierigkeiten sowie das Erleben von Diskriminierung (Böttche, Heeke & Knaevelsrud, 2016a). Stress und Traumatisierungen der Eltern wirken sich ebenfalls auf die Kinder aus (Lambert & Alhassoon, 2015).

Umso wichtiger sind Elterninterviewleitfäden in der Herkunftssprache, um die Eltern in die Diagnostik zentral einzubeziehen. Das wiederum ist Grundlage für familienbezogene Therapieziele wie eine Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung sowie die Förderung eines positiven Selbstbildes und einer situationsangemessenen kulturellen Identität (Adriaanse et al., 2016). Eltern müssen außerdem Gesundheitskompetenz (Health Competency) entwickeln: Wissen über Versorgungsangebote, gesundheitsbewusstes Verhalten, Ernährungsstrategien, die den veränderten Lebensumständen angepasst sind, sowie Aufsuchen von Gesundheitsversorgern und Beratungsstellen zur Vorsorge bzw. zur Hilfe bei gesundheitlichen Problemen (Martin, Rücker, Bau & Wiegand, 2014). Ähnlich wichtig ist die Vermittlung von Bildungskompetenz, damit Eltern und Kinder sich besser in der Bildungslandschaft zurechtfinden – mit positiven Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Denn für viele zugewanderte Eltern ist der Schulerfolg ihrer Kinder ein Maßstab dafür, ob sich die Mühen der Migration gelohnt haben (Alba & Foner, 2015). Es kann zu einer besonderen Herausforderung des diagnostischen Prozesses werden, das Begabungs- bzw. Leistungspotential der Kinder zutreffend einzuschätzen, um dann einen Weg zwischen notwendiger zusätzlicher Förderung einerseits und möglicher Überforderung durch familiäre Bildungserwartungen andererseits zu finden.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

8.2.4 Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund

Nach einer Literaturübersicht von Hebebrand et al. (2016) wurde bei 86 % der in stationärer kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung befindlichen, zugewanderten Jugendlichen Stress in Zusammenhang mit dem Asylprozess festgestellt. Neben Kriseninterventionen in Kliniken bzw. Ambulanzen findet Psychotherapie für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im ärztlichen Versorgungsnetzwerk der niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater sowie durch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten statt. Psychodiagnostik bzw. -therapie wird zudem von sogenannten Trauma-Ambulanzen für Flüchtlingskinder und Familien angeboten. Dank zahlreicher Initiativen existieren Beratungsstellen mit ähnlichen Schwerpunkten inzwischen in vielen Großstädten. Häufig haben Flüchtlingskinder und -jugendliche zusätzlich zu psychischen Beschwerden auch körperliche Gesundheitsbelastungen (Hebebrand et al., 2016).

Kinderkliniken und niedergelassene Kinderärzte sind in den meisten Fällen die ersten Anlaufstellen bei gesundheitlichen Problemen von Kindern mit Fluchthintergrund. Für diese Settings sollte daher gesundheitliche Chancengleichheit angestrebt werden. Das verlangt den Abbau von Sprach- und Kommunikationsbarrieren insbesondere bei chronischen körperlichen Erkrankungen (Ipsiroğlu & Bode, 2005). Diese Krankheiten können mit vielfältigen psychischen Belastungen einhergehen, denen vorgebeugt werden sollte. Bei einer Befragung von 229 Kinder- und Jugendärzten (Langer, Schaper, Gupta, Porst & Ostermann, 2013) gaben von den Befragten 75 % sprachlich bedingte Verständigungsschwierigkeiten bei der Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund an. Das beeinträchtigte nach Ansicht der Kinderärzte sowohl das Erkennen von Sprachentwicklungsstörungen (81 %) als auch die Aufklärungsgespräche zur häuslichen Unfallprävention. Auf die zahlreichen Diagnostik- und Beratungsangebote von Jugend- und Gesundheitsämtern sowie von Beratungsstellen unterschiedlicher Träger sei hier nur hingewiesen. Das Angebotsspektrum von frühen Hilfen für Flüchtlingsfamilien entwickelt sich aktuell vielfältig weiter.

8.3 Psychische Störungsbilder

8.3.1 Posttraumatische Belastungsstörungen und Depression sowie andere Störungsbilder

Insbesondere geflüchtete Migranten sind vielfältigen Stressoren ausgesetzt. Die Probleme im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstatus können jahrelang bestehen bleiben (Thommessen, Laghi, Cerrone, Baiocco & Todd, 2013). Bei Flücht-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

lingskindern wird oft eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert, mit Angst und Depression als häufigen komorbiden Störungen (Gavranidou et al., 2008). Zu traumatisierenden Erlebnissen wie Trennung oder gar Tod von Angehörigen, sexueller Ausbeutung, sexuellem Missbrauch und Zwangsarbeit kann es bei Kindern und Jugendlichen vor allem vor und während der Flucht gekommen sein. Aus einer Literaturübersicht von Bronstein und Montgomery (2011) ergibt sich eine PTBS-assoziierte Belastung von 19 bis 45 % der untersuchten Flüchtlingskinder insgesamt. Witt et al. (2015) finden nochmals erhöhte Raten für die Untergruppe UMF von 17 bis 71 %. Fragebogenstudien kommen dabei zu höheren Belastungsraten als interviewgestützte Untersuchungen (Witt et al., 2015).

Akkulturationsstress wird häufig zu den potentiell traumatisierenden Erfahrungen gezählt. Dieser entsteht durch die Notwendigkeit, Beziehungen zu zwei verschiedenen Kulturen zu integrieren. Dabei haben manche zugewanderten Familien schon im Heimatland einer Minderheitenkultur angehört. Akkulturationsprobleme der Eltern können die Kinder zusätzlich belasten (Belhadj Kouider & Petermann, 2015). Zu den Überforderungen zugewanderter Kinder gehören neben möglichen direkten und indirekten Kriegs- und Fluchterlebnissen später das Dolmetschen für Eltern und Geschwister, eine veränderte Rollenverteilung in der Familie, innerfamiliäre Konflikte und fehlende Unterstützung durch die Eltern (Gavranidou et al., 2008). Hinzu kommen eingeschränkte Ausbildungsmöglichkeiten, insbesondere bei unzureichenden Sprachkenntnissen und mangelnder schulischer Vorbildung. Böttche, Stammel und Knaevelsrud (2016b) heben den wiederkehrenden Stress durch Diskriminierungserfahrungen hervor. Junge Zugewanderte sprechen ihre erlebten sozialen Enttäuschungen und die Wahrnehmung mangelnder Akzeptanz durch die Aufnahmegesellschaft häufig nicht eigenständig an. Einheimische Diagnostiker sollten daher gezielt nach erlebter Diskriminierung fragen.

Bei zugewanderten Personen scheint insgesamt eine erhöhte Vulnerabilität nicht nur für PTBS, sondern zusätzlich für Depressionen und Angststörungen zu bestehen (Lindert, von Ehrenstein, Priebe, Mielck & Brähler, 2009). Hingegen haben zugewanderte Kinder und Jugendliche ein erhöhtes Risiko, eine internalisierende Störung zu entwickeln (Belhadj Kouider & Petermann, 2015). Insgesamt wird der Anteil psychisch belasteter Flüchtlingskinder in Deutschland auf etwa 40 % geschätzt – vor allem durch PTBS, Depression und Ängste (Gavranidou et al., 2008). Bronstein, Montgomery und Ott (2013) stellten eine Depression bei 23 % der von ihnen in Großbritannien untersuchten UMF fest. Die Prävalenzzahlen in der Literatur variieren demnach stark. Dennoch halten Böttche et al. (2016b) Depressionen für die häufigste Trauma-Folgestörung bei Flüchtlingen.

Bei Angststörungen scheint eine Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Migration vorzuliegen: Jungen sind nach Belhadj Kouider und Petermann (2015) stärker belastet. Witt et al. (2015) fanden in der Literatur Prävalenzraten für unter-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

schiedliche Angststörungen bei 18 bis 77 % der UMF. In der Gruppe afghanischer UMF, die Bronstein et al. (2013) untersuchten, gaben 35 % ausgeprägte Angstsymptome an.

Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten fanden sich in der Literatur nach Witt et al. (2015) bei 22 bis 72 % der UMF. Dabei korrelierten emotionale und Verhaltensprobleme bei afghanischen UMF nicht nur positiv mit der Anzahl belastender Ereignisse vor der Migration, sondern auch mit der Dauer des Aufenthalts in Großbritannien (Bronstein et al., 2013). Aggressives Verhalten von UMF scheint wesentlich beeinflusst von Gewalterfahrungen in der Familie einerseits und von spezifischen Persönlichkeitszügen andererseits (Mueller-Bamouh, Ruf-Leuschner, Dohrmann, Schauer & Elbert, 2016). Zu oppositionellem und regelwidrigem Verhalten von UMF können die pädagogischen Regeln in Jugendhilfeeinrichtungen beitragen. Damit kommen gerade ältere Jugendliche schlechter zurecht, nachdem sie auf der Flucht weitgehend auf sich gestellt und selbstverantwortlich waren. Es kann dann zu psychoseähnlichen Symptomen als Reaktion kommen (Schepker et al., 2017). Eine andere Reaktion auf diese Situation sind psychosomatische Beschwerden. Gavranidou und Abdallah-Steinkopff (2007) gehen ebenfalls von einer erhöhten Vulnerabilität von Flüchtlingen für psychosomatische Erkrankungen aus. Diese seien aber noch nicht ausreichend empirisch belegt. Ein weiteres Problem bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Schweiz sind erhöhte Abtreibungsraten (Jaeger, Hossain, Kiss & Zimmerman, 2012). Hingegen wurden aber bei Mädchen mit Migrationshintergrund in einer Multicenter-Studie seltener emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend diagnostiziert (Gaber et al., 2013).

8.3.2 Kulturspezifische Krankheitskonzepte

Hebebrand et al. (2016) weisen auf einen potentiellen Selektionsbias bezogen auf das Ausmaß potentiell traumatisierender Belastungen bei Flüchtlingskindern hin. Dabei könnten das Trauma-Modell und sonstige westliche Störungskonzepte bei anderen kulturellen Patientengruppen nur eingeschränkt anwendbar sein. Daher sollten alternative Rahmenkonzepte für die Diagnostik bei Flüchtlingskindern entwickelt werden. So hängt vom ethnischen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund nicht nur die Akzeptanz von Behandlungs- und Präventionsangeboten ab (Adriaanse et al., 2016). Vielmehr bestimmen diese Einflüsse auch psychische und psychosomatische Beschwerdemuster, deren Bewertung, sowie die Bereitschaft, Symptome und Krankheitsvorstellungen mitzuteilen (Glaesmer, Brähler & von Lersner, 2012). Kulturell beeinflusste Darstellungsweisen und Sprachbilder zum Ausdruck psychischer Belastungen finden sich in vielen Sprachen. Dazu zählen „Idioms of Distress“, Organmetaphern und kulturell verdichtete Symbole zur Mitteilung von Gefühlszuständen (Abdallah-Steinkopff, 2017; Erim, Toker, Aygün,

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Özdemir, Renz & Gün, 2010). Verständnisbrücken öffnen sich hier beispielsweise durch den Einsatz des „Cultural Formulation Interviews“ aus dem Diagnostischen und Statistischen Leitfaden psychischer Störungen (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013) in der Anamneseerhebung bei Kindern und Jugendlichen (Belhadj Kouider & Petermann, 2015; Glaesmer et al., 2012). Notwendig sind nach Johnson-Agbakwu, Allen, Nizigiyimana, Ramirez und Hollifield (2014) außerdem kurze kultursensible und validierte Screeningtests für Flüchtlinge, um Depression, PTBS und Angst möglichst zeitnah nach der Ankunft feststellen zu können.

8.4 Kultursensitives Verhalten

8.4.1 Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung ist erforderlich, wenn Kinder und Eltern einen anderen kulturellen Hintergrund haben als der Behandler. Kritisch ist zu sehen, dass es keine allgemein akzeptierte Definition von Kulturkompetenz gibt. Zudem wird die Reichweite dieses Konzepts in der Fachliteratur unterschiedlich bewertet. Daher ist die Grenze zwischen allgemeinen fachlichen Standards von Diagnostik und Therapie bezogen auf den Beziehungsaufbau bzw. auf die kommunikative Einfühlung einerseits sowie auf eine spezifisch interkulturelle Kompetenz andererseits unscharf. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu den nachfolgend referierten Ergebnissen.

Der Behandler sollte besonders sensibel für die psychosoziale Situation seiner Patienten mit Migrationshintergrund sein und Interesse für ihre potentiellen Gesundheitsprobleme sowie zusätzlich für ihren kulturellen und religiösen Hintergrund bekunden. Ergänzend sollte er auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten ebenso wie auf kulturelle bzw. ethnische Zugehörigkeiten eingehen (Abdallah-Steinkopff, 2017; Belhadj Kouider & Petermann, 2015; Gavranidou & Abdallah-Steinkopff, 2007) sowie Diskriminierungserfahrungen erfragen. Hilfreich ist außerdem die Kenntnis kulturell verdichteter Symbole in Märchen und Metaphern. Ein weiterer Aspekt kultureller Kompetenz von Diagnostikern ist ihre Bereitschaft zur kulturellen Selbstreflektion, um eigene kulturelle Überzeugungen und Haltungen berücksichtigen zu können (Erim et al., 2010; Martin et al., 2014). Dies erleichtert einen respektvollen Umgang mit den kulturell mitbestimmten Wünschen der zugewanderten Eltern nach möglichst guter Gesundheit und Bildung ihrer Kinder. Die Organisationsstruktur und die Familienhierarchie sowie außerfamiliäre unterstützende Netzwerke können durch Genogramme oder Familienskulpturen auch durch Nicht-Muttersprachler als Therapeuten gemeinsam mit der Familie herausgestellt werden (Schepker & Siefen, 2008).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Das Beherrschen der jeweiligen Herkunftssprache der Familie kann zu kultureller Kompetenz beitragen. So betont Gün (2007) die Bedeutung der Einstellung muttersprachlicher Fachkräfte für die interkulturelle Öffnung sozialer Dienste und zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse in der Psychotherapie. Angesichts der Vielzahl von Sprachen der Migrationsbevölkerung ist bestenfalls eine begrenzte Zahl an muttersprachlichen Therapeuten verfügbar. Muttersprachliche Kompetenz sollte deshalb nicht als notwendige Voraussetzung für die Arbeit mit Personen mit Migrationshintergrund und ihren Familien bewertet werden (Schouler-Ocak, 2017). Der Einbezug von Kulturmittlern und Dolmetschern in Diagnostik und Therapie kann die Sprachbarriere überbrücken, die Beachtung kultureller Besonderheiten fördern sowie die adäquate Deutung kulturgebundener Ausdrücke unterstützen. Die Kulturkompetenz eines Behandlers dient insbesondere dem Ziel, die Beziehung zu Kindern bzw. Eltern mit Migrationshintergrund zu stärken. Jedoch sollten sich Behandler auch in solchen Situationen auf ihre bewährten kommunikativen Fähigkeiten und Therapietechniken verlassen. Nach Schepker und Siefen (2008) ist das Interesse für den kulturellen Lebenshintergrund eine wichtige Grundlage für die therapeutische Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund. Dabei sind allgemeine Informationen über das familiäre Herkunftsland und im Speziellen über die ethnokulturell mitgeprägten Lebensbedingungen zu berücksichtigen.

Neben der psychischen und körperlichen Gesundheit der Kinder oder Jugendlichen gilt es, das psychische bzw. sonstige gesundheitliche Befinden der Eltern zu berücksichtigen. Ergänzend wird die Familiendynamik von den aktuellen sozioökonomischen Lebensbedingungen mitbestimmt. Fragen zu diesen sensiblen Bereichen werden am besten offen formuliert, ggf. in enger Zusammenarbeit mit einem Dolmetscher. Falls der Behandler kulturelle Besonderheiten zu wenig berücksichtigt, bemühen sich Dolmetscher häufig selbstständig um eine kultursensitive Ausgestaltung der Botschaften (Abdallah-Steinkopff, 2017). Auf deren nonverbale Reaktionen zu achten, lohnt sich daher. Gemeinsames Ziel diagnostischer Gespräche muss eine von allen Beteiligten akzeptierte Beschreibung von Symptomen bzw. Verhaltensauffälligkeiten und ein gemeinsam geteiltes Störungsmodell sein (Reher & Metzner, 2016). Ebenso einvernehmlich sollten die Therapieziele formuliert werden. Eine frühzeitige Verständigung, zumindest auf erste Schritte, ist wichtig. Zwar kann ein tradiertes Respektverhalten gegenüber Autoritäten dem Behandler mehr Entscheidungsspielraum zubilligen (Abdallah-Steinkopff, 2017). Mögliche Vorbehalte gegen eine medikamentöse Behandlung oder Schwierigkeiten, weiter entfernte Therapieangebote zu erreichen, sollten jedoch unbedingt angesprochen und ausführlich diskutiert werden. Dies kann die Behandlungsmotivation steigern. Zur interkulturell kompetenten Diagnostik gehört ebenfalls das geduldige Erfragen der eigenen Migrationserfahrungen und -belastungen: von der Migrationsentscheidung über den Migrationsweg bis hin zum schließlich erreichten Aufenthaltsstatus und dem weiteren Adaptationsprozess im Ankunftsland (Erim et al., 2010).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Interkulturelle Kompetenz stützt sich demnach auf eine Reihe interaktionsrelevanter Kompetenzen wie Hintergrundwissen, die Bereitschaft eigene kulturelle Normen und Überzeugungen zu reflektieren, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen kulturspezifischen Problemen einerseits und persönlichen migrationsspezifischen Belastungen andererseits, eine kinder- und elterngerechte Informationsübermittlung über das weitere diagnostische und therapeutische Vorgehen sowie das Eingehen auf Misstrauen oder Vorbehalte bei Patienten sowie deren Angehörigen (Gavranidou & Abdallah-Steinkopff, 2007; Reher & Metzner, 2016). Offen angesprochen werden sollten aktuelle Behandlungserwartungen und Erfahrungen mit Vorbehandlern sowie subjektive Krankheitskonzepte. Dabei helfen Sensibilität für nonverbale Signale bei Kindern, Eltern und Dolmetschern sowie Offenheit für unterschiedliche Einstellungen (Abdallah-Steinkopff, 2017). Auf Vorbehalte gegenüber Psychologie und Kinder- bzw. Jugendpsychiatrie sowie auf Gefühle von Scham und Schuld – etwa bei traumatisierten Jugendlichen und Angehörigen – ist behutsam einzugehen (Stotz, Elbert, Muller & Schauer, 2015).

8.4.2 Grenzen interkultureller Kompetenz

Andererseits sollte das Risiko von Stereotypisierung oder Kulturalisierung von Problemen und Interaktionen beachtet werden. Nicht unmittelbar verständliche Reaktionen und Mitteilungen dürfen daher nicht vorschnell pathologisiert oder kulturalisiert werden (Schepker et al., 2017). Schließlich können allgemeine Kenntnisse über kulturelle Gruppen, z. B. Stereotypisierungen, die diagnostische Unvoreingenommenheit im Einzelfall beeinträchtigen. Zur präziseren Beurteilung mehrdeutiger diagnostischer Situationen im transkulturellen Setting werden mehr empirische Arbeiten benötigt, insbesondere zur Effizienz kultursensibler Diagnostik und Therapie. Darüber hinaus gibt es eine Tendenz zur Politisierung des Begriffs „Kulturkompetenz“. So wurden Programme zur parallelen Implementierung von interkultureller Kompetenz in kooperativen Gesundheits- und Versorgungsinstitutionen entwickelt (Wu & Martinez, 2006). Nach Sue, Zane, Nagayama, Gordon und Berger (2009) umfasst *allgemeine interkulturelle Kompetenz* eine Reihe persönlicher Voraussetzungen bei Therapeuten: Kultursensibilität, kulturelles Hintergrundwissen und kulturbezogene Interventionstechniken. Dagegen erwächst die *individuelle interkulturelle Kompetenz* aus konkreten Interaktionserfahrungen mit Personen mit Migrationshintergrund, persönlicher Wissensaneignung, Reisen, Sprachkenntnissen und möglichem eigenen Migrationshintergrund des Diagnostikers. Ein solcher persönlicher kultursensitiver Zugang kann allerdings nicht allen Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gleichmäßig gerecht werden. Hier haben die Authentizität der behandelnden Person und ihre Freude an der Interaktion mit Menschen anderen kulturellen Hintergrunds Vorrang vor dem Bemühen, die zahlreichen oben dargestellten Anforderungen an kultursensitive Diagnostik zu erfüllen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

8.5 Bedeutung von Sprache für das klinische Setting

8.5.1 Sprache und Inanspruchnahme

Die Inanspruchnahme von Diagnostik und Behandlung durch Kinder, Jugendliche und ihre Familien mit Migrationshintergrund wird durch Sprach- und Informationsbarrieren beeinträchtigt (Ipsiroğlu & Bode, 2005). Muttersprachliche Diagnostiker stehen nur begrenzt zur Verfügung. Notwendig ist daher bei vielen zugewanderten Familien und deren Kindern der Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern oder Dolmetschern. Die herkunfts- und sprachbezogene Zusammensetzung von Einwanderergruppen – seien es Flüchtlingsfamilien oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – ändert sich allerdings ständig (Reher & Metzner, 2016). In einigen Sprachen stehen qualifizierte Dolmetscher daher nicht immer ortsnah zur Verfügung. Selbst wenn Kinder in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, können ihre sprachlichen Kompetenzen im Deutschen begrenzt sein. Das ist ebenso zu berücksichtigen wie etwaiger Analphabetismus der Eltern (Ipsiroğlu & Bode, 2005). Nach einer Literaturzusammenfassung von Alba und Foner (2015) benötigen Kinder aus Familien, in denen nicht die im jeweiligen Aufnahmeland dominierende Sprache gleichzeitig die in ihrer Familie vorherrschende ist, oft einige Jahre des Schulbesuchs im Aufnahmeland, um die sprachliche Kompetenz einheimischer Kinder zu erreichen. Das könnte erklären, weshalb sie später höhere Bildungsabschlüsse erreichen als nach Testergebnissen zu Beginn der Schullaufbahn zu erwarten war. Wenn zugewanderte Eltern, Kinder und Jugendliche sprachlich nicht kompetent genug sind, um Fragebögen in deutscher Sprache zu bearbeiten, sollten Testverfahren in der familiären Herkunftssprache verfügbar gemacht und standardisiert werden – zunächst für die größten Gruppen Zugewanderter. Wenn derartige Testinstrumente nicht vorhanden sind, kann eine solide Diagnostik nur durch den systematischen Einsatz von Dolmetschern gewährleistet werden.

8.5.2 Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern

Diagnostik- und Behandlungsqualität können nur bei differenzierten Kommunikationsmöglichkeiten gewährleistet werden. Wenn Diagnostiker und zugewanderte Familien sich nicht in einer Herkunfts- oder Drittsprache ausreichend gut verständigen können, müssen Dolmetscher hinzugezogen werden. An Modellen der Sprachmittlung im Gesundheitswesen unterscheiden Wächter und Vanheiden (2015) zwischen Ad-hoc-Dolmetschenden, geschultem bilingualem Personal, Gemeindedolmetschern („Community Interpreting"), Medizindolmetschern, Tele-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

fon- und Videodolmetschen[3] sowie internetbasierten Übersetzungshilfen. Alle Modelle können nützlich sein in Abhängigkeit ihrer Verfügbarkeit und der konkreten diagnostischen Situation. Ein Problem dabei stellt der fehlende Titelschutz für die Begriffe „Übersetzer“ und „Kulturmittler“ dar. Sprachmittler haben teils sehr unterschiedliche Ausbildungen. Ebenso wenig einheitlich ist die Bezahlung, denn es besteht kein allgemein akzeptierter Finanzierungsanspruch. Das hat zu einem Flickenteppich von Finanzierungsmöglichkeiten und Trägervarianten geführt. Mal ist die Finanzierung spendenbasiert, mal erfolgt sie durch staatliche Institutionen. Allein schon deshalb ist die Verfügbarkeit von Sprachmittlern eingeschränkt (Wächter und Vanheiden, 2015). Bei bislang selten in Deutschland gesprochenen Sprachen müssen unter Umständen wechselnde Dolmetscher in die Diagnostik eines Kindes integriert werden. Dabei sollte aber das Dolmetschen durch Kinder und Jugendliche vermieden werden. Bilingual kompetente Mitarbeiter benötigen systematische und qualitativ ausreichende Qualifizierungsangebote. Bei Übersetzungen durch Bekannte und Verwandte oder andere Ad-hoc-Dolmetscher kann die Neutralität der Übersetzung beeinträchtigt sein (Kießl, Meißner, Romer & Möller, 2017).

Texte und Testmaterialien in der Herkunftssprache sind sinnvolle Übersetzungshilfen (Johnson-Agbakwu et al., 2014). Bei freier Übersetzung ist die Gefahr von Verzerrungen größer (Böttche et al., 2016b). Der Einsatz schriftlicher Informationsmaterialen in der Herkunftssprache kann Sprachmittler aber insbesondere bei analphabetischen Zugewanderten nicht ersetzen. Mindeststandards in der Diagnostik erfordern grundlegende Kommunikationsmöglichkeiten. Klinische Erfahrung zeigt allerdings, dass eine gute therapeutische Allianz notfalls auch ohne Sprachmittler aufgebaut werden kann, selbst bei sehr begrenzten Sprachkenntnissen der Beteiligten. Vertrauen und das Gefühl, verstanden zu werden, stellen sich aber schneller mit der Hilfe von dolmetschenden Dritten ein. Hingegen sind manche zugewanderten Eltern gerade darauf stolz, dass sie die Kooperation mit dem Behandler entweder gleich zu Beginn oder im Laufe der Behandlung aus eigener Kraft erfolgreich gestalten konnten, trotz möglicher Missverständnisse.

8.5.3 Professionelles Dolmetschen in der klinischen Diagnostik

Dolmetschen kann in der Doppelfunktion von Übersetzung und Berücksichtigung kultureller Unterschiede gesehen werden (Langer et al., 2013). Nur bilingual kompetente Diagnostiker kommen ohne solche Unterstützung aus. Ansonsten

3 Videodolmetschen bezeichnet die dezentrale und bildgestützte Übersetzungsarbeit mittels Skype oder ähnlichen Diensten. Es ermöglicht einen umfassenderen Austausch von Eindrücken und Informationen als das Telefondolmetschen. Videodolmetschen ist insbesondere bei selten gesprochenen Sprachen, mangelnder direkter Erreichbarkeit von Dolmetschern sowie in Notfallsituationen hilfreich (Wächter & Vanheiden, 2015).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

ist Diagnostik mit Familien mit Migrationshintergrund intensive interkulturelle Kommunikation. Die klinische Praxis zeigt, dass geschulte Dolmetscher sprachlichen Mindestanforderungen in beiden Sprachen genügen sollten, sie aber ebenfalls Erfahrung in der Kooperation mit Diagnostikern erwerben müssen. So versuchen effektive Dolmetscher nicht, die Führung im Gespräch zu übernehmen und verstehen es, sich von Vereinnahmung durch zugewanderte Eltern abzugrenzen. Kulturellen Missverständnissen wirken sie diskret entgegen, ohne Kritik am Behandler zu üben. Literaturübersichten, Falldarstellungen und Projektberichte zur Arbeit mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie mit deren Eltern weisen auf den Nutzen der Unterstützung durch Sprach- und Kulturmittler hin (Langer et al., 2013). Allein mit Dolmetschern gelingt es beispielsweise, beide Elternteile verlässlich einzubeziehen (Gavranidou et al., 2008). Kulturabhängige Erklärungen für die Entwicklung psychosomatischer Beschwerden könnten ohne kulturkompetente Dolmetscher übersehen werden. Bedenken bestehen hingegen bezüglich der Einbeziehung wichtiger weiterer Informanten wie begleitender Verwandte oder Bekannte: Vorbehalte, Misstrauen, Angst vor Diskriminierung oder Beschämung seitens der hilfesuchenden Familien würden zu spät oder gar nicht erkannt. Solange Fragebögen nicht kultursensibel restandardisiert sind, können diese mit Hilfe von Dolmetschern bei analphabetischen Patienten und deren Angehörigen zumindest als Interviewleitfäden eingesetzt werden.

Die erfolgreiche Arbeit mit Dolmetschern verlangt von Diagnostikern Offenheit und Lernbereitschaft. Veröffentlichungen erfahrener Behandler können dazu eine Orientierung bieten (vgl Abdallah-Steinkopff, 2017). So kann etwa durch eine geplante Sitzordnung in der Behandlung die Kooperation zwischen Dolmetscher und Behandler gefördert werden. Im dolmetschergestützten Diagnostikprozess sollten weiterhin berücksichtigt werden: Vor- und Nachbesprechung von Dolmetscher und Therapeut; Konzentration auf kurze Aussagesätze, die unmittelbar übersetzt werden (was genauso für die reziproken Mitteilungen der betroffenen Personen gilt); Beachtung nonverbaler Signale. An die Schweigepflicht ist immer wieder zu erinnern. Nützlich sind zudem Fortbildungen zum Dolmetschereinsatz, um einen respektvollen Umgang in der Dreieckssituation des Dolmetschens zu gewährleisten (Abdallah-Steinkopff, 2017).

Tatsächlich gibt es Fallstricke in der Zusammenarbeit, selbst wenn Kontaktaufnahme und Finanzierung bewältigt wurden. Gegen den Einsatz eines bestimmten Sprachmittlers kann sprechen, wenn dessen eigener Aufenthaltsstatus unsicher ist oder er einer Volksgruppe angehört, die ggf. mit der Volksgruppe der Patientenfamilie im Konflikt steht. Weiterhin müssen Therapeuten verhindern, dass Dolmetscher versuchen, eigene Wertvorstellungen durchzusetzen oder die Diagnostiker vom Gesprächsprozess praktisch auszuschließen. Andererseits müssen Sprachmittler vor Loyalitätskonflikten geschützt werden oder vor möglicher Retraumatisierung durch die Übersetzung von Verlust- und Gewalterfahrungen (Abdallah-Steinkopff, 2017). Auch wenn der Behandler die Kooperation als wich-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

tiges Ziel betont, kann es zu Enttäuschungen in der konkreten Gesprächssituation kommen. Langer et al. (2013) fanden in einer Befragung von Kinderärzten, dass nur 58 % mit dem Dolmetschereinsatz in verschiedener Form zufrieden waren. Als besonders problematisch wurden bewertet die geringe Verfügbarkeit professioneller Dolmetscher, der hohe Zeitaufwand, um den Dolmetschereinsatz zu organisieren, und die ungeklärte Finanzierung.

8.5.4 Sprachmittler als Mediator zwischen Behandler und Patient

Kultursensible Diagnostik ist die Basis einer adäquaten Therapie von Zugewanderten (Knischewitzki, Machleidt & Calliess, 2013). Gutes Dolmetschen ergänzt die kulturelle Kompetenz des Diagnostikers. Das wiederum ist Basis für einen offenen Austausch über kulturabhängige Krankheitskonzepte und für die Erarbeitung eines gemeinsam getragenen Krankheitskonzepts oder Störungsmodells. Sofern ein Dolmetscher selbst zugewandert ist, profitiert problemfokussierte Sprach- und Kulturmittlung von den persönlichen Erfahrungen des Dolmetschers mit Migrations- und Akkulturationsstress. Wachsender Verbreitung in Städten und Kreisen erfreut sich das Modell des Gemeindedolmetscherdienstes mit standardisierter Ausbildung von Sprach- und Kulturmittlern mit Migrationshintergrund. Ein solches wird beispielsweise vom Ethno-Medizinischen-Zentrum Hannover angeboten (Wächter & Vanheiden, 2015).

Behandler und Dolmetscher sollten sich in einem Vorgespräch auf ein systematisches Vorgehen bei der Diagnostik und Behandlung bei Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen verständigen. Angesichts der sehr unterschiedlichen Ausbildungsgänge empfiehlt es sich, über die Ausbildungstiefe des Dolmetschers zu sprechen. Der Diagnostiker kann dann besser beurteilen, wieviel Verständnis er in bestimmten Bereichen zunächst beim Sprachmittler schaffen muss. Therapeut und Mittler sorgen gemeinsam für einen Dialogcharakter bei Exploration und Therapiegesprächen. Sprachmittler dürfen unterbrechen und nachfragen. Diagnostiker sollten immer wieder unmittelbare Übersetzungen der kurz zu formulierenden Redebeiträge aller Beteiligten einfordern. Kinder und Eltern werden zusätzlich durch nonverbale Signale zur aktiven Mitgestaltung eines ausgewogenen Informationsaustauschs ermuntert.

Der Diagnostiker muss Interaktionsstörungen zwischen dem Sprachmittler und sich selbst früh erkennen und auflösen. Der Sprachmittler darf die Botschaft abwandeln, um Beschämung oder Irritation zu vermeiden, sollte dies aber spätestens im Nachgespräch nachvollziehbar machen. Sofern nicht früher angesprochen, gilt es dann unterschiedliche Wertvorstellungen von Diagnostikern und Dolmetschern, sowie ethnische, religiöse oder politische Konfliktpotenziale zwischen zugewanderter Familie und Dolmetscher transparent zu machen. Manche

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Strategien, wie die Übersetzung von Patientenäußerungen in Ich-Form, passen nicht zum Stil jedes Diagnostikers oder Übersetzers. Negativen Auswirkungen von Überengagement der Sprachmittler auf den Diagnostikprozess ist vonseiten der behandelnden Person früh entgegenzuwirken (Schepker et al., 2017). Ein solides Arbeitsbündnis zwischen Dolmetschern und Diagnostikern erfordert nach Kießl et al. (2017) eine gute Beziehung zwischen allen Beteiligten, Transparenz von Regeln und Abläufen sowie Geduld und Respekt.

8.5.5 Möglichkeiten zum Einsatz von Sprachmittlern in Deutschland

Das Bewusstsein für die Bedeutung von Sprach- und Kulturmittlung für die Qualitätssicherung von Diagnostik und Behandlung im Gesundheitswesen wächst in vielen Organisationen und politischen Institutionen (Wächter & Vanheiden, 2015). Offen bleibt jedoch, wann eine verbindliche Finanzierung von ausreichend qualifizierten Sprachmittlern als Mischfinanzierung von gesetzlicher Krankenversicherung und aus Steuermitteln durchgesetzt werden kann. Bis dahin sollte jeder Diagnostiker sich über regional verfügbare Dolmetscherangebote informieren. Zudem braucht er Informationen über die Höhe der jeweiligen Kosten, die bei neuen Übersetzungsformen wie dem Videodolmetschen relativ hoch sein können. In Kliniken und Institutionen kann inzwischen häufiger auf hauseigene Dolmetscherangebote zurückgegriffen werden. Nicht immer wird dabei auf Mindeststandards in der Ausbildung geachtet. Die Sprachmittlung durch Eltern oder Geschwister wird häufig als Element der Beziehungsförderung zwischen behandelnder Person und der vorstelligen Familie eingesetzt. Allerdings ist das Risiko von Überforderung, Loyalitäts- und Rollenkonflikten sowie inhaltlicher Verzerrung dabei eindeutig zu hoch.

8.6 Ablauf der Diagnostik

8.6.1 Diagnostische Strategien und Prozesse

Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist ein zielgerichteter Prozess, an dem schon unmittelbar mehrere Personen teilnehmen: Behandler, Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Verwandte, Sprach- und Kulturmittler, Mitarbeiter von Wohngruppen oder von Erstaufnahmeeinrichtungen. Mittelbar können weitere Beteiligte Einfluss auf den Diagnostikverlauf haben: Lehrer, überweisende Ärzte, Rechtsanwälte, Mitarbeiter von Frühfördereinrichtungen, Spezialambulanzen, Gesundheitsämtern, Sozialämtern und Ausländerbehörden. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend. Sie zeigt aber, dass die einlei-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

tende Frage nach dem Vorstellungsgrund nur der Beginn einer schrittweisen gemeinsamen Zielabklärung sein kann. Jedes, insbesondere das erste diagnostische Gespräch, hat Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen behandelnder Person und Patient sowie den Angehörigen. Bereits nach dem ersten Kontakt müssen weitere diagnostische Schritte geplant werden. Oft werden erste Terminbestätigungen und Bescheinigungen für die Schule und andere Behörden von Eltern und Begleitern gewünscht. Das impliziert erste Festlegungen, die eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zuverlässig getroffen werden können. Neben dem konkreten Vorstellungsanlass sind allgemeine Ziele von Diagnostik und Therapie bei Kindern mit Migrationshintergrund nach Adriaanse et al. (2016) die Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung unter Berücksichtigung sozialer Benachteiligungen sowie die Förderung eines positiven Selbstbildes und der kulturellen Identität.

Diagnostik sollte die Basis für eine mögliche spätere multimodale Behandlung bieten. Diese umfasst Psychotherapie, Unterstützung durch Sozialarbeiter, allgemeine medizinische Versorgung und ggf. auch aufenthaltsrechtliche Beratung (Böttche et al., 2016b). Die personale Diagnostik ist der Angelpunkt. Der Behandler kann Testverfahren einsetzen. Er muss sich aber vor allem auf seine allgemeine Erfahrung mit der Diagnostik von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien (mit oder ohne Migrationshintergrund) stützen. Allerdings sind manche Krankheitskonzepte nicht auf Patienten aus anderen Kulturen übertragbar (Bronstein et al., 2013). Darüber hinaus ist behandelnden Personen zu empfehlen, ein auf ihre persönliche Arbeitsweise zugeschnittenes Anamneseschema für Personen mit Migrationshintergrund auszuarbeiten. Dabei ist die Orientierung am Cultural-Formulation-Interview des DSM-5 hilfreich (American Psychiatric Association, 2013). Ohnehin können Eltern-Interviews zwar in verschiedene Herkunftssprachen übersetzt worden sein, diese Versionen sind jedoch oft nicht validiert (Adriaanse et al., 2016). Manche Beobachtungen sind bei der Anwendung von Testverfahren bei Minderjährigen mit Migrationshintergrund bislang schwer einzuordnen. Es zeigt sich etwa, dass einige Kinder aus ethnischen Minderheitsgruppen im Aufenthaltsland und Flüchtlingskinder in den sogenannten kulturfairen Verfahren niedrigere Werte erreichen als nach dem Eindruck des Untersuchers zu erwarten wäre (Adriaanse et al., 2016). Diese Diskrepanzen unterstreichen die Bedeutung von klinischer Erfahrung des Untersuchers und der Einbeziehung unterschiedlicher Informationen. Umso wichtiger wird dann der Eindruck von Lehrern des aktuellen Kindesverhaltens in der Schule. Eltern müssen gezielt dazu befragt werden, ob Leistungsschwierigkeiten bereits im Herkunftsland bestanden haben.

Wenn möglich sollten mehrere Diagnostiktermine eingeplant werden. Gerade UMF brauchen Zeit, um Vertrauen zum Behandler zu fassen (Siebenbürger, 2017). Viele traumatisierte Kinder und Jugendliche benötigen therapeutische Unterstützung, um über ihre Erlebnisse berichten zu können. Nicht jeder Diagnostiker kann gleich gut mit Informationslücken umgehen. Die anamnestischen Angaben von

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

UMF sind häufig knapp und gleichen sich. Manchmal werden die Jugendlichen erst offener, wenn die übrige Familie nachziehen konnte. Ferner wird die Diskussion über ambivalent besetzte Themen in zugewanderten Familien oft nachhaltig vermieden. Das kann die Entscheidung für Migration oder die Probleme beim Nachholen von Familienmitgliedern betreffen, welche in einem Herkunfts- oder Transitland zunächst zurückblieben, oder Enttäuschungen über die aktuelle sozioökonomische Lage der Familie. Häufig wird über Kriegserlebnisse, Misshandlungen oder andere Traumatisierungen zunächst nur andeutungsweise gesprochen. Selbst wenn der Diagnostiker derartige Themen für sehr zentral hält, sollte er zunächst nicht insistieren.

8.6.2 Chancen und Grenzen standardisierter Diagnostik

Eine hochwertige Diagnostik ist essentiell für die Auswahl, Durchführung und Überwachung effektiver Interventionen. Neben anamnestischen Strategien sollten standardisierte Verfahren eingesetzt werden, um bestmögliche Vergleichbarkeit in der Beurteilung von Leidenszuständen zu gewährleisten. Angesichts des bereits hohen und stetig zunehmenden Bevölkerungsanteils Minderjähriger mit Migrationshintergrund besteht ein wachsender Bedarf an Verfahren, die in ethnokulturell diversen Patientengruppen aussagekräftige Befunde erzielen. Geeignete standardisierte Verfahren können dabei in ökonomischer Weise eine Sprach- und Kulturbarriere überwinden, den Gegenstandsbereich der Behandlung eingrenzen und Themenbereiche mit besonderem Handlungsbedarf priorisieren. Viele angewandte Verfahren wurden ohne den systematischen Einbezug von Migrantengruppen entwickelt. Daher sollte bei der Auswahl geeigneter standardisierter Verfahren die Passung zum Patienten mit Migrationshintergrund beurteilt werden. Dazu können Informationen aus dem Testmanual (z. B. gesonderte Normierungen, Verfügbarkeit weiter Sprachadaptionen), ergänzende Forschungsarbeiten zum fraglichen Verfahren (z. B. Validierungsstudien und Messinvarianzanalysen) oder die kritische Durchsicht des Verfahrens per Augenschein genutzt werden. Bei standardisierten diagnostischen Verfahren ist zu beachten, dass sich sowohl zwischen verschiedenen Sprachadaptionen desselben Verfahrens als auch bei der Anwendung derselben Variante in verschiedenen Populationen Reliabilitäten und Validitäten unterscheiden können.

Insbesondere bei der Anwendung von Verfahren in Migrantengruppen gilt es zu überlegen, ob das erhobene Syndrom im Vergleich zur autochthonen Gruppe mit denselben Symptomen assoziiert ist. Dabei sollte beachtet werden, dass für Heranwachsende mit Migrationshintergrund ergänzende, einzigartige Entwicklungsaufgaben bestehen, die Ursache und Projektionsfläche von Leid darstellen können (Motti-Stefanidi, Berry, Chryssochoou, Sam & Phinney, 2012). Dazu zählt beispielsweise die Entwicklung einer bikulturellen Identität (Benet-Martinez & Haritatos,

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

2005). Neuere Entwicklungen in der standardisierten Testdiagnostik setzen auf die Beteiligung von Migrantengruppen bei Adaption und Neunormierung etablierter Verfahren. Unter Beteiligung von türkeistämmigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird derzeit eine deutschsprachige Adaption der „Beck Youth Inventories“ (Beck, Beck & Jolly, 2005) und dessen Normierung durch die Autoren dieses Buchbeitrages vorbereitet. Weiterhin formierten sich bereits internationale Arbeitsgruppen zur kulturintegrativen Erarbeitung standardisierter Testverfahren (KIDSCREEN, Ravens-Sieberer & The European KIDSCREEN Group, 2006). In einem anderen Ansatz werden gering sprachbasierte Verfahren erarbeitet, bei denen beispielsweise Piktogramme zu symptombezogenen Situationen beurteilt werden sollen (Bilder-Angst-Test) (Bös & Mechling, 1985). Es soll nicht pauschal von der Anwendung standardisierter Verfahren bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund abgeraten werden. Bewusstheit über mögliche Probleme bei der Anwendung, die informierte Auswahl geeigneter Instrumente und die kritische Beurteilung der Befunde können den Nutzen standardisierter Verfahren in der Diagnostik erhöhen und Gefahren unpräziser Schlussfolgerungen vorbeugen.

8.6.3 Sammlung von Verfahren zur standardisierten klinisch-psychologischen Diagnostik

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels ist eine Sammlung von Verfahren zur standardisierten klinisch-psychologischen Diagnostik dargestellt, die für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund geeignet sind. Die Zusammenstellung ist hinsichtlich des diagnostischen Anliegens untergliedert in Breitbandverfahren, störungsspezifische Verfahren und ergänzende Verfahren. Breitbandverfahren bestehen aus mehreren Einzelskalen. Sie decken typischerweise ein Spektrum unterschiedlicher Arten von mentalem Leiden ab und geben Anhaltspunkte für potentielle Belastungsfelder. Psychometrische Gütekriterien (u. a. Reliabilität, Validität, Sensitivität und Spezifität) sind angesichts ihrer breiteren Ausrichtung häufig schlechter. Breitbandverfahren werden daher zu einem frühen Zeitpunkt des diagnostischen Prozesses eingesetzt. Sie unterstützen in ökonomischer Weise die symptomatische Exploration insbesondere bei sprachlichen Barrieren. Die dargestellte Auswahl störungsspezifischer Verfahren orientiert sich an den internationalen Klassifikationssystemen für psychische Störungen. Sie sind nur sinnvoll einsetzbar zur Abklärung (Ausschluss oder Absicherung) von Verdachtsdiagnosen. Eingesetzt in ihrem begrenzten Gültigkeitsbereich weisen störungsspezifische Verfahren zumeist eine hohe psychometrische Güte auf. Störungsspezifische Verfahren werden typischerweise im Verlauf des diagnostischen Prozesses eingesetzt, wenn bereits begründete Vermutungen vorliegen. Weiterhin sind zwei ergänzend einsetzbare Verfahren dargestellt. Erstens ist dies ein vollstrukturiertes diagnostisches Interview. Dies kann von Diagnostikern und Dolmetschern als Orientierung entweder zur Vorbereitung der Zusammenarbeit

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

oder zur gemeinsamen Befunderhebung genutzt werden. Zweitens ist ein kürzlich veröffentlichter Fragebogen angeführt, der Hinweise zum Akkulturationsprozess von Minderjährigen mit Migrationshintergrund liefert. Besonders bei Personen, die nicht selbst eingewandert sind, ist die kulturelle Orientierung zunächst unklar und es sollte abgeklärt werden, ob dies Relevanz für den diagnostischen Prozess hat. Alle dargestellten Verfahren sind in unterschiedlichen Sprachräumen verbreitet. Es liegen jeweils auch deutsche Adaptionen vor. Alle Verfahren werden in der Forschung und in der Versorgung eingesetzt und wurden wissenschaftlich mehrfach überprüft. Vor ihrer Verwendung sollte die Lizenzierung geprüft und gegebenenfalls das Nutzungsrecht eingeholt werden.

8.7 Zwölf Grundsätze für die klinisch-psychologische Diagnostik

Als programmatische Zusammenfassung dieses Kapitels werden in Ergänzung bestehender Leitlinien (vgl. Machleidt, 2002) 12 Grundsätze zur klinisch-psychologischen Diagnostik bei Minderjährigen mit Migrationshintergrund formuliert. Die Grundsätze richten sich an Behandler im diagnostischen Prozess, an Forscher bei der Neukonstruktion, Adaption und Überprüfung von diagnostischen Verfahren sowie auch an gesundheitspolitische Akteure in der psychosozialen Versorgung von Migrantengruppen.

1. Das diagnostische Ziel sind gleich hohe Qualitätsstandards in Diagnostik und Behandlung für einheimische wie für Kinder mit Migrationshintergrund in der kinder- und jugendpsychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Versorgung.
2. Bei der Anwendung von diagnostischen Verfahren bei Minderjährigen mit Migrationshintergrund kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass die erhobenen Befunde vergleichbar valide sind zum Einsatz derselben Verfahren bei einheimischen Minderjährigen.
3. Für die Auswahl diagnostischer Verfahren bei der Untersuchung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollten kulturelle Merkmale des Patienten berücksichtigt werden, die Einfluss auf Verständnis, Erleben und Ausdruck von Psychopathologie nehmen könnten.
4. Kulturfaire standardisierte Testdiagnostik ergänzt die multiinformante personale Diagnostik bei Minderjährigen mit Migrationshintergrund.
5. Strategien zur Einbeziehung von Eltern mit Migrationshintergrund in Diagnostik und Therapie sind systematisch qualitativ weiterzuentwickeln.
6. Ein auf Kinder, Jugendliche und Eltern zugeschnittenes Interview sollte in Orientierung am „Cultural Formulation Interviews“ des DSM-5 entwickelt werden, um eine kultur- und migrationsspezifische Anamneseerhebung zu gewährleisten.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7. Für Psychodiagnostik und -therapie müssen sowohl fächerübergreifende Versorgungsmodelle im Gesundheitswesen als auch systematisch abgestimmte Konzepte zur Zusammenarbeit mit staatlichen, sozialen und anderen Institutionen entwickelt werden.
8. Verbindliche Leitlinien zum professionellen Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern sind für Behandler und andere professionelle Experten in Gesundheits- und Sozialinstitutionen sowie für die Sprachmittler selbst festzulegen. Diese Aufgabe sollte suprainstitutionell umgesetzt werden, beispielsweise durch psychologische Berufsverbände in Zusammenarbeit mit Experten für unterschiedliche Fremdsprachen.
9. Testverfahren für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie kulturfaire standardisierte Elternfragebögen müssen einer der Schwerpunkte einer zentralen Datenbank zur interkulturellen Diagnostik im deutschsprachigen Raum werden, wie sie von Glaesmer et al. (2012) gefordert wird. Einzuschließen sind zudem lizenzfreie Erhebungsinstrumente.
10. Langfristige Forschung zu kulturellen, sprachlichen und migrationsbezogenen Einflüssen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und damit auf die Psychodiagnostik erfordert Migrationsdefinitionen mit einer Drei- oder Mehrgenerationenperspektive.
11. Der Nutzen von kultursensitiver Diagnostik und Therapie ist in Evaluationsstudien empirisch zu überprüfen.
12. Der Resilienz- und Ressourcenforschung in zugewanderten Familien muss künftig stärkeres Interesse gelten.

8.8 Verfahrenssammlung geeigneter standardisierter Diagnostikverfahren

8.8.1 Breitbandverfahren

Tabelle 8.1: Kurzbeschreibung YSR

Verfahrensart:	Breitbandverfahren
Testverfahren:	Youth Self-Report 11-18R (YSR)
Autoren:	Achenbach, 1991 Deutsche Bearbeitung: Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a
Konzeption:	Selbstauskunft über Verhaltensauffälligkeiten; internale, externale und gemischte Störungen sowie psychosoziale Kompetenzen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.1: Fortsetzung

Untertests:		119 Items, einige Items werden mehren Subskalen zugeordnet: Kompetenzbezogen (35), Symptombezogen (84) Subskalen: Internale Auffälligkeiten (31), Sozialer Rückzug (7), Körperliche Beschwerden (9), Angst/Depressivität (16), Externale Auffälligkeiten (30), Dissoziales Verhalten (11), Aggressives Verhalten (19), Gemischte Auffälligkeiten (keine übergeordnete Skala), Soziale Probleme (8), Schizoid/zwanghaft (7), Aufmerksamkeitsprobleme (9), Gesamtauffälligkeit (117)				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		$\alpha = .85–.95$ Subskalenreliabilitäten $\alpha = .56$ bis .71. (für Subskalen „Sozialer Rückzug" und „Schizoid/Zwanghaft" bei beiden Geschlechtern und die Skala „Soziale Probleme" bei Jungen α nur im Bereich $< .70$) $r_{tt} = .65$ (11–14 Jahre), $r_{tt} = .83$ (15–18 Jahre) ($N = 292$)				
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
11–18 Jahre	Englisch, albanisch, arabisch, bosnisch, bulgarisch, deutsch, kroatisch, tschechisch, uvm.	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15–20 Minuten Auswertung: 15 Minuten	$N = 1.800$ Normierung in Deutschland (Döpfner, Plück, Berner, Englert, Fegert & Huss, 1998; Döpfner, Plück, Berner, Fegert, Huss & Lenz, 1997)	Identische Faktorstruktur für 23 Kulturen belegt, Verfahren wird in Forschung und Praxis transkulturell eingesetzt	Kostenpflichtig über die „Equals"-Arbeitsgruppe: http://www.equals.ch/software/testverfahren/ysr-youth-self-report

Tabelle 8.2: Kurzbeschreibung CBCL

Verfahrensart:	Breitbandverfahren
Testverfahren:	Child Behaviour Checklist (CBCL 4-18)
Autoren:	Achenbach, 1991 Deutsche Bearbeitung: Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998b
Konzeption:	Fremdurteil der Eltern zu Verhaltensauffälligkeiten; internale, externale und gemischte Störungen sowie psychosoziale Kompetenzen auf Basis von empirischen Kriterien und anhand eines bereits in der Literatur bestehenden „Itempools"

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.2: Fortsetzung

Untertests:		120 Items; einige Items werden mehreren Subskalen zugeordnet. Übergeordnete Skalen: Gesamtauffälligkeit, Internale Probleme, Externale Probleme Kompetenzbezogen (35), Symptombezogen (85) Subskalen: Ängstlich/Depressiv (14), Rückzüglich/Depressiv (9), Körperliche Beschwerden (9), Soziale Probleme (8), Denk-, (Schlaf-) und repetitive Probleme (7), Aufmerksamkeitsprobleme (11), Regelverletzendes Verhalten und Aggressives Verhalten (33)				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		α = .58 bis .98 (Subskala „Soziale Probleme“: α = .39) (klinische Stichprobe *N* = 1.653 sowie deutsche Feldstichprobe *N* = 1.622) r_{tt} = .81 nach 5 Wochen (*N* = 1.969)				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normie-rungs-stich-probe**	**Ergän-zende Informa-tionen**	**Bezug**
4–18 Jahre; Klein-kind-version 1,5–5 Jahre er-hältlich	Englisch, albanisch, arabisch bosnisch, deutsch, kroatisch, russisch, uvm.	Papier- und PC-Ver-sion	Bearbei-tung: 15–20 Mi-nuten Auswer-tung: 15 Minu-ten	*N* = 2.856 Normie-rung in Deutsch-land für Mädchen und Jungen im Alter von 4–11 Jahren/ 12–18 Jah-ren (Döpf-ner et al., 1998; Döpf-ner et al. 1997)	Internatio-nal validiert: Überein-stimmung mit Selbst-auskünften aus der YSR bei *r* = .52, in aktueller Version kön-nen DSM-orien-tierte Ska-len berech-net werden	Kosten-pflichtig über Testzentrale Hogrefe Verlag: https://www.testzentrale.de/shop/deutsche-schulalter-formen-der-child-behavior-checklist-von-thomas-m-achen-bach.html

Tabelle 8.3: Kurzbeschreibung D.I.M.A.T.

Verfahrensart:	Breitbandverfahren
Testverfahren:	Dominic Interactive Multimedia Assessment Tools (D.I.M.A.T.)
Autoren:	Valla, Bergeron & Smolla, 2000 (aktuelle Version) Deutsche Bearbeitung: Valla, 1996
Konzeption:	Selbsturteil zu Symptomen von Angststörungen, Depressionen, Aufmerksamkeits- und Verhaltensproblemen sowie Substanzmissbrauch nach DSM-IV

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.3: Fortsetzung

Untertests:		91 (Kinderversion) bzw. 85 (Version für Jugendliche) Items in Form von Bildern stellen DSM- IV relevante Situationen dar und erfragen in dualistischer Form schriftlich und per Voice Over, wie sich der Proband selbst in dieser Lage einschätzt Subskalen-Summenwerte können für internalisierende und externalisierende Störungen bestimmt werden				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Jugendversion: $\alpha = .70$ bis .83; $r_{tt} = .42$ bis .62 ($N = 535$) Kinderversion: $\alpha = .89$ ($N = 403$)				
Alter	**Test-sprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
6–11 Jahre (Version für Kinder) 12–18 Jahre (Version für Jugendliche)	Französisch, bulgarisch, deutsch, englisch, italienisch, rumänisch, türkisch	PC-Version per CD-ROM Papierversion: Dominic-R	Bearbeitung: 15 Minuten Automatisierte Auswertung durch das Computerprogramm	*N* = 297 Normierung in Kanada für Jungen und Mädchen im Alter von 6–18 Jahren (Valla et al., 2000)	Bild- und Ton-gestütztes digitales Verfahren, dadurch nur geringe Sprachkompetenz erforderlich; Avatar für das Testverfahren kann in Geschlecht & Ethnie angepasst werden	Kostenpflichtig über die Website: http://www.dominic-interactive.com/commande.jsp

Tabelle 8.4: Kurzbeschreibung KIDSCREEN-52

Verfahrensart:	Breitbandverfahren
Testverfahren:	KIDSCREEN-52 (Gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen)
Autoren:	Ravens-Sieberer & KIDSCREEN Group Europe, 2006
Konzeption:	Konstruiert durch internationale Arbeitsgruppe als transkulturelles Instrument: Selbstauskunft und Fremdauskunft zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität in 52 Items und 8 Rasch-skalierte Dimensionen unterteilt

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.4: Fortsetzung

Untertests:		1. körperliches Wohlbefinden (5), 2. psychisches Wohlbefinden (6), 3. Stimmungen und Emotionen (7), 4. Selbstwahrnehmung (5), Autonomie (5), 5. Beziehungen zu Eltern und zum Zuhause (6), 6. finanzielle Möglichkeiten (3), 7. Beziehungen zu Gleichaltrigen und soziale Unterstützung (6), 8. schulisches Umfeld (6), 9. soziale Akzeptanz (Bullying, 3)				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		α = .76 bis .89 (*N* = 22.296)				
Alter	**Testsprache**	**Test-aufbau**	**Zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
8–18 Jahre	Übersetzungen in > 20 Sprachen, darunter deutsch, englisch, französisch, kroatisch, persisch, polnisch, russisch, türkisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15–20 Minuten Automatisierte Auswertung möglich	*N* = 22.296 Normierung für Europa (Ravens-Sieberer et al., 2006)	Kurzversionen Kidscreen-10/ Kidscreen-27 verfügbar	Copyright bei der „Kidscreen Group“, Lizenz ggf. kostenpflichtig erhältlich unter https://www.kidscreen.org/

8.8.2 Störungsspezifische Verfahren

Tabelle 8.5: Kurzbeschreibung SCAS

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Angststörungen
Testverfahren:	Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)
Autoren:	Spence, 1998 Deutsche Bearbeitung: Essau, Muris & Ederer, 2002
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zu diversen Angstsymptomen, entsprechend den Klassifikationen von Angststörungen nach DSM-IV
Untertests:	44 Items decken folgende Bereiche ab: Generalisierte Angststörung (6), Panikstörung/Agoraphobie (9), soziale Phobie (6), Trennungsangst (6), Zwangsstörungen (6), Angst vor körperlichen Verletzungen (5)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.5: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:		α = .93 (*N* = 4916) Subskalenreliabilität: α = .74 (Trennungsangst), α = .74 (soziale Phobie), α = .76 (Zwangsstörungen), α = .82 (Panikstörung/Agoraphobie), α = .77 (Generalisierte Angststörung), α = .60 (Angst vor körperlichen Verletzungen) r_{tt} = .60 Gesamtretest-Reliabilität nach 6 Monaten (*N* = 344)				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
4–18 Jahre	Englisch, arabisch, deutsch, persisch, polnisch, russisch, slowenisch, tschechisch, uvm.	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15–20 Minuten Auswertung: 15 Minuten	Deutsche Normierung mit *N* = 556 Altersbereich 8–12 Jahre (Essau et al., 2002)	Messinstrument als App für iOS kostenlos verfügbar unter http://itunes.apple.com/co/app/spence-childrens-anxiety-scale/id1065315823?l=en&mt=8	Frei erhältlich unter http://www.scaswebsite.com

Tabelle 8.6: Kurzbeschreibung UCLA Post-Traumatic-Symptom-Disorder Reaction Index für DSM-IV

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Belastungsstörungen (PTBS)
Testverfahren:	UCLA Post-Traumatic-Symptom-Disorder Reaction Index für DSM-IV
Autoren:	Steinberg, Brymer, Kim, Briggs, Ippen et al., 2013 Deutsche Bearbeitung: Ruf, Schauer & Elbert, 2011
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zu traumatischen Ereignissen in der Vergangenheit und zum Auftreten von posttraumatischen Stresssymptomen innerhalb des letzten Monats
Untertests:	22 Items zur Biografie traumatischer Erlebnisse (u.a. Gewalt- und Kriegserfahrungen, sexuelle Gewalt), Erleben von traumatischem Stress während und nach dem Trauma sowie Checkliste von posttraumatischen Stresssymptomen innerhalb der letzten 30 Tage
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	α = .90 (*N* = 6.291) (Steinberg et al., 2013) r_{tt} = .84 Gesamtretest-Reliabilität nach 6 bis 28 Tagen (*N* = 27) (Steinberg et al., 2013)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.6: Fortsetzung

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungs-stich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
6–18 Jahre	Englisch, arabisch, arme-nisch, chi-nesisch, deutsch, hebräisch, russisch	Papier- und PC-Ver-sion	Bearbei-tung: 20 Minu-ten Auswer-tung: 10 Minu-ten	*N* = 413 Normie-rung für Kinder im Alter von 7–17 Jah-ren (Hof-beck, 2010)	Kurzfas-sung er-hältlich, Aktuali-sierte Ver-sion nach DSM-V auf Englisch verfügbar	Frei erhältlich unter http://www.uni-klinik-ulm.de/fi-leadmin/Klini-ken/Kinder_Jugendpsychia-trie/praxisma-nual/Praxisma-nual_Stand_Juni2011.pdf

Tabelle 8.7: Kurzbeschreibung CES-DC

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Depressive Störungen
Testverfahren:	Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC)
Autoren:	Fendrich, Weissman & Warner, 1990 Deutsche Bearbeitung: Barkmann, Erhart, Schulte-Markwort & BELLA Study Group, 2008
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zum Screening depressiver Symptomatik aus verschiedenen depressiven Störungsformen
Untertests:	20 Items zu emotionalem Befinden, Kognition und Verhalten
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	α = .56 bis .82 (*N* = 2.863) (Barkmann et al., 2008) r_{tt} = .51 bis .86 Gesamtretest-Reliabilität nach einer Woche für Jugendliche im Alter von 15 Jahren (*N* = 339) (Aguilar & Berganza, 1993); (*N* = 148) (Faulstich, Carey, Ruggiero, Enyart & Gresham, 1986)

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungsstich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
6–17 Jahre	Englisch, arabisch, armenisch, deutsch, griechisch, hebräisch, persisch, russisch	Papier- und PC-Ver-sion	Bearbei-tung: 5 Minuten Auswer-tung: 5–10 Mi-nuten	*N* = 1.657 Normierung für Kinder in Deutsch-land im Alter von 7–17 Jahren	Korrelation mit anderen Depressi-onstests sowie mit Gesamtauf-fälligkeits-summen-	Copyright liegt bei den Auto-ren https://www.sprin-germedizin.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.7: Fortsetzung

				(Bettge, Wille, Barkmann, Schulte-Markwort, Ravens-Sieberer & BELLA Study Group, 2008)	werten (Bettge et al. 2008)	de/the-german-version-of-the-centre-for-epidemiological-studies-dep/8683726

Tabelle 8.8: Kurzbeschreibung CDC

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Dissoziative Störungen
Testverfahren:	Child Dissociative Checklist (CDC)
Autoren:	Putnam, Helmers & Trickett, 1993 Deutsche Bearbeitung: Zaoui, Traub & Hensel, o. D.
Konzeption:	Fremdurteil zu dissoziativen Phänomenen bei Kindern anhand von 20 Merkmalen in einer Checkliste
Untertests:	Keine Untertests; 20 Merkmale als Auflistung, die durch die Bezugsperson für die vergangenen 12 Monate auf einer 3-Punkt-Likert-Skala bewertet werden
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	$\alpha = .95$ $r_{tt} = .69$ Gesamtretest-Reliabilität nach einem Jahr ($N = 181$) (Putnam, 1998)

Alter	**Testsprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
5–12 Jahre	Englisch, deutsch, italienisch, tschechisch, türkisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 5 Minuten Auswertung: 5–10 Minuten	$N = 181$ Normierung für Kinder im Alter von 4–14 Jahren (Putnam et al., 1993)	Weitere Validierungsstudien mit ähnlichen Ergebnissen zu den Gütekriterien liegen international vor; Übersetzte Versionen	Frei erhältlich unter www.kindertrauma-institut.de/de/Materialien/

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.8: Fortsetzung

					z.T. im Rahmen von Studien entstanden	

Tabelle 8.9: Kurzbeschreibung SCARED-D

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Emotionale Störungen					
Testverfahren:	Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-D)					
Autoren:	Birmaher, Brent, Chiappetta, Bridge, Monga & Baugher, 1999 Deutsche Bearbeitung: Plass, Barkmann, Mack, Mittenzwei, Riedesser & Schulte-Markwort, 2004					
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zur Erfassung von Angstsymptomen nach ICD-10					
Untertests:	41 Items insgesamt, darin enthalten: Panikstörung (13), Generalisierte Angst (9), Trennungsangst (8), Soziale Phobie (7), Schulangst (4)					
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Gesamtreliabilität: $\alpha = .93$ ($N = 171$) (Plass et al., 2004)					
Alter	**Testsprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
8–18 Jahre	Englisch, arabisch, chinesisch, deutsch, dänisch, französisch,italienisch, tamil	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15 Minuten Auswertung: 20 Minuten	Liegt bis dato nicht vor	Kurzversion (5) verfügbar	Frei erhältlich unter www.pediatricbipolar.pitt.edu/content.asp?id=2333

Tabelle 8.10: Kurzbeschreibung ChEger-Q

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Essstörungen
Testverfahren:	Child Eating Disorder Examination Questionnaire (ChEger-Q)
Autoren:	Fairburn & Cooper, 1993 Deutsche Bearbeitung: Hilbert, Tuschen-Caffier & Ohms, 2004

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.10: Fortsetzung

Konzeption:		Selbsturteil zur Erfassung des Essverhaltens bei Kindern				
Untertests:		28 Items insgesamt, darin enthalten in 4 Subskalen gezügeltes Essverhalten (5), Sorgen über Essen (5), Gewicht (5), Figur (8)				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		$\alpha = .68$ bis .94 $r_{tt} = .69$ nach 7,5 Monaten ($N = 532$) (Hilbert, Tuschen-Caffier, Karwautz, Niederhofer & Munsch, 2007)				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normie-rungs-stich-probe**	**Ergän-zende Informa-tionen**	**Bezug**
8–14 Jahre	Englisch, deutsch, griechisch, norwegisch, spanisch	Papier- und PC-Version	Dauer Bearbeitung: 15 Minuten Dauer Auswertung: 15 Minuten	$N = 532$ Normierung für Kinder in Deutschland im Alter von 8–13 Jahren (Hilbert, Hartmann & Czaja, 2008)	$N = 808$ Normierung im englischsprachigen Raum für Mädchen im Alter von 12–14 Jahren	Frei erhältlich unter http://www.vfp-muenster.de/publikationen/online/EDE_VfP_1.pdf

Tabelle 8.11: Kurzbeschreibung Conners 3

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Aufmerksamkeitsstörungen
Testverfahren:	Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3 (Conners 3)
Autoren:	Conners, 2004 Deutsche Bearbeitung: Lidzba, Christiansen & Drechsler, 2013
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zur Erfassung von hyperaktivem und aufmerksamkeitsgestörtem Verhalten nach Definition des DSM-IV-TR
Untertests:	DSM-IV-TR und ICD-10 Symptomskalen umfassen die Diagnosekriterien der ADHS und der Störung mit oppositionellem Trotzverhalten (DSM-5), bzw. der hyperkinetischen Störungen und der Störung des Sozialverhaltens (ICD-10); die Anzahl der jeweils zutreffenden Diagnosekriterien (kategoriale Beurteilung; Symptomzahl) sowie ein Standardwert (dimensionale Beurteilung; Skalenwert) können berechnet werden
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	$\alpha = .70$ bis .85 $r_{tt} = .71$ und $r_{tt} = .98$ ($N = 3.400$) (Conners, 2004)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.11: Fortsetzung

Alter	Testsprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungs-stichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
6–18 Jahre	Englisch, chinesisch, deutsch, spanisch Elternversion zusätzlich auf Arabisch und Französisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15–20 Minuten Auswertung: 20 Minuten	*N* = 777 Petermann (2015)	Vier verschiedene Versionen erhältlich: ADHS-Index, Langversion, Kurzversion, Global-Index	Kostenpflichtig erhältlich unter https://www.hogrefe.ch/shop/conners-skalen-zu-aufmerksamkeit-und-verhalten-3-70014.html

Tabelle 8.12: Kurzbeschreibung PANSS

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Schizophrene Störungen
Testverfahren:	Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
Autoren:	Kay, Fiszbein & Opler, 1987 Deutsche Bearbeitung: Müller, Rossbach, Davids, Wetzel & Benkert, 2000
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zur typologischen und dimensionalen Erfassung von Art und Schweregrad der schizophrenen Symptomatik bei Jugendlichen auf Basis eines strukturierten Interviews
Untertests:	Subskala Positivsymptome: Delusion, formale Denkstörung, Halluzinationen, Erregung, Größenwahn, Feindseligkeit, Misstrauen/Verfolgungswahn Subskala Negativsymptome: Affektverarmung, emotionale Isolation, mangelnde Beziehungsfähigkeit, Apathie/Rückzug, erschwertes abstraktes Denkvermögen, mangelnde Spontaneität und Gesprächsfähigkeit, stereotypes Denken Globalskala: Angst, Schuldgefühle, Depression, verlangsamte Motorik, Unkooperativität, ungewöhnliche Denkinhalte, Desorientiertheit, Aufmerksamkeitsschwäche, mangelnde Urteils- und Einsichtsfähigkeit, Störung der Willensbildung, mangelnde Impulskontrolle, Selbstbezogenheit, aktive soziale Meidung, somatische Beschwerden

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.12: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:		α = .74–.83 (*N* = 101) r_{tt} = .77–.89 über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten bei nicht remissiven hospitalisierten Patienten (*N* = 15) (Kay et al., 1987)				
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
Ab 9 Jahre	Englisch, arabisch, deutsch, italienisch, portugiesisch, türkisch, spanisch, ungarisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 30–40 Minuten Auswertung: 20 Minuten	*N* = 4.091 Normierung für den deutschsprachigen Raum anhand einer klinischen Stichprobe	Standardisiertes „Rater-Training" für die deutsche Version etabliert	Deutsche Übersetzung kann kostenpflichtig vom Verlag MHS bezogen werden (Multi-Health Systems Inc, P.O. Box 950 North Tonawanda, NY 14120-0950 USA)

Tabelle 8.13: Kurzbeschreibung PSQI

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Schlafstörungen
Testverfahren:	Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Autoren:	Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989 Deutsche Bearbeitung: Riemann & Backhaus, 1996
Konzeption:	Selbsturteil zu Schlafqualität, -latenz und -quantität in 19 Items retrospektiv für die letzten 4 Wochen Fakultatives Fremdurteil in 5 Items
Untertests:	7 Subkomponenten, deren Werte einzeln berechnet und auch zu einem Gesamtsummenwert aufaddiert werden können: Subjektive Schlafqualität (1), Schlaflatenz (2), Schlafdauer (1), Schlaffeffizienz (3), Schlafstörungen (9), Schlafmittelkonsum (1), Tagesmüdigkeit (2)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.13: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:		α = .80 (*N* = 473) r_{tt} = .57 bis .82 nach 2 Wochen (*N* = 55) (Backhaus, Niemann, Hohagen, Riemann & Junghanns, 2001)				
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
ab 8 Jahre	Übersetzung in 56 Sprachen verfügbar, darunter englisch, arabisch, deutsch, polnisch, russisch, slovakisch, tschechisch, türkisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 15 Minuten Auswertung: 15 Minuten	*N* = 1.049 Normierung für den deutschsprachigen Raum im Alter zwischen 15–50 Jahren (Zeitlhofer et al., 2000)	Deutsche Version ist anders als die englische Originalversion nur für einen Messzeitraum von 2 Wochen ausgelegt	Zu nicht kommerzieller Forschung frei erhältlich von der Universität Pittsburgh unter www.psychiatry.pitt.edu/node 78240

Tabelle 8.14: Kurzbeschreibung CSI

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Somatoforme Störungen
Testverfahren:	Children´s Somatization Inventory (CSI)
Autoren:	Garber, Walker & Zeman, 1991 Deutsche Bearbeitung: Gulewitsch, Rosenkranz, Barkmann & Schlarb, 2015
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zu somatischen Beschwerden in 35 Items retrospektiv für die letzten 2 Wochen
Untertests:	Abgefragt werden Herzrasen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, andere körperliche (chronische) Schmerzen
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	α = .80 r_{tt} = .70 nach zwei Wochen (*N* = 738) (Gulewitsch et al., 2015)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.14: Fortsetzung

Alter	Testsprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungs-stich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
7–18 Jahre	Englisch, dänisch, deutsch, nieder-ländisch, polnisch, spanisch, ungarisch, türkisch	Papierver-sion	Bearbei-tung: 20–25 Mi-nuten Auswer-tung: 15–20 Mi-nuten	*N* = 1.539 Normie-rung in Deutsch-land *N* = 540 Normie-rung in den USA	Kurzver-sion mit 24 Items verfügbar	For-schungs- und behand-lungsbe-zogener Bezug kostenfrei über Gule-witsch et al. (2015)

Tabelle 8.15: Kurzbeschreibung ECBI

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Störungen des Sozialverhal-tens
Testverfahren:	Eyberg Child Behaviour Inventory (ECBI)
Autoren:	Eyberg & Pincus, 1999 Deutsche Bearbeitung: Lösel, Beelmann & Stemmler, 2002
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zu externalisierenden Verhaltenspro-blemen im heimatlichen Kontext in 36 Items
Untertests:	Anhand verschiedener „Problemverhaltensweisen" werden zwei Summenwerte berechnet: Problemwert (Summe der als Erzie-hungsproblem empfundenen Verhaltensweisen, Wertebereich von 0 bis 36); Intensitätswert (Summe aller Häufigkeitsangaben, Wer-tebereich von 36 bis 252)
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	α = .89 bis .92 r_{tt} = .71 bis .75 nach einem Jahr (*N* = 718) (Beelmann, Lösel, Stemmler & Jaursch, 2006

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.15: Fortsetzung

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungsstich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
2–16 Jahre	Übersetzung in 21 Spra-chen erhält-lich, u.a. englisch, deutsch, türkisch, russisch, chinesisch, spanisch	Papier- und PC-Ver-sion	Bearbei-tung: 5–10 Minuten Auswer-tung: 5–10 Minuten	*N* = 32 Vergleichs-werte für den deutsch-sprachigen Raum für zwei Alters-gruppen (3 bis 4, 5 bis 6 Jahre) (Lösel et al., 2002)	Ökonomi-scher Fra-gebogen, kein Rater-Training erforder-lich	Kosten-pflichtig erhältlich unter www4. parinc. com/Pro-ductFa-mily=IC-ECBI

Tabelle 8.16: Kurzbeschreibung OCI-C

Verfahrensart:	Störungsspezifisches Verfahren für Zwangsstörungen
Testverfahren:	Kinderversion des Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-C)
Autoren:	Foa et al., 2002 Deutsche Bearbeitung: Gönner, Leonhart & Ecker, 2007
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zum Auftreten von Zwangsgedanken und -handlungen in 18 Items
Untertests:	Zwangsgedanken und -handlungen werden in 6 Subskalen erfragt: Waschen (3), Kontrollieren (3), Ordnen (3), Zwangsgedanken (3), Horten (3), Mentales Neutralisieren (3)
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Gesamtsummenwert $\alpha = .77$ Subskalen: Waschen $\alpha = .53$, Obsessing $\alpha = .66$, Hoarding $\alpha = .50$, Ordering $\alpha = .43$, Checking $\alpha = .64$, Neutralizing $\alpha = .46$ ($N = 296$) (Piqueras Rodríguez, Martínez Gonzalez, Montesinos Miquel Ángel, Rivas, Mataix-Cols & Alcázar, 2009) $r_{tt} = .78$ nach drei Wochen ($N = 816$ Jugendliche)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.16: Fortsetzung

Alter	Testsprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungs-stich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
7–18 Jahre	Englisch, chinesisch, deutsch, französisch, italienisch, portugie-sisch, spanisch	Papier- und PC-Ver-sion	Bearbei-tung: 10 Minu-ten Auswer-tung: 15 Minu-ten	*N* = 1.135 Normie-rung für den eng-lisch-sprachi-gen Raum (Foa et al., 2002)	Konver-gente Vali-dität mit Yale-Brown Ob-sessive-Compulsive Scale (*r* = .31) (Jones et al., 2013)	Bezug von den Autoren

8.8.3 Ergänzende Verfahren

Tabelle 8.17: Kurzbeschreibung Kinder-DIPS

Verfahrensart:	Strukturiertes Interview
Testverfahren:	Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV): Dt. Version Kinder-DIPS
Autoren:	Shaffer, Fisher, Lucas, Dulcan & Schwab-Stone, 2000 (aktuelle Version) Deutsche Bearbeitung: Unnewehr, Schneider & Margraf, 1995
Konzeption:	Vollstrukturiertes Interview zur Klassifikation von über 30 psychi-schen Störungsbildern, basierend auf DSM-IV & ICD-10 (Eltern- und Kindversion verfügbar)
Untertests:	358 Stammitems, 1.300 Kontingenzitems zur Exploration der Symptomatik in den letzten zwei bis vier Wochen vor dem Inter-view sowie im vergangenen Jahr
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	K = .50 bis .79 nach einer Woche (*N* = 264) (Unnewehr et al., 1995)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 8.17: Fortsetzung

Alter	Testsprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungs-stichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
6–18 Jahre	Englisch, chinesisch, dänisch, deutsch, französisch, japanisch, spanisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: ca. 60–120 Minuten Auswertung: 45 Minuten	*N* = 110 Normierung für den deutschsprachigen Raum im Zuge der Manualentwicklung (Unnewehr et al., 1995)	Kurzes Training für Interviewer nötig (DIPS-Zertifizierung); Anpassung auf DSM-5 in Vorbereitung	Copyright und Bezug bei der Columbia University DISC Development Group, dt. Version kostenpflichtig über Springer Verlag

Tabelle 8.18: Kurzbeschreibung FRAKK

Verfahrensart:	Migrationsbezogenes Verfahren
Testverfahren:	Frankfurter Akkulturationsskala (FRAKK)
Autoren:	Frankenberg & Bongard, 2013 Ursprungsversion ist die deutsche Version von Frankenberg & Bongard, 2013
Konzeption:	Selbst- und Fremdurteil zu Akkulturationsstrategien als zweidimensionales Konstrukt in 14 Items
Untertests:	Zwei Dimensionen: Orientierung an Herkunftskultur (6) gegenüber der Orientierung an Aufnahmekultur (6)
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Orientierung an der Aufnahmekultur (AK), $\alpha = .74$ Orientierung an der Herkunftskultur (HK), $\alpha = .78$ (Frankenberg & Bongard, 2013)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Alter	Testsprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungs-stichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
6–18 Jahre (6–10 Jahre Kinderversion, 11–18 Jahre Jugendversion)	deutsch, englisch Elternversion zusätzlich verfügbar auf Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, Persisch, Polnisch, Russisch, Türkisch	Papier- und PC-Version	Bearbeitung: 10–15 Minuten Auswertung: 15 Minuten	*N* = 387 Normierung für Deutschland für das Alter 6–11 (Frankenberg & Bongard, 2013)	Veröffentlichung im Hogrefe Verlag geplant	Derzeit Bezug durch die Autoren

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Literatur

Abdallah-Steinkopff, B. (2017). Zusammenarbeit mit Dolmetschern. In A. Liedl, M. Böttche, B. Abdallah-Steinkopff & C. Knaevelsrud (Hrsg.), *Psychotherapie mit Flüchtlingen – neue Herausforderungen, spezifische Bedürfnisse. Das Praxisbuch für Psychotherapeuten und Ärzte* (S. 90–107). Stuttgart: Schattauer.

Achenbach, T. M. (1991). *Manual for the Youth Self-Report and 1991 Profile.* Burlington, VT: University of Vermont.

Achenbach, T. M. (2015). Transdiagnostic heterogeneity, hierarchical dimensional models, and societal, cultural, and individual differences in the developmental understanding of psychopathology. *European Child & Adolescent Psychiatry, 24* (12), 1419–1422. http://doi.org/10.1007/s00787-015-0795-0

Adriaanse, M., Doreleijers, T., van Domburgh, L. & Veling, W. (2016). Factors associated with psychiatric symptoms and psychiatric disorders in ethnic minority youth. *European Child & Adolescent Psychiatry, 25* (10), 1067–1079. http://doi.org/10.1007/s00787-016-0829-2

Aguilar, G. & Berganza, C. E. (1993). Confiabilidad test-retest de la Escala de Depresion para Ninos y Adolescentes del Centro de Estudios Epidemiologicos (CES-DC-M), en el diagnostico de la depresion en adolescentes guatemaltecos. *Avances en Psicologia Clinica Latinoamericana, 11,* 59–63.

Alba, R. & Foner, N. (2015). *Strangers no more. Immigration and the challenges of integration in North America and Western Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press. http://doi.org/10.1515/9781400865901

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. http://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist. (1998a). *Fragebogen für Jugendliche; deutsche Bearbeitung der Youth Self-Report Form der Child Behavior Checklist (YSR). Einführung und Anleitung zur Handauswertung mit deutschen Normen*, bearbeitet von M. Döpfner, J. Plück, S. Bölte, K. Lenz, P. Melchers & K. Heim (2. Aufl.). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik (KJFD).

Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist. (1998b). *Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen; deutsche Bearbeitung der Child Behavior Checklist (CBCL/4-18). Einführung und Anleitung zur Handauswertung mit deutschen Normen*, bearbeitet von M. Döpfner, J. Plück, S. Bölte, K. Lenz, P. Melchers & K. Heim (2. Aufl.). Köln: Arbeitsgruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik (KJFD).

Backhaus, J., Niemann, T., Hohagen, F., Riemann, D. & Junghanns, K. (2001). Test-retest reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in patients with primary insomnia. *World Journal of Biological Psychiatry, 2*, 374.

Barkmann, C., Erhart, M., Schulte-Markwort, M. & BELLA Study Group. (2008). The German version of the Centre for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC): psychometric evaluation in a population-based survey of 7 to 17 years old children and adolescents – results of the BELLA study. *European Child & Adolescent Psychiatry, 17* (Suppl. 1), 116–124.

Beck, J. S., Beck, A. T. & Jolly, J. B. (2005). *Beck Youth Inventories (BYI-2)* (2nd ed.). San Antonio, TX: Pearson.

Beelmann, A., Lösel, F., Stemmler, M. & Jaursch, S. (2006). Beurteilung von sozialen Verhaltensproblemen und Erziehungsschwierigkeiten im Vorschulalter. Eine Untersuchung zur deutschen Adaptation des Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). *Diagnostica, 52*, 189–198. http://doi.org/10.1026/0012-1924.52.4.189

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Belhadj Kouider, E. & Petermann, F. (2015). Migrantenkinder. *Kindheit und Entwicklung, 24,* 199–208. http://doi.org/10.1026/0942-5403/a000176

Benet-Martínez, V. & Haritatos, J. (2005). Bicultural Identity Integration (BII): Components and Psychosocial Antecedents. *Journal of Personality, 73* (4), 1015–1050. http://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2005.00337.x

Bettge, S., Wille, N., Barkmann, C., Schulte-Markwort, M., Ravens-Sieberer, U. & BELLA Study Group. (2008). Depressive symptoms of children and adolescents in a German representative sample: results of the BELLA study. *European Child & Adolescent Psychiatry, 17* (1), 71–81.

Bierbrauer, G. (1994). Toward an understanding of legal culture: Variations in individualism and collectivism between Kurds, Lebanese, and Germans. *Law & Security Review, 28* (2), 243–264. http://doi.org/10.2307/3054146

Birmaher, B., Brent, D., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S. & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38,* 1230–1236.

Bös, K. & Mechling, H. (1985). *Bilder-Angst-Test für Bewegungssituationen (BAT). Handanweisung.* Göttingen: Hogrefe.

Böttche, M., Heeke, C. & Knaevelsrud, C. (2016a). Sequenzielle Traumatisierungen, Traumafolgestörungen und psychotherapeutische Behandlungsansätze bei kriegstraumatisierten erwachsenen Flüchtlingen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 59* (5), 621–626.

Böttche, M., Stammel, N. & Knaevelsrud, C. (2016b). Psychotherapeutische Versorgung traumatisierter geflüchteter Menschen in Deutschland. *Der Nervenarzt, 87* (11), 1136–1143.

Bronstein, I. & Montgomery, P. (2011). Psychological Distress in Refugee Children: A systematic Review. *Clinical Child Family Psychology Review, 14,* 44–56. http://doi.org/10.1007/s10567-010-0081-0

Bronstein, I., Montgomery, P. & Ott, E. (2013). Emotional and behavioural problems amongst Afghan unaccompanied asylum seeking children: results from a large-scale cross-sectional study. *European Child and Adolescent Psychiatry, 22,* 285–294. http://doi.org/10.1007/s00787-012-0344-z

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016a). *Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht 2015*. Berlin: Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zugriff am 09. 08. 2017. Verfügbar unter https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2015.html

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016b). *Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: April 2016*. Berlin: Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zugriff am 2.10. 2016. Verfügbar unter https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2016.pdf

Buysse, D.J., Reynolds, C.F., Monk, T.H., Berman, S.R. & Kupfer, D.J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry research, 28* (2), 193–213. http://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4

Calliess, I.T., Ünlü, A., Neubauer, A., Hoy, L., Machleidt, W. & Behrens, K. (2009). Hannover Interview „Migration, Akkulturation und seelische Gesundheit" (HMMH). *Klinische Diagnostik und Evaluation, 2,* 145–167.

Conners, K.C. (2004). *Manual for Conners Rating Scales. Conners 3rd Edition*. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.

Doğan, S. (2000). The historical development of counselling in Turkey. *International Journal for the Advancement of Counselling, 22*, 57–67. http://doi.org/10.1023/A:1005474126819

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Döpfner, M., Plück, J., Berner, W., Englert, E., Fegert, J. M., Huss, M. (1998). Psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern – Ergebnisse einer bundesweit repräsentativen Studie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, 27,* 9–19.

Döpfner, M., Plück, J., Berner, W., Fegert, J., Huss, M., Lenz, K. (1997). Psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse einer repräsentativen Studie: Methodik, Alters-, Geschlechts- und Beurteilereffekte. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 25,* 218–233.

Erim, Y., Toker, M., Aygün, S., Özdemir, Z., Renz, M. & Gün, A. (2010). Essener Leitlinien zur interkulturellen Psychotherapie. *PiD – Psychotherapie im Dialog, 11* (04), 299–305. http://doi.org/10.1055/s-0030-1248638

Essau, C. A., Muris, P. & Ederer, E. M. (2002). Reliability and validity of the Spence Children's Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German children. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33*, 1–18. http://doi.org/10.1016/S0005-7916(02)00005-8

Eyberg, S. & Pincus, D. (1999). *Eyberg Child Behavior Inventory and Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory – revised (ECBI/SESBI-R). Professional Manual.* Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Fairburn, C. G. & Cooper, Z. (1993). The Eating Disorder Examination (12th ed.). In C. G. Fairburn & G. T. Wilson (Eds.), *Binge Eating: Nature, Aassessment, and Treatment* (pp. 317–360). New York: Guilford.

Faulstich, M. E., Carey, M. P., Ruggiero, L., Enyart, P. & Gresham, F. (1986). Assessment of depression in childhood and adolescence: an evaluation of the Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC). *American Journal of Psychiatry, 143* (8), 1024–1027.

Fendrich, M., Weissman, M. M. & Warner, V. (1990). Screening for Depressive Disorder in Children and Adolescents: validating the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children. *American Journal of Epidemiology, 131*, 538–551. http://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a115529

Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G. & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. *Psychological Assessment, 14*, 485–496. http://doi.org/10.1037/1040-3590.14.4.485

Frankenberg, E. & Bongard, S. (2013). Development and preliminary validation of the Frankfurt Acculturation Scale for Children (FRACC-C). *International Journal of Intercultural Relations, 37* (3), 323–334. http://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.12.003

Gaber, T. J., Bouyrakhen, S., Herpertz-Dahlmann, B., Hagenah, U., Holtmann, M., Freitag, C. M. et al. (2013). Migration background and juvenile mental health: a descriptive retrospective analysis of diagnostic rates of psychiatric disorders in young people. *Global Health Action, 6* (Supplement), 1–12.

Garber, J., Walker, L. S. & Zeman, J. (1991). Somatization symptoms in a community sample of children and adolescents: further validation of the Children's Somatization Inventory. *Psychological Assessment, 3*, 588–595. http://doi.org/10.1037/1040-3590.3.4.588

Gavranidou, M. & Abdallah-Steinkopff, B. (2007). Brauchen Migrantinnen und Migranten eine andere Psychotherapie? *Psycotherapeutenjournal, 6* (4), 353–361.

Gavranidou, M., Niemiec, B., Magg, B. & Rosner, R. (2008). Traumatische Erfahrungen, aktuelle Lebensbedingungen im Exil und psychische Belastung junger Flüchtlinge. *Kindheit und Entwicklung, 17* (4), 224–231. http://doi.org/10.1026/0942-5403.17.4.224

Georgas, J., Mylonas, K., Bafiti, T., Poortinga, Y. H., Christakopoulou, S., Kagitcibasi, C. et al. (2001). Functional relationships in the nuclear and extended family: a 16-culture study. *International Journal of Psychology, 36* (5), 289–300. http://doi.org/10.1080/00207590143000045

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Glaesmer, H., Brähler, E. & von Lersner, U. (2012). Kultursensible Diagnostik in Forschung und Praxis. *Psychotherapeut, 57* (1), 22–28. http://doi.org/10.1007/s00278-011-0877-5

Gönner, S., Leonhart, R. & Ecker, W. (2007). Das Zwangsinventar OCI-R – die deutsche Version des Obsessive-Compulsive Inventory-Revised. *PPmP: Psychotherapie – Psychosomatik – Medizinische Psychologie, 57* (9–10), 395–404. https://doi.org/10.1055/s-2007-970894

Gulewitsch, M.D., Rosenkranz, T., Barkmann, C. & Schlarb, A.A. (2015). Measuring somatic complaints in primary school children: validation and revision of the German Children's Somatization Inventory (CSI) and its parental version. *Child Psychiatry and Human Development, 46* (5), 786–799.

Gün, A.K. (2007). *Interkulturelle Missverständnisse in der Psychotherapie. Gegenseitiges Verstehen zwischen einheimischen Therapeuten und türkeistämmigen Klienten*. Freiburg i.B.: Lambertus.

Hebebrand, J., Anagnostopoulos, D., Eliez, S., Linse, H., Pejovic-Milovancevic, M. & Klasen, H. (2016). A first assessment of the needs of young refugees arriving in Europe: what mental health professionals need to know. *European Child and Adolescent Psychiatry, 25* (1), 1–6.

Hilbert, A., Hartmann, A. & Czaja, J. (2008). Child Eating Disorder Examination-Questionnaire: Evaluation der deutschsprachigen Version des Essstörungsfragebogens für Kinder. *Klinische Diagnostik und Evaluation, 1* (4), 447–463.

Hilbert, A., Tuschen-Caffier, B., Karwautz, A., Niederhofer, H. & Munsch, S. (2007). Eating Disorder Examination-Questionnaire: Evaluation der deutschsprachigen Übersetzung. *Diagnostica, 53,* 144–154. http://doi.org/10.1026/0012-1924.53.3.144

Hilbert, A., Tuschen-Caffier, B. & Ohms, M. (2004). Eating Disorder Examination: Deutschsprachige Version des strukturierten Essstörungsinterviews. *Diagnostica, 50,* 98–106. http://doi.org/10.1026/0012-1924.50.2.98

Hofbeck, B. (2010). *Psychometrische Eigenschaften der deutschen Version des UCLA PTSD Reaction Index.* Unveröffentlichte Diplomarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München.

Ipsiroğlu, O.S. & Bode, H. (2005). Transkulturelle Pädiatrie. *Monatsschrift Kinderheilkunde, 153* (1), 8–15. http://doi.org/10.1007/s00112-004-1069-y

Jaeger, F.N., Hossain, M., Kiss, L. & Zimmerman, C. (2012). The health of migrant children in Switzerland. *International Journal of Public Health, 57* (4), 659–671. http://doi.org/10.1007/s00038-012-0375-8

Johnson-Agbakwu, C.E., Allen, J., Nizigiyimana, J.F., Ramirez, G. & Hollifield, M. (2014). Mental health screening among newly arrived refugees seeking routine obstetric and gynecologic care. *Psychological services, 11* (4), 470–476. http://doi.org/10.1037/a0036400

Jones, A.M., De Nadai, A.S., Arnold, E.B., McGuire, J.F., Lewin, A.B., Murphy, T.K. & Storch, E.A. (2013). Psychometric Properties of the Obsessive-Compulsive Inventory: child Version in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder. *Child Psychiatry Human Development, 44*, 137–151.

Kalter, F. & Schroedter, J.H. (2010). Transnational marriage among former labour migrants in Germany. *Zeitschrift für Familienforschung, 22* (1), 11–36.

Kay, S.R., Fiszbein, A. & Opler, A. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin, 13* (2), 261–276. http://doi.org/10.1093/schbul/13.2.261

Kießl, G., Meißner, T., Romer, G. & Möller, B. (2017). Dolmetschereinsatz in der Arbeit mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen, ihren Familien und Bezugspersonen im psychotherapeutischen Versorgungskontext. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 66* (4), 304–312.

Knischewitzki, V., Machleidt, W. & Calliess, I.T. (2013). Überblick: Transkulturelle Psychiatrie. *Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, 81* (5), 285–294. http://doi.org/10.1055/s-0033-1335148

Lambert, J.E. & Alhassoon, O.M. (2015). Trauma-focused therapy for refugees: meta-analytic findings. *Journal of counseling psychology, 62* (1), 28–37. http://doi.org/10.1037/cou0000048

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Langer, T., Schaper, K., Gupta, S., Porst, R. & Ostermann, T. (2013). Sprachbarrieren in der Betreuung von Patienten mit Migrationshintergrund – Ergebnisse einer Pilotstudie zu den Erfahrungen von Kinder- und Jugendärzten. *Klinische Pädiatrie, 225* (2), 96–103. http://doi.org/10.1055/s-0032-1331760

Leung, A.K.-Y. & Cohen, D. (2011). Within- and between-culture variation: individual differences and the cultural logics of honor, face, and dignity cultures. *Journal of Personality and Social Psychology, 100* (3), 507–526. http://doi.org/10.1037/a0022151

Lidzba, K., Christiansen, H. & Drechsler, R. (2013). *Conners 3. Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten-3*. Deutschsprachige Adaptation der Conners 3rd edition von C. Keith Conners. Bern: Huber.

Lindert, J., von Ehrenstein, O.S., Priebe, S., Mielck, A. & Brähler, E. (2009). Depression and Anxiety in Labor Migrants and Refugees – A Systematic Review and Meta-Analysis. *Social Science and Medicine, 69* (2), 246–257. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.04.032

Lösel, F., Beelmann, A. & Stemmler, M. (2002). *Skalen zur Messung sozialen Problemverhaltens bei Vor- und Grundschulkindern.* Universität Erlangen-Nürnberg: Institut für Psychologie.

Machleidt, W. (2002). Die 12 Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von MigrantInnen in Deutschland. *Der Nervenarzt, 73* (12), 1208–1212. http://doi.org/10.1007/s00115-002-1460-7

Martin, L., Rücker, P., Bau, A.M. & Wiegand, S. (2014). Transkulturelle Pädiatrie – Vielfalt und Kindergesundheit. *Monatsschrift Kinderheilkunde, 162* (8), 733–744. http://doi.org/10.1007/s00112-014-3178-6

Motti-Stefanidi, F., Berry, J., Chryssochoou, X., Sam, D.L. & Phinney, J. (2012). Positive immigrant youth adaptation in context: developmental, acculturation, and social-psychological perspectives. In A.S. Masten, K. Liebkind & D.J. Hernandez (Eds.), *Realizing the potential of immigrant youth* (pp. 117–158). Cambridge (UK): Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/CBO9781139094696.008

Mueller-Bamouh, V., Ruf-Leuschner, M., Dohrmann, K., Schauer, M. & Elbert, T. (2016). Are experiences of family and of organized violence predictors of aggression and violent behavior? A study with unaccompanied refugee minors. *European Journal of Psychotraumatology, 7*, 27856. http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.27856

Müller, M.J., Rossbach, W., Davids, E., Wetzel, H. & Benkert, O. (2000). Evaluation eines standardisierten Trainings für die „Positive and Negative Syndrome Scale“ (PANSS). *Der Nervenarzt, 71* (3), 195–204. http://doi.org/10.1007/s001150050029

Petermann, F. (2015). Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 62* (1), 73–75. https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000180

Phalet, K. & Schönpflug, U. (2001). Intergenerational Transmission of Collectivism and Achievement Values in Two Acculturation Contexts: the Case of Turkish Families in Germany and Turkish and Moroccan Families in the Netherlands. *Journal of Cross-Cultural Psychology, 32* (2), 186–201. https://doi.org/10.1177/0022022101032002006

Piqueras Rodríguez, J.A., Martínez Gonzalez, A.E., Montesinos Miquel Ángel, M.D.H., Rivas, F., Mataix-Cols, D. & Alcázar, A.I.R. (2009). Propiedades psicométricas del „Inventario obsessivo compulsivo-revisado“ [Psychometric properties of the Obsessive Compulsive Inventory-Revised in a non-clinical sample of late adolescents]. *Psícologia Conductal: Revista Internacional de Psychología Clínica y de la Salud, 17* (3), 561–572.

Plass, A., Barkmann, C., Mack, B., Mittenzwei, K., Riedesser, P. & Schulte-Markwort, M. (2004). German Translation and Validation of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) – First Results. In H. Remschmidt & M. Belfer (Eds.), *Book of Abstracts of the 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry*

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

and Allied Professions (IACAPAP), in Berlin, 22.–26. August 2004 (S. 298). Darmstadt: Steinkopff.

Probst, J.C., Laditka, S.B., Moore, C.G., Harun, N. & Powell, M.P. (2007). Race and ethnicity differences in reporting of depressive symptoms. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 34* (6), 519–529. http://doi.org/10.1007/s10488-007-0136-9

Putnam, F.W. (1998). Trauma models of the effects of childhood maltreatment. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 2* (1), 51–66. http://doi.org/10.1300/J146v02n01_04

Putnam, F.W., Helmers, K. & Trickett, P.K. (1993). Development, reliability, and validity of a child dissociation scale. *Child Abuse and Neglect, 17*, 731–741. http://doi.org/10.1016/S0145-2134(08)80004-X

Ramel, B., Täljemark, J., Lindgren, A. & Johansson, B.A. (2015). Overrepresantation of unaccompanied refugee minors in inpatient psychiatric care. *SpringerPlus, 4*, 131–137. http://doi.org/10.1186/s40064015-0902-1

Ravens-Sieberer, U. & the European KIDSCREEN Group. (2006). *The KIDSCREEN Questionnaires – Quality of life questionnaires for children and adolescents. Handbook*. Lengerich: Pabst.

Reher, C. & Metzner, F. (2016). Entscheidungshilfe zur Therapieplanung bei jugendlichen Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Traumafolgestörungen in der ambulanten Praxis. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 65,* 707–728. http://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.10.707

Riemann, B. & Backhaus, J. (1996). *Behandlung von Schlafstörungen. Ein psychologisches Gruppenprogramm*. Weinheim: Beltz.

Ruf, M., Schauer, M. & Elbert, T. (2011). UPID: UCLA PTSD Index for DSM IV (Child version, revision 1, deutsche Fassung). In C. Barkmann, M. Schulte-Markwort & E. Brähler (Hrsg.), *Klinisch-psychiatrische Ratingskalen für das Kindes- und Jugendalter* (S. 468–472). Göttingen: Hogrefe.

Sauer, M. & Brinkmann, H.U. (2016). Einführung: Integration in Deutschland. In H.U. Brinkmann & M. Sauer (Hrsg.), *Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Entwicklung und Stand der Integration* (S. 1–21). Wiesbaden: Springer VS.

Schenk, L., Bau, A.-M., Borde, T., Butler, J., Lampert, T., Neuhauser, H. et al. (2006). Mindestindikatorensatz zur Erfassung des Migrationsstatus. Empfehlungen für die epidemiologische Praxis. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 49* (9), 853–860, http://doi.org/10.1007/s00103-006-0018-4

Schepker, R., Adam, H. & Siefen, R.G. (2017). Beyond Trauma – kinder- und jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Behandlung von (unbegleiteten) minderjährigen Flüchtlingen. In I. Graef-Calliess & M. Schouler-Ocak (Hrsg.), *Migration und Transkulturalität. Neue Aufgaben in Psychiatrie und Psychotherapie* (S. 315–325). Stuttgart: Schattauer.

Schepker, R. & Siefen, R.G. (2008). Therapiefragen in Migrantenfamilien. In H. Remschmidt, F. Mattejat & A. Warnke (Hrsg.), *Therapie psychischer Störungen bei Kindern und Familien. Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 493–503). Stuttgart: Thieme.

Schouler-Ocak, M. (2017). Traumazentrierte Psychotherapie bei Migranten. In I. Graef-Calliess & M. Schouler-Ocak (Hrsg.), *Migration und Transkulturalität. Neue Aufgaben in Psychiatrie und Psychotherapie* (S. 269–280). Stuttgart: Schattauer.

Schulze, P.A., Harwood, R.L., Schoelmerich, A. & Leyendecker, B. (2002). The cultural structuring of parenting and universal developmental tasks. *Parenting: Science and Practice, 2* (2), 151–178. http://doi.org/10.1207/S15327922PAR0202_04

Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C., Dulcan, M. & Schwab-Stone, M. (2000). NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children, Version IV (NIMH DISC-IV): description, differences from

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

previous versions, and reliability of some common diagnoses. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39,* 28–38.

Shiraev, E. & Levy, D.A. (2014). *Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications.* Harlow (UK): Pearson.

Siebenbürger, B. (2017). Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF). In A. Liedl, M. Böttche, B. Abdallah-Steinkopff & C. Knaevelsrud (Hrsg.), *Psychotherapie mit Flüchtlingen* (S. 121–123). Stuttgart: Schattauer.

Spence, S.H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. *Behaviour Research and Therapy, 36* (5), 545–566. http://doi.org/10.1016/S0005-7967(98)00034-5

Steinberg, A.M., Brymer, M.J., Kim, S., Briggs, E.C., Ippen, C.G., Ostrowski, S.A. ... & Pynoos, R.S. (2013). Psychometric properties of the UCLA PTSD Reaction Index: Part I. *Journal of Traumatic Stress, 26*, 1–9. http://doi.org/10.1002/jts.21780

Stotz, S.J., Elbert, T., Muller, V. & Schauer, M. (2015). The relationship between trauma, shame, and guilt: findings from a community-based study of refugee minors in Germany. *European Journal of Psychotraumatology, 6*, No. 25863. http://doi.org/10.3402/ejpt.v6.25863

Sue, D.W. & Sue, D. (1999). *Counselling the culturally different* (3rd ed.). New York: Wiley.

Sue, S., Zane, N., Nagayama, H., Gordon, C. & Berger, L.K. (2009). The case for cultural competency in psychotherapeutic interventions. *Annual Review of Psychology, 60*, 525–548. http://doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163651

Thommessen, S., Laghi, F., Cerrone, C., Baiocco, R. & Todd, B. (2013). Internalizing and externalizing symptoms among unaccompanied refugee and Italian adolescents. *Children and Youth Services Review, 35* (1), 7–10. http://doi.org/10.1016/j.childyouth.2012.10.007

United Nations. (1989). *Convention of the rights of the child*. Zugriff am 03.07.2017. Verfügbar unter http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Unnewehr, S., Schneider, S. & Margraf, J. (1995). *Kinder-DIPS. Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes-und Jugendalter*. Berlin: Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-662-06607-2

Valla, J.P. (1996). TONI-R: Heft 1 und Heft 2. Deutschsprachige Version des DOMINIC-R (6. Auflage). *Nicht publizierter Test, Riviere-des-Prairies Hospital, Research Unit, 7070*, Perras Blvd., Montreal, Kanada.

Valla, J.P., Bergeron, L. & Smolla, N. (2000). The Dominic-R: A pictorial interview for 6- to 11-year-old children. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39* (1), 85–93. http://doi.org/10.1097/00004583-200001000-00020

Wächter, M. & Vanheiden, T. (2015). *Sprachmittlung im Gesundheitswesen. Erhebung und einheitliche Beschreibung von Modellen der Sprachmittlung im Gesundheitswesen*. Berlin: Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zugriff am 09.08.2017. Verfügbar unter https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/Sprachmittlung%20im%20Gesundheitswesen.html

Witt, A., Rassenhofer, M., Fegert, J.M. & Plener, P.L. (2015). Hilfebedarf und Hilfsangebote in der Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. *Kindheit und Entwicklung, 24* (4), 209–224. http://doi.org/10.1026/0942-5403/a000177

Wu, E. & Martinez, M. (2006). *Taking cultural competency from theory to action.* The Commonwealth Fund. Zugriff am 02.02.2017. Verfügbar unter http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2006/oct/taking-cultural-competency-from-theory-to-action

Yavuz, S. (2008). Review of Cross-cultural competence. *International Journal of Cross Cultural Management, 8* (1), 112–114.

Zaoui, E., Traub, H. & Hensel, T. (o.D.). *Checkliste für dissoziative Erfahrungen von Kindern*. Zugriff am 01.05.2017. Verfügbar unter http://www.ipkj.de/index.php?id=74

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Zeitlhofer, J., Schmeiser-Rieder, A., Tribl, G., Rosenberger, A., Bolitschek, J., Kapfhammer, G. et al. (2000). Sleep and quality of life in the Austrian Population. *Acta Neurologica Scandinavica, 102* (4), 249–257. http://doi.org/10.1034/j.1600-0404.2000.102004249.x

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

9 Kultursensible klinische Psychodiagnostik bei Erwachsenen

Yuriy Nesterko & Heide Glaesmer

9.1 Analyserahmen

Ausgehend von den Grundkonzepten und aktuellen Erkenntnissen aus dem Forschungsfeld Migration und Gesundheit, wird in diesem Buchbeitrag auf die besonderen Aspekte der klinischen Diagnostik psychischer Störungen bei erwachsenen Personen mit Migrationshintergrund eingegangen. Dabei wird zunächst allgemein auf kulturbedingte Unterschiede im Hinblick auf die verschiedenen Krankheitsbilder und Erwartungshaltungen hinsichtlich deren Behandlung Bezug genommen (Abschnitt 9.2). Es wird die aktuelle Befundlage zur psychischen Belastungen von Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland (Abschnitt 9.3) sowie von Geflüchteten in den westlichen Aufnahmeländern (Abschnitt 9.4) referiert. Die Spezifik einer fragebogenbasierten Diagnostik wird mit dem interviewgestützten Vorgehen in Beziehung gesetzt und vor dem Hintergrund der jeweiligen Vor- und Nachteile kritisch reflektiert (Abschnitt 9.5). Im Weiteren werden exemplarisch vorhandene, kultursensible Testverfahren (Abschnitt 9.6) sowie praktische Beispiele aus der psychologischen Begutachtung von Geflüchteten vorgestellt (Abschnitt 9.8). Abschließend werden in Anlehnung an den Leitfaden zur kultursensiblen Diagnostik (Cultural Formulation Interview, CFI) des *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5* (American Psychiatric Association/Falkai et al., 2015) die vier Bereiche, die im Rahmen eines kultursensiblen psychodiagnostischen Prozesses eine besondere Beachtung finden sollten, besprochen und kommentiert (Abschnitte 9.7 und 9.8). Hierzu gehören:

- die kulturelle Identität des Patienten (Wertorientierungen, Sprachkenntnisse, Selbst- und Körperbild, Weltanschauungen);
- kulturell gebundene Leidenskonzepte;
- psychosoziale Stressoren und kulturelle Besonderheiten von Vulnerabilität und Resilienz;
- kulturelle Eigenschaften der Beziehungen zwischen dem oder der Betroffenen und dem Behandler bzw. der Behandlerin.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Ziel dieses Buchbeitrages ist es, der Leserschaft einen Einblick in die kultursensible klinisch-diagnostische Arbeit zu vermitteln und Anleitungen zur kritischen Reflektion der eigenen diagnostischen Tätigkeit mit Patienten bzw. Klienten mit Migrationshintergrund zu geben.

9.2 Migration und Gesundheit

Der Zusammenhang zwischen Migration und Gesundheit wird seit einigen Jahren in der deutschsprachigen epidemiologischen Forschung zunehmend zum Thema gemacht (Rommel, Saß, Born & Ellert, 2015; Glaesmer, Wittig, Brähler, Martin, Mewes & Rief, 2009). Dabei werden unterschiedliche Annahmen über den möglichen Einfluss von Migrationserfahrungen auf den Gesundheitszustand sowie auf die Versorgungsbedürfnisse diskutiert und untersucht. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Migrationserfahrungen einen Einfluss auf den Gesundheitszustand der Migrierten haben, wenngleich Art und Richtung dieses Zusammenhanges sehr komplex gestaltet und bisher unzureichend geklärt sind (Glaesmer et al., 2009).

Lange Zeit bestimmte die nationale und internationale Migrationsforschung die Annahme, dass es sich bei Migration in erster Linie um einen positiven Selektionsprozess handelt (Healthy-Migrant-Effekt) (Rommel et al., 2015). Im Rahmen dieses Ansatzes wird davon ausgegangen, dass eher gesunde und jüngere Menschen auswandern (Razum & Rohrmann, 2002). Hinweise für einen daraus resultierenden Gesundheitsvorteil der Migrierten gegenüber der einheimischen Bevölkerung zeigten sich in erster Linie in einer geringeren Mortalität in der Migriertenpopulation. In einer detaillierten Analyse stellten Razum und Rohrmann (2002) jedoch fest, dass dieser Vorteil (auf die Migriertenpopulation in Deutschland bezogen) zum Teil durch den so genannten „Late-Entry-Bias“ erklärt werden kann: Personen, die beispielsweise aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen in ihr Herkunftsland zurückkehren, werden in der amtlichen Statistik oder entsprechenden Studien nicht erfasst. Eine weitere Erklärung für die niedrigeren Mortalitätsraten unter Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu Einheimischen in den westlichen Aufnahmeländern ist im Wandel der Sterblichkeitsstruktur während der letzten 100 Jahren in den industrialisierten Gesellschaften zu sehen (Razum & Twardella, 2004): von hoher Mortalität vorwiegend aufgrund von Infektionskrankheiten hin zu geringerer Sterblichkeit an nicht übertragbaren Krankheiten. Diese Veränderung wird durch den Grad der Industrialisierung, Urbanisierung, Wohlstand und Sozialstaatsentwicklung bestimmt (Schenk, 2007). Die Migration wird unter diesem Blickwinkel als gesundheitlicher Übergang im Sinne einer vergleichsweise schnellen Lebensqualitätssteigerung verstanden. Andererseits liefern jüngere Untersuchungen mit Fokus auf Personen mit Migrationshintergrund, die bereits länger in Deutschland leben, Hinweise darauf, dass sich mit zunehmender Aufent-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

haltsdauer die Unterschiede in den Sterblichkeitsraten zwischen Migrierten und Einheimischen nach und nach verringern (Spallek & Razum, 2008). Im Gegensatz zum Healthy-Migrant-Effekt mehren sich Forschungsbefunde über migrationsassoziierte Nachteile für die allgemeine gesundheitliche Lage, für den subjektiv eingeschätzten Gesundheitszustand sowie in der gesundheitlichen Versorgung im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (Rommel et al., 2015). So ist der Healthy-Migrant-Effekt im deutlichen Kontrast zu den inzwischen stärker verbreiteten defizitorientierten Auffassungen über die Einflussnahme einer Migrationserfahrung auf die Gesundheitslage der Migrierten zu sehen. Insgesamt bleibt die Befundlage allerdings uneinheitlich; es bedarf einer theoretischen Konzeptualisierung der verfügbaren Empirie zum komplexen Zusammenspiel von Migration und Gesundheit.

In einem umfassenden Analyse- und Erklärungsmodell (vgl. Abbildung 9.1) – das die derzeit diskutierten potentiellen Einflussvariablen im Kontext von Migrationserfahrungen auf den Gesundheitszustand der Migrierten beschreibt – postuliert Schenk (2007) sechs zentrale Dimensionen, die den Zusammenhang zwischen Migration und Gesundheit erklären können. Als erstes seien die *Bedingungen bzw. die gesundheitsbezogenen Voraussetzungen des Herkunftslandes* von Bedeutung. Diese Bedingungen – etwa die gesundheitliche Versorgung oder der Lebensstil – können zu Gesundheitsvorteilen wie auch -nachteilen im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung führen. Dabei wird betont, dass die Unterschiede nicht allein von den gesundheitlichen Voraussetzungen des Herkunftslandes, sondern auch von dem zu betrachtenden Störungsbild abhängig sind (z. B. führen Unterschiede in Präventionsmaßnahmen von Tuberkulose zu unterschiedlichen Prävalenzen). Weiterhin wird der *Migrationsakt* als mögliche einwirkende Dimension betrachtet und grundsätzlich als kritisches Lebensereignis aufgefasst. Schenk (2007) geht davon aus, dass zumindest für die erste Generation der Personen mit Migrationshintergrund der Migrationsakt als ein spezifischer Anpassungsprozess mit zahlreichen rechtlichen, kulturellen und sozialen Anforderungen zu betrachten ist. Die *soziale Lage im Aufnahmeland* ist ein dritter wichtiger Aspekt, da auch jenseits der Migrationsforschung bekannt ist, dass ein niedrigerer sozioökonomischer Status mit schlechterer Gesundheit und niedrigerer Lebenserwartung assoziiert ist. Die Autorin sieht in dem häufig in empirischen Studien dokumentierten niedrigeren sozialen Status der Migrierten im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung des Aufnahmelandes eine Charakteristik der Migrantinnen und Migranten, und damit eine wichtige vermittelnde Variable in dem komplexen Zusammenhang zwischen Migration und Gesundheit. Aus diesem Grund sollte der soziale Status in den Vergleichen zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund nach Möglichkeit kontrolliert werden. Des Weiteren bestimmen die *im Aufnahmeland geltenden gesetzlichen Regelungen* das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand der Migrierten. So führt beispielsweise ein unsicherer Aufenthaltsstatus häufiger zu psychischen Belastungen als ein sicherer. Sowohl die soziale als auch die recht-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

liche Lage in der neuen Umgebung tragen dazu bei, dass *ethnische Zugehörigkeit* als weitere Dimension einen Einfluss auf den Gesundheitszustand haben kann. Eine Diskriminierungserfahrung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit würde z. B. eher negativ einwirken, während eine enge Verbundenheit mit der eigenen ethnischen Gruppe eher unterstützend und stabilisierend wirken kann. Schließlich werden *Zugangsbarrieren zur gesundheitlichen Versorgung* als wichtige Dimension beschrieben. Auf diese wird im Weiteren ausführlicher eingegangen.

Oft wird in der deutschsprachigen Migrationsforschung über eine geringere Inanspruchnahme von Migrantinnen und Migranten an Präventions- und Vorsorgeuntersuchungen berichtet (Walter, Krauth, Kurtz, Salman & Machleidt, 2007). Eine Ursache dafür wird in spezifischen Zugangsbarrieren gesehen (Kao, 2009; Razum, Geiger, Zeeb & Ronellenfitsch, 2004). Die bestehenden Unterschiede zwischen Migrierten und Einheimischen im Zugang zur Gesundheitsversorgung lassen sich nach Razum et al. (2004) auf drei Ursachen zurückführen. Zum einem werden Kommunikationsprobleme, etwa durch mangelnde Sprachkenntnisse seitens der Migrierten oder durch Informationslücken auf Seiten des Systems als entscheidend betrachtet. Eine weitere Erklärung für eine geringe Inanspruchnahme durch Personen mit Migrationshintergrund könnte in kulturspezifischen Krankheitskonzepten zu sehen sein, die zu einem anderen Umgang mit verschiedenen Beschwerden führen (Schenk, 2007). Eine dritte Erklärung zielt auf die Bedingungen im Gesundheitssystem ab. Hier sind gesetzliche Regelungen zu nennen, z. B. Zugangs-

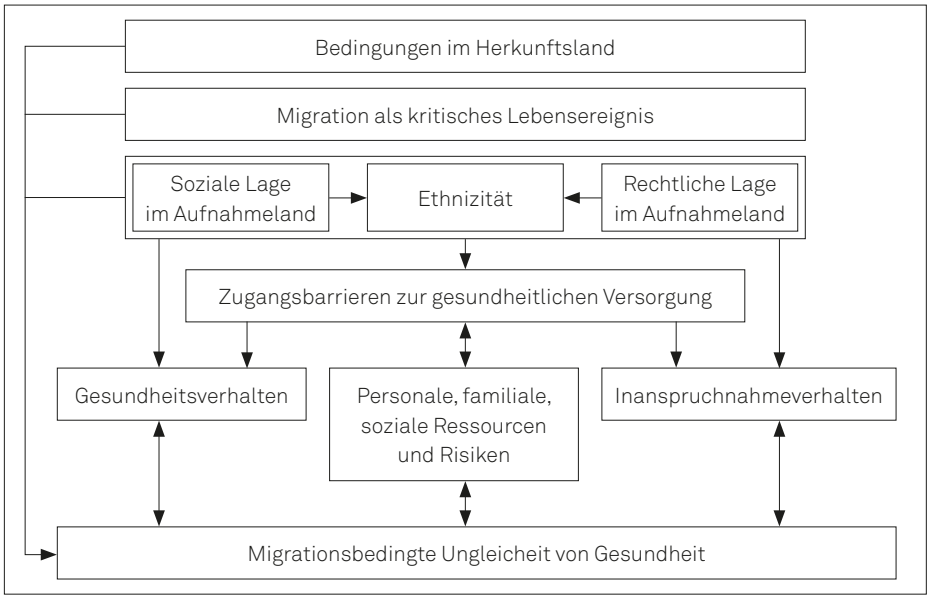

Abbildung 9.1: Erklärungsmodell zum Zusammenhang von Migration und Gesundheit, nach Schenk (2007)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

barrieren aufgrund eines illegalen Aufenthaltes, fehlende interkulturelle Kompetenz des medizinischen Personals oder der Mangel an Kultur- und Sprachmittlern im Gesundheitssystem.

In der Arbeit von Kao (2009) wird auf die Migrationsgeneration, die Aufenthaltsdauer und das Einreisealter als entscheidende Einflussgrößen für das Inanspruchnahmeverhalten verwiesen. Kao (2009) fand heraus, dass Migrierte der zweiten und dritten Generation leichteren Zugang zu gesundheitsbezogenen Leistungen haben als Personen, die selbst migriert sind. Die größten Nachteile konstatierte Kao (2009) für Personen, die erst im Erwachsenenalter migriert sind. Zwischen den verschiedenen Aspekten des Migrationshintergrundes kommt es zu wechselseitiger Beeinflussung und je nach Gesundheitsindikator zu unterschiedlichen Wirkungen. Das Gesundheits- und Inanspruchnahmeverhalten wird von Schenk (2007) als Vermittlungsebene zwischen Migrationserfahrungen und Gesundheit aufgefasst. Wichtig dabei ist, dass das Gesundheits- und Inanspruchnahmeverhalten sowohl von der Herkunftskultur als auch von der Kultur des Aufnahmelandes geprägt werden. Entscheidende Faktoren, die den Gesundheitszustand mitbestimmen, sind zudem die persönlichen, familiären und sozialen Ressourcen (z. B. Selbstwertgefühl, soziale Kompetenz, Familienklima), über die eine Person verfügt.

9.3 Psychische Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland – empirische Befunde

Für die Bundesrepublik Deutschland liegen bislang nur einige epidemiologische bevölkerungsbasierte Untersuchungen zur psychischen Gesundheit von Personen mit Migrationshintergrund vor (Rommel et al., 2015; Glaesmer et al., 2009). Als problematisch ist dabei vor allem zu betrachten, dass Personen mit Migrationshintergrund in den repräsentativen Studien meist unzureichend erfasst werden; außerdem werden in empirischen Untersuchungen häufig nur ausgewählte Migriertengruppen mit der einheimischen Bevölkerung verglichen. So sind in der Forschungsliteratur unterschiedliche und sich zum Teil widersprechende Befunde zu finden, die größtenteils auf verschiedenen methodischen Ansätzen und Stichprobengrößen beruhen. Meistens stehen spezifische Störungsbilder bestimmter ethnischer homogener Gruppen von Migrantinnen und Migranten im Fokus dieser Arbeiten, sodass nur eingeschränkt Vergleiche bzw. generelle Aussagen möglich sind (Walter et al., 2007). In der Arbeit von Rommel et al. (2015), in der die ersten Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) vorgestellt werden, wird von einer häufigeren depressiven Symptomatik der Migranten der ersten und zweiten Generation und der Migrantinnen der ersten Generation im Vergleich zu einheimischen Männern und Frauen berichtet.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Schouler-Ocak und Kollegen (2008) konstatieren für die in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten ein erhöhtes Risiko an Schizophrenie zu erkranken. In den Untersuchungen von Merbach, Wittig & Brähler (2008) und Wittig, Lindert, Merbach & Brähler (2008) wurden höhere Angst- bzw. Depressionswerte polnischer und vietnamesischer Migrantinnen und Migranten im Vergleich zur deutschen Kontrollstichprobe ohne Migrationshintergrund identifiziert. Tagay und Kollegen (2008) berichten über höhere Raten für Posttraumatische Belastungsstörung türkischsprechender Migrantinnen und Migranten (ethnische Kurdinnen und Kurden sowie ethnische Türkinnen und Türken).

Viele der verfügbaren Studien wurden auf der Grundlage klinischer Stichproben durchgeführt und erlauben damit nur eingeschränkte Rückschlüsse auf die Allgemeinbevölkerung (Koch & Brähler, 2008). Die internationale Metaanalyse von Swinnen und Selten (2007) kommt zu dem Ergebnis, dass es bisher keinen Beleg für erhöhte Raten affektiver Störungen bei Migrierten auf Bevölkerungsniveau gibt. In Deutschland sind bisher nur wenige bevölkerungsrepräsentative Untersuchungen zum Auftreten psychischer Störungen bei Personen mit und ohne Migrationshintergrund verfügbar (Rommel et al., 2015; Bermejo, Mayninger, Kriston & Härter, 2010; Glaesmer et al., 2009). Die Studie von Glaesmer et al. (2009) konnte keine Unterschiede im Auftreten psychischer Belastungen bei Migrierten und Einheimischen in Deutschland zeigen. In einer migrationssensitiven Reanalyse des Zusatzsurveys „Psychische Störungen“ des Bundesgesundheitssurveys 1998 wurden keine Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund in den Vierwochen- bzw. Zwölfmonatsprävalenzen psychischer Störungen gefunden. Die Lebenszeitprävalenz war jedoch bei den Migrantinnen und Migranten mit 50,8 % im Vergleich zu 42,5 % bei den Einheimischen erhöht. Darüber hinaus fanden sich häufiger affektive und somatoforme Störungen bei Personen mit im Vergleich zu Personen ohne Migrationshintergrund (Bermejo et al., 2010). Die Prävalenzunterschiede werden von den Autoren weniger auf die Migration als solche zurückgeführt, sondern als Folge verschiedenster mit der Migration verbundener Faktoren gesehen, zum Beispiel die sozioökonomische Lage oder die psychosoziale Belastung (Bermejo et al., 2010). Die letztgenannten, bevölkerungsrepräsentativen Studien wurden mit deutschsprachigen Erhebungsinstrumenten durchgeführt und schließen sowohl aus diesem Grund als auch aufgrund ihrer Stichprobenziehung besonders vulnerable oder belastete Gruppen von Migranten und Migrantinnen (z. B. Geflüchtete, illegal eingewanderte Migrantinnen und Migranten) aus.

Probleme der kulturellen Äquivalenz der Instrumente – im engeren Sinne die Vergleichbarkeit der Instrumente über die kulturellen Eigenheiten hinweg – müssen bei der Interpretation der Ergebnisse ebenfalls beachtet werden, worauf im Weiteren noch eingegangen wird. Unklar bleibt auf Basis des bisherigen Forschungsstands, ob es hinsichtlich psychischer Störungen tatsächlich einen erhöhten objektiven Versorgungsbedarf bei Personen mit Migrationshintergrund gibt. Über die subjektiven Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten hinsichtlich der Ver-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sorgung psychischer Belastungen müsste darüber hinaus ebenfalls kritisch reflektiert werden, weil diese (wie bereits erwähnt) von kulturell geprägten Krankheitskonzepten beeinflusst werden können.

9.4 Psychische Belastung von Geflüchteten – Stand der Forschung

Menschen mit Fluchthintergrund bzw. Asylsuchende stellen eine vergleichsweise kleine Untergruppe der in Deutschland lebenden Person mit Migrationshintergrund dar; dennoch wird im Zuge der anhaltenden Krisensituationen in verschiedenen arabischen und afrikanischen Ländern, der politischen Reaktionen der westlichen Industriestaaten darauf sowie medialen und gesellschaftlichen Debatten um den richtigen Umgang mit Geflüchteten, dieser Personenkreis des Öfteren als Sinnbild für die gesamte Gruppe der Migrantinnen und Migranten aufgefasst. Generell gilt für den Status „Flüchtling" die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 (UNHCR, 1951): Flüchtlinge sind im Sinne dieser Konvention all diejenigen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugungen in ihrem Heimatland verfolgt werden und sich aufgrund dieser Verfolgung auf der Flucht befinden. Zur besseren Spezifikation der Fluchtbewegungen hat sich daher die Unterscheidung zwischen freiwilliger und erzwungener Migration herauskristallisiert, auch wenn eine solche dichotomisierte Kategorisierung die Realität eher unzureichend abbildet (Hargasser, 2015). Generell ist davon auszugehen, dass Migration und Flucht komplexe Ursachen bzw. Motive haben. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei Flucht häufig um eine eher spontane, unfreiwillige, durch äußere Umstände wie Krieg, Verfolgung oder Vertreibung erzwungene Entscheidung, während Migration in anderen Fällen eine zwar ebenfalls komplex bedingte, aber geplante Entscheidung ist. Neben Syrien und den Ländern Ex-Jugoslawiens gehören Afghanistan und Irak zu den derzeit wichtigsten Herkunftsländern von Asylsuchenden in Deutschland (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2017).

Die Geflüchteten sind meist wiederholten Belastungen bzw. Traumatisierungen ausgesetzt, wobei diese nicht nur im Herkunftsland, sondern auch während und nach der Flucht erlebt werden. Sie stellen einen zentralen Risikofaktor für die psychische und physische Gesundheit dieses Personenkreises dar. Abbildung 9.2 gibt einen Überblick über Prä-, Peri- und Postmigrationsstressoren.

Die verfügbaren Befunde zu psychischen Belastungen bei Geflüchteten in Deutschland und international weisen ein deutlich erhöhtes Risiko für Posttraumatische Belastungsstörungen auf. Die Prävalenzraten für Posttraumatische Belastungsstörung bewegen sich meist zwischen 30 % und 40 % (Böttche, Heeke & Knaevelsrud, 2016); ähnlich hoch sind die Prävalenzraten für depressive Störungen. In einer kleinen Studie in Deutschland mit 76 Geflüchteten ergab sich eine Punktprävalenz für Post-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Belastungen vor der Flucht	Belastungen während der Flucht	Belastungen im Aufnahmeland
Naturkatastrophen	Armut und Mangel an Nahrung	Drohende Abschiebung/ unklarer Aufenthaltsstatus/ unklare Perspektiven
Armut und Mangel an Nahrung	Bewaffnete Konflikte (Ausbombung, Beschuss, Belagerung)	Leben in Illegalität
Bewaffnete Konflikte (Ausbombung, Beschuss, Belagerung)	Verfolgung und Gewalterleben bzw. Zeugenschaft	Beengte Wohnverhältnisse
Genozid oder Verfolgung aufgrund von Religion, ethnischer Zugehörigkeit usw.	Abschiebehaft	Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten
Organisierte Gewalt	Leben in Flüchtlingslagern	Verständigungsschwierigkeiten
Verfolgung und Gewalterleben bzw. Zeugenschaft	Trennung von Angehörigen	Probleme der Kommunikation mit Behörden
Inhaftierung, Folter	Mangel an Informationen über Verbleib von Angehörigen	Gefühl der Unerwünschtheit, Anfeindungen
Sexualisierte Kriegsgewalt, Zwangsverheiratung	Angst vor Abschiebung	Gefühl der Fremdheit
Verlust von Angehörigen	Leben in Illegalität	Verlust der sozialen Bezüge
Mangel an Informationen über Verbleib von Angehörigen	Obdachlosigkeit	„Anpassungsanforderungen“
	Lebensbedrohliche Situationen	

Abbildung 9.2: Flucht als Prozess – Risiko kumulativer und andauernder Belastungen

traumatische Belastungsstörung von 40 % (Gäbel, Ruf, Schauer, Odenwald & Neuner, 2006). Den Ergebnissen einer Studie (Mall & Henningsen, 2015) mit syrischen Flüchtlingskindern (N=102) zufolge erfüllen 22 % der untersuchten Kinder das Vollbild einer Posttraumatischen Belastungsstörung, weitere 16 % leiden an einer Anpassungsstörung. Auch in der Arbeit von Richter, Lehfeld und Niklewski (2015) mit insgesamt 283 Asylbewerbern wurde bei 63,6 % der Stichprobe mindestens eine psychiatrische Diagnose ermittelt; die Prävalenzrate für Posttraumatische Belastungsstörung lag bei 32,2 %. Kröger, Frantz, Friel & Heinrichs (2016) berichten im Rahmen ihrer Untersuchung mit 280 Asylsuchenden in Braunschweig von Prävalenzraten zwischen 16,1 % und 28,1 % für Posttraumatische Belastungsstörungen, je nach Herkunft der Befragten. Problematisch ist dabei, dass die derzeit vorliegenden Befunde meist auf relativ kleinen und/oder selektiven Stichproben beruhen, üblicherweise aus Querschnittsuntersuchungen gewonnen sind und zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten im Prozess der Migration bzw. Flucht ansetzen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Über die Verläufe von psychischen Belastungen in dieser Zielgruppe ist wenig bekannt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ein substanzieller Anteil der Posttraumatischen Belastungsstörungen unbehandelt einen chronischen Verlauf nimmt. Je nach Population und Methodik variiert dieser Anteil in verschiedenen Untersuchungen sehr stark, liegt aber häufig zwischen 30 % und 40 % (Welch, Caramanica, Maslow, Brackbill, Stellman & Farfel, 2016). In den letzten Jahren hat das Konzept der „verzögert auftretenden Posttraumatischen Belastungsstörung (delayed onset PTSD)" zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die bisherige Befundlage zeigt, dass etwa ein Viertel aller Fälle einen verzögerten Beginn hat, also später als sechs Monate nach dem traumatischen Ereignis das Vollbild einer Posttraumatischen Belastungsstörung vorzufinden ist. In den meisten Fällen liegt dann vorher eine sogenannte „Brückensymptomatik" vor, das heißt es finden sich Symptome, die unter der diagnostischen Schwelle liegen (Utzon-Frank et al., 2014). Während in der ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015) noch immer ein Symptombeginn der Posttraumatischen Belastungsstörung spätestens sechs Monate nach dem traumatischen Ereignis gefordert wird, hat das Konzept der verzögert auftretenden Posttraumatischen Belastungsstörung im DSM-5 (American Psychiatric Association/Falkai et al., 2015) Eingang gefunden und soll auch im ICD-11 berücksichtigt werden (Maercker, Gäbler, O'Neil, Schützwohl & Müller, 2013). Dass die Posttraumatische Belastungsstörung mit verzögertem Beginn auch bei Geflüchteten eine große Rolle spielt, zeigen erste Studien in dieser Gruppe (Lamkaddem, Stronks, Deville, Olff, Gerritsen & Essink-Bot, 2014). Der Anteil an allen Fällen der Posttraumatischen Belastungsstörungen scheint jedoch auch hier einer großen Varianz zu unterliegen. Mit Blick auf den Prozess der Migration sowie angesichts der Kenntnis um die damit häufig verbundenen kriegsassoziierten und kumulativen Traumatisierungen müssen wir davon ausgehen, dass in dieser Gruppe häufig Posttraumatische Belastungsstörungen mit verzögertem Beginn auftreten (Nesterko & Glaesmer, 2016).

Generell erleben Geflüchtete häufig lang andauernde, wiederholte und interpersonelle Traumatisierungen wie Krieg, Verfolgung oder Folter. Dazu kommen die Erfahrungen während der Flucht (die in manchen Fällen Wochen, Monate oder gar Jahre andauern), welche mit weiteren traumatischen Ereignissen einhergehen können, aber auch mit Veränderungen, die sowohl kulturelle Werte als auch den sozioökonomischen Status und die sozialen Bezüge umfassen können (Assion, Bransi & Koussemou, 2011). Betrachtet man Flucht als Prozess, so spielen die Bedingungen und Erfahrungen im Aufnahmeland für den Verlauf psychischer Belastungen eine wichtige Rolle. Die Versorgungsarbeit geht kaum über individuelle und/oder therapeutische Perspektiven hinaus, wobei sie vordergründig von den Gegebenheiten und den Regularien im Aufnahmeland geprägt bzw. stark eingeschränkt wird. Aufgrund der oft wiederholten und schwerwiegenden Traumatisierungen von Geflüchteten wird häufig die besondere Bedeutung der komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung in dieser Zielgruppe diskutiert. Die derzei-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

tige empirische Evidenz (wenngleich sehr lückenhaft) zeigt aber eher, dass die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung bei Geflüchteten nicht gehäuft auftritt (ter Heide, Mooren & Kleber, 2016).

9.5 Ableitungen für die klinische Versorgung und Diagnostik

Inzwischen haben in Deutschland etwa 21 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 2016). Auch wenn es sich dabei um eine sehr heterogene Gruppe von Personen handelt, die zum Teil selbst gewandert sind oder der zweiten und dritten Generation angehören, die aus verschiedenen Herkunftsländern stammen, unterschiedlich stark integriert sind sowie über sehr unterschiedliche sprachliche Kompetenzen im Deutschen verfügen, stellt diese Gruppe der Bevölkerung einen großen Anteil von Patienten in der ambulanten und stationären Versorgung dar. Darüber hinaus besteht aufgrund der häufigen psychischen Belastungen bei Geflüchteten, die aktuell in Deutschland leben, eine weitere für die psychosoziale Versorgung hoch relevante Aufgabe. Ausgehend von den aktuell verfügbaren Befunden zur psychischen Gesundheit von Personen mit Migrationshintergrund (einschließlich Geflüchteter) sowie entsprechend der theoretischen Ansätze, die das komplexe Zusammenspiel zwischen Migration und Gesundheit beschreiben und erklären, ergibt sich eine Reihe von Herausforderungen für die klinische Versorgung bzw. Diagnostik. Neben dem Versorgungsbedarf, der sich aus der Häufigkeit psychischer Erkrankungen ableitet, sind kulturell bedingte Unterschiede in der Art und Weise psychische Belastungen auszudrücken, in den subjektiven Krankheits- oder Gesundheitskonzepten und in den daraus resultierenden Bedürfnissen der Patienten bzw. Klienten mit Migrationshintergrund ein wichtiges Thema für eine sachgerechte Diagnostik sowie für eine darauf aufbauende Versorgung psychischer Belastungen.

Eine der Grundvoraussetzung für eine angemessene Beurteilung der psychischen Belastung von Personen mit Migrationshintergrund ist in der Kultursensitivität der Erhebungsmethode zu sehen. Klinische Diagnostik umfasst ein breites Spektrum an Methoden: vom diagnostischen Gespräch des erfahrenen Klinikers über standardisierte bzw. strukturierte klinische Interviews und Instrumente zur Fremdbeurteilung durch den Behandler bis zu Selbsteinschätzungen der Personen mit Hilfe von Fragebögen. Im Wesentlichen gelten in unterschiedlicher Gewichtung die verschiedenen Aspekte einer kultursensitiven Diagnostik für alle diese diagnostischen Methoden. Einige testtheoretische Aspekte betreffen nur die psychometrischen Instrumente. Auf diese wird im Weiteren noch genauer eingegangen werden.

Häufig weichen sprach- und kulturbedingte Vorstellungen der Ärzte bzw. Psychotherapeuten im Hinblick auf das, was als „krank“ bzw. „gesund“ zu betrachten ist,

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

von den Konzepten der Patienten bzw. Klienten ab. Gerade im Bereich der psychischen Gesundheit kann das Spektrum der Sichtweisen auf Ursache, Symptomatik und Behandlung seitens der Betroffenen eine Herausforderung für den Behandler sein. Allgemein wird davon ausgegangen, dass das Risiko einer Fehldiagnose bei Personen mit Migrationshintergrund höher ist. Insofern gilt es für den Diagnostiker, die kulturspezifischen Besonderheiten im Ausdruck psychopathologischer Symptome, wie auch die kulturell bedingten Erwartungen der Patienten hinsichtlich der Kommunikation und Behandlung zu berücksichtigen (Gäbel et al., 2006). Dabei nimmt die Sprache und im weitesten Sinne die Spezifik der kulturellen Färbung der Symptomschilderung Einfluss auf die Erfassung sowohl körperlicher als auch psychischer Symptome. In diesem Zusammenhang wird von sogenannten „Idioms of Distress" (Mall & Henningsen, 2015) gesprochen. Anhand entsprechender kulturspezifischer Ausdrucksmuster wird die Diskrepanz im Verständnis einer idiomatischen Wendung zwischen den Trägern zweier unterschiedlicher Sprach- und Kulturräume beschrieben. So kann beispielsweise eine bestimmte Aussage oder Verhaltensweise, die in einer Kultur als typisch für Depression gilt, in einer anderen Kultur nicht als eine solche aufgefasst werden (Richter et al., 2015), selbst wenn diese Aussage bzw. das geschilderte Verhalten korrekt sprachlich übersetzt wurden. In Anlehnung an die psychometrische Diagnostik ist hier vom Konstruktbias bzw. von der fehlenden funktionalen Äquivalenz des Symptoms die Rede (Koch, Staudt & Gary, 2015).

Darüber hinaus spielen die kulturell bedingten Unterschiede im Ausmaß der Bereitschaft über bestimmte Symptome zu sprechen, wie auch das Verhältnis zwischen dem erlebten und geschilderten Leidensdruck eine nicht unwesentliche Rolle. Gerade das überwiegend „westlich geprägte" Konzept der Depression ist in seiner Kultursensitivität unzureichend erforscht (Richter et al., 2015). So wird vermutet, dass aufgrund „abweichender Beschwerdemuster" bei Patienten anderer Kulturkreise seltener depressive Erkrankungen aufgedeckt werden und es in der Folge häufiger zu Fehldiagnosen kommt (Siefen, Glaesmer & Brähler, 2011). Um den Herausforderungen angemessen zu begegnen, empfiehlt sich neben dem Einsatz muttersprachlicher Untersucher – der jedoch im Rahmen eines psychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Settings auf eine Reihe von strukturellen Problemen stößt – vor allem das Hinzuziehen von sogenannten Kultur- und Sprachmittlern (Nesterko, Kaiser & Glaesmer, 2017). Der diagnostische Prozess sollte bei Menschen mit Migrationshintergrund – neben den allgemein üblichen Informationen – kultur- und migrationsspezifische Faktoren (kulturspezifische Krankheitskonzepte, Diskriminierungserfahrungen, Akkulturationsverläufe, Sprachkenntnisse etc.) berücksichtigen, da es sonst zu diagnostischen Fehleinschätzungen kommen kann. Im klinischen Kontext in Deutschland ist bislang in der Mehrheit der Fälle von einer personalen Diagnostiksituation auszugehen, in der Patienten mit Migrationshintergrund auf Diagnostiker oder Therapeuten treffen, die keinen Migrationshintergrund haben.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

9.6 Psychometrische klinische Diagnostik im interkulturellen Kontext – ausgewählte Verfahren

Fast alle kulturbezogenen Anforderungen der personalen klinischen Diagnostik lassen sich auf die psychometrische Diagnostik, die neben der klinischen Praxis vor allem in der Forschung breite Anwendung findet, mithilfe von Fragebogen und Tests übertragen. Im Idealfall werden verschiedene Versionen von Tests parallel entwickelt. Ein solches Vorgehen findet sich bei einigen weit verbreiteten Verfahren zur Erfassung von Lebensqualität, wie dem World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) (Power et al., 1998), dem EQ-5D™ (Brooks, Rabin & Charro, 2003) oder dem SF-36 Health Survey (Ware & Sherbourne, 1992). Dies sind jedoch eher Ausnahmen, die meisten diagnostischen Verfahren werden in einer Sprache entwickelt und später übersetzt bzw. zum Teil adaptiert.

Beim Einsatz psychometrischer Verfahren in kulturvergleichenden Studien, in verschiedenen Sprachversionen oder Gruppen sollte möglichst sichergestellt werden, dass man das gleiche Konstrukt erfasst und vergleicht. Aus psychometrischer Perspektive wird hier von Messinvarianz (measurement invariance) gesprochen, die verschiedene Unteraspekte beinhaltet. Die funktionale Äquivalenz zielt darauf ab, in allen Gruppen das gleiche Konstrukt zu erfassen. Dieser Aspekt wird schon relativ lange in kulturvergleichenden Studien diskutiert, wobei zunächst vor allem auf die Vergleichbarkeit von Validitätskriterien und die kritische Diskussion von geeigneten bzw. vergleichbaren Cut-off-Werten fokussiert wurde. Inzwischen werden vor allem konfirmatorische Faktorenanalysen eingesetzt, um Messinvarianz zu untersuchen (Chen, 2008). Dabei können drei Aspekte der Messinvarianz mithilfe von konfirmatorischen Faktorenanalysen analysiert werden (Chen, 2008):

1. Konfigurale Invarianz (configural invariance) meint, dass vergleichbare Faktoren in den verschiedenen Gruppen untersucht werden. Das heißt, dass die Items eines Fragebogens in den verschiedenen Gruppen oder Sprachversionen den gleichen Faktoren zuzuordnen sind, wenngleich sich die Faktorladungen unterscheiden können. Wenn keine konfigurale Invarianz besteht, misst das Instrument nicht das gleiche Konstrukt über die verschiedenen Gruppen.
2. Metrische Invarianz (metric invariance) geht einen Schritt weiter und verlangt, dass die Faktorladungen für die verschiedenen Items vergleichbar sind. Dieser Äquivalenzaspekt muss erfüllt sei, um sinnvolle Vergleiche zwischen Gruppen durchführen zu können.
3. Skalare Invarianz (scalar invariance) drückt aus, dass ein Item den gleichen Ausgangspunkt hat (intercept). Nur wenn dieser Äquivalenzaspekt erfüllt ist, sind aus psychometrischer Sicht sinnvolle Mittelwertvergleiche zwischen Gruppen möglich.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Auch wenn heute mit Hilfe konfirmatorischer Faktorenanalysen die verschiedenen Aspekte von Messinvarianz geprüft werden können, liegen solch umfängliche Untersuchungen nur sehr selten für verschiedene Sprachversionen von Instrumenten vor. Aus diesem Grund ist die empirische Evidenz bezüglich der Messinvarianz von Testverfahren oft sehr begrenzt. Aufgrund der hohen Erfassungs- und Auswertungsökonomie und gerade im Kontext möglicher Sprachbarrieren zwischen Diagnostiker und Klient wird in der Praxis dennoch auf Testverfahren in der jeweiligen Sprache der Klientin bzw. des Klienten zurückgegriffen. Im Folgenden wird detaillierter auf die am häufigsten eingesetzten Verfahren eingegangen, die die Symptomlast der gängigen psychischen Beschwerden – Depressivität (PHQ-9; HSCL-25), Ängstlichkeit (HSCL-25), Posttraumatische Belastungsstörungen (IES-R; HTQ), somatoforme Beschwerden (PHQ-15), sowie gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36) – erfassen.

PHQ-9

Das Depressionsmodul des Patient Health Questionnaire (PHQ-9) (vgl. Tabelle 9.1) orientiert sich an den DSM-IV-Kriterien der Major Depression; es ist ein gut validiertes und häufig angewandtes Verfahren zur Erfassung depressiver Beschwerden in der klinischen Versorgung. Inzwischen wird es auch in vielen anderen Settings eingesetzt (z. B. in bevölkerungsbasierten Studien oder bei stationären Patienten verschiedener Fachdisziplinen) (Löwe, Spitzer, Zipfel & Herzog, 2002; Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). Auf einer vierstufigen Likert-Skala (von „überhaupt nicht“ bis „beinahe jeden Tag“) wird dabei auf der Grundlage von neun Items die aktuelle (die letzten zwei Wochen) depressive Symptomatik erfasst. Der PHQ-9 bietet die Möglichkeiten einer dimensionalen (Bestimmung des Schweregrades) wie auch kategorialen (Vorliegen einer majoren oder minoren Depression) Auswertung, wobei in zahlreichen klinischen Studien für beide Auswertungsformen hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte ermittelt wurden.

Zum PHQ-9 sind einige psychometrische Studien verfügbar, die sich mit der kulturellen Äquivalenz des Instruments beschäftigen. In der Untersuchung von Huang und Kollegen (2006) wurden vier verschiedene ethnische Gruppen verglichen. Die einfaktorielle Struktur des PHQ-9 konnte in allen Gruppen bestätigt werden; die Reliabilitätskoeffizienten bewegten sich von .79 bis .89. Wenngleich die Antwortraten für die Items in den vier Gruppen prinzipiell vergleichbar waren, zeigten sich für eine Mehrzahl der Items Hinweise auf ein „differential item functioning“ (DIF). Das DIF kann entstehen, wenn eine der untersuchten Subgruppen ein Item anders interpretiert oder beantwortet, aber auch wenn der Zusammenhang zwischen der zu identifizierenden Störung und dem Item in den Subgruppen unterschiedlich ist. Würde etwa „Weinen“ bei gleicher Depressionsschwere in einer Gruppe deutlich häufiger auftreten, würde man von einer unter-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

schiedlichen Symptom-Störung-Relation sprechen (Hepner, Morales, Hays, Edelen & Miranda, 2008).

Tabelle 9.1: Kurzbeschreibung PHQ-9

Testverfahren:	Depressionsmodul des Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
Autoren:	K. Kroenke, R. L. Spitzer & J. B. W. Williams, 2001 Deutsch von B. Löwe, R. L. Spitzer, S. Zipfel & W. Herzog, 2002
Konzeption:	Der PHQ-9 wurde als Screening-Instrument zur Identifikation von depressiven Störungen für den routinemäßigen Einsatz in der primärärztlichen Versorgung entwickelt und orientiert sich an den DSM-IV-Kriterien der Major Depression. Heute wird der PHQ-9 sehr breit in verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Settings eingesetzt und ist auch in der Forschung sehr etabliert.
Untertests:	Mithilfe von neun Items wird die aktuelle (die letzten zwei Wochen) depressive Symptomatik erfasst.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Der PHQ-9 bietet die Möglichkeiten einer dimensionalen (Bestimmung des Schweregrades) wie auch kategorialen (majore Depression/minore Depression) Auswertung, wobei in zahlreichen Studien für beide Auswertungsformen hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte ermittelt wurden. Die Reliabilitätskoeffizienten bewegten sich von .79 bis .89.

Alter	**Testsprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
ab 18 Jahren	über 20 verschiedene Sprachen vorhanden, z. B. Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch	neben den verfügbaren Papier- und Online-Versionen ist PHQ-9 auch als Telefoninterview validiert worden	Bearbeitungsdauer: 1 bis 2 Minuten Auswertungsdauer: ca. 5 Minuten	Auswertung in Anlehnung an ICD-10 bzw. DSM-IV	Zum PHQ-9 sind einige psychometrische Studien verfügbar (s. o.), die sich mit der kulturellen Äquivalenz des Instruments beschäftigen.	frei verfügbar unter: http://www.phqscreeners.com/

Für das mit dem PHQ-9 verwandte Mood-Modul des Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) wurde in einer Studie an weißen Amerikanerinnen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

und Afroamerikanerinnen gezeigt, dass es kein DIF in den beiden Gruppen gibt. Eine weitere Studie verglich den PHQ-9 anhand von Faktorenanalysen bei einheimischen und aus Surinam zugewanderten Niederländerinnen und Niederländern. Für die Frauen fand sich eine kulturelle Invarianz. Für die Männer konnte diese nur teilweise bestätigt werden, weil das Item zu den psychomotorischen Problemen bei den Männern, die aus Surinam zugewandert waren, in seiner Faktorladung abwich (Baas, Cramer, Koeter, van de Lisdonk, van Weert & Schene, 2011). Die Autoren resümieren, dass der PHQ-9 bei den Frauen der beiden Gruppen problemlos eingesetzt werden kann, für die Männer das abweichende Item kritisch betrachtet werden muss und weitere Forschung nötig ist, um dessen Verhalten in verschiedenen kulturellen bzw. ethnischen Gruppen zu untersuchen (Baas et al., 2011). Eine deutsche Studie, die den PHQ-9 bei Deutschen und in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund verglichen hat, konnte die Messäquivalenz des Instruments in den beiden Gruppen nachweisen. Neben der bereits von Huang et al. (2006) belegten konfiguralen Invarianz (identische faktorielle Struktur) konnten zudem metrische Invarianz (gleiche faktorielle Struktur und gleiche Faktorladungen) sowie skalare Invarianz (gleiche faktorielle Struktur, gleiche Faktorladungen und gleiche „item intercepts“) gezeigt werden (Mewes, Christ, Rief, Brähler, Martin & Glaesmer, 2010).

Wenngleich die hier dargestellten psychometrischen Arbeiten zur kulturellen Äquivalenz des PHQ-9 nur einige Aspekte in unterschiedlichen ethnischen Gruppen vergleichen, sind diese doch insgesamt positiv zu bewerten und lassen vermuten, dass der PHQ-9 gute kulturelle Äquivalenz besitzt. Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass er sich 1. an den DSM-IV- und den ICD-10-Kriterien orientiert, und dass 2. bei der Entwicklung der international etablierten Klassifikationssysteme naturgemäß versucht wird, möglichst breit anwendbare Kriterien auch für den internationalen Vergleich zu formulieren.

HSCL-25

Bei der Hopkins-Symptoms-Checklist-25 (HSCL-25) (vgl. Tabelle 9.2) handelt es sich um ein international etabliertes, sowohl in der Forschung als auch im klinischen Setting breit angewendetes Instrument zur Erfassung von Depression und Angst (Glaesmer, Brähler, Grande, Hinz, Petermann & Romppel, 2014). Das Verfahren besteht aus insgesamt 25 Items, davon 10 zur Erfassung von Angst- und 15 zur Erfassung von Depressionssymptomen. Das Antwortformat ist eine vierstufigen Likert-Skala (von „überhaupt nicht“ bis „extrem“), auf der die aktuelle (die letzten sieben Tage) Belastung durch Angst- und Depressionssymptome erfasst wird. Die Auswertung erfolgt indem die Werte einzelner Items entsprechend der beiden Subskalen bzw. als Gesamtwert aufaddiert werden. Es liegen alters- und geschlechtsspezifische Normen vor.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 9.2: Kurzbeschreibung HSCL-25

Testverfahren:	Hopkins Symptoms Checklist-25 (HSCL-25)					
Autoren:	L. R. Derogatis, R. S. Lipman, K. Rickels, E. H. Uhlenhuth & L. Covi, 1974 Deutsche Version von F. Petermann & E. Brähler, 2013					
Konzeption:	Die HSCL-25 ist eine Symptom-Checkliste zur differenzierten Erfassung von Angst und Depression.					
Untertests:	Besteht aus 25 Items: 10 Items zur Erfassung von Symptomen der Angst, und 15 Items, um depressive Symptome zu erfassen					
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) Skala Angst: α = .84, Skala Depression: α = .91 und Gesamtwert bei α = .94.					
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
14 bis 93 Jahre		Papierversion	Bearbeitungsdauer: etwa 3–5 Minuten. Auswertungsdauer: etwa 3–5 Minuten	Repräsentative Gesamt- sowie alters- und geschlechtsspezifische Normen für Deutschland (*N* = 2.462) von Glaesmer et al. (2014)	Zur HSCL-25 sind einige psychometrische Studien verfügbar (s. u.), die sich mit der kulturellen Äquivalenz des Instruments beschäftigen.	Deutsche Version über Testzentrale Göttingen

Die HSCL-25 liegt in mehreren Sprachen vor (z. B. Arabisch [Al-Turkait & Ohaeri, 2010], Swahili [Lee, Kaaya, Mbwambo, Smith-Fawzi & Leshabari, 2008], Farsi, Dari, Somali, Bosnisch [Jakobsen, Thoresen & Johansen, 2011], Vietnamesisch [Smith Fawzi, Murphy, Pham, Lin, Poole & Mollica, 1997]) und wurde entsprechend häufig im Hinblick auf psychometrische Charakteristika im interkulturellen Vergleich geprüft. So konnten Renner, Salem und Ottomeyer (2006) eine vergleichbar hohe Reliabilität bei Geflüchteten aus Tschetschenien (.92), Afghanistan (.96) und West-Afrika (.91) für die Gesamtskala zeigen. In der Arbeit von Bean und Kollegen (2007) wurden mehrere Sprachversionen von der HSCL-25 in einer Gesamtstichprobe von 3.890 Probanden – unbegleitete minderjährige Geflüchtete, Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie einheimische Jugendliche,

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

jeweils in den Niederlanden und Belgien – miteinander verglichen und validiert. Die Autoren berichten von guten bis sehr guten psychometrischen Charakteristika des Verfahrens und sprechen eine Empfehlung für den Einsatz der HSCL-25 im interkulturellen Kontext aus. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer Studie von Tinghög und Carstensen (2010) für die einheimische schwedische Bevölkerung und in Schweden lebende Migrantinnen und Migranten aus Finnland, dem Irak und dem Iran gezeigt. In der kürzlich publizierten Arbeit von Selmo und Kollegen (2016) konnte zudem gezeigt werden, dass die arabische Online-Version des Verfahrens eine hohe Validität und Reliabilität aufweist.

Insgesamt wird über die Studien hinweg gute interne Konsistenz mit Cronbachs $\alpha \geq .90$ für den Gesamtscore, sowie Cronbachs $\alpha \geq .85$ für die Subskala Depression und Cronbachs $\alpha \geq .76$ für die Angstskala berichtet (Glaesmer et al., 2014). Auch die faktorielle und strukturelle Validität von HSCL-25 im 2-Faktoren Modell wurde in vielen Studien (Selmo et al., 2016; Glaesmer et al., 2014; Mels, Derluyn, Broekaert & Rosseel, 2010) belegt. Ferner werden in einigen Arbeiten von der englischen Originalfassung abweichende Cut-off-Werte für die Subskalen Angst und Depression berichtet (Mollica, Wyshak, deMarneffe, Khuon & Lavelle, 1987). So zeigten Ventevogel und Kollegen (2007) in einer Studie mit afghanischen Probanden (Paschtu-Version des Fragebogens), dass der optimale Cut-Off-Wert für Frauen etwas höher (2.25 vs. 2.0) und für Männer etwas niedriger (1.5 vs. 2.0) angesetzt werden sollte. In der Arbeit von Glaesmer und Kollegen (2014) liegen die Normwerte für die deutsche Allgemeinbevölkerung vor. Insgesamt kann von einer guten bis sehr guten psychometrischen Charakteristik und kultureller Äquivalenz der HSCL-25 ausgegangen werden.

IES-R

Die durch Weiss und Marmar (1997) erweiterte und revidierte Version der ursprünglich von Horowitz und Kollegen (1979) entwickelten Impact of Event-Scale (IES) (Tabelle 9.3) ist das am meisten übersetzte und verwendete Instrument im Bereich traumaassoziierter Störungen. Mit 22 Items werden die drei Symptomcluster einer Posttraumatischen Belastungsreaktion – Intrusionen, Vermeidung und Übererregung – erfasst. Die jeweiligen Symptome werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala bezüglich der Intensität bzw. des Ausmaßes der Belastung (von „ganz und gar nicht belastend“ bis „extrem belastend“) erfasst. Die Frage- bzw. Item-Formulierungen unterscheiden sich von den jeweiligen Fassungen der Diagnosekriterien von Posttraumatischer Belastungsstörung im DSM-5 bzw. ICD-10; eine Schätzformel erlaubt jedoch, aus den drei Subskalen der IES-R das Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung abzuschätzen (Maercker & Schützwohl, 1998).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 9.3: Kurzbeschreibung IES-R

Testverfahren:	Impact of Event Scale-Revised (IES-R)
Autoren:	M. Horowitz, N. Wilner & W. Alvarez, 1979; Revidierte Form: D.S. Weiss & C.R. Marmar, 1997 (In J.P. Wilson & T.M. Keanse) Deutsche Version von A. Maercker & M. Schützwohl, 1998
Konzeption:	Die Skala ist eine Erweiterung der Vorläuferversion IES. Die Items des IES wurden ursprünglich aus dem theoretischen Modell traumatischer Stressfolgen (Horowitz, 1976) abgeleitet.
Untertests:	Drei Subskalen: „Intrusionen", „Vermeidung" und „Übererregung" erfassen typische Formen individueller Reaktionen bzw. Symptome auf extrem belastende Ereignisse.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die interne Konsistenz (Crohnbachs α) liegt für die Skala „Intrusionen" bei α = .90, für die Skala „Vermeidung" bei α = .79, für die Skala „Übererregung" bei α = .90. Die Retest-Reliabilität (3 Monate) betrug für „Intrusionen" r_{tt} = .80, „Vermeidung" r_{tt} = .66 sowie „Übererregung" r_{tt} = .79.

Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
Ab 18 Jahren		Papierversion	Bearbeitungsdauer: 7–15 Minuten Auswertungsdauer: 15–20 Minuten	Auswertung erfolgt in Anlehnung an ICD-10 bzw. DSM-IV	Zur IES-R sind einige psychometrische Studien verfügbar (s.u.), die sich mit der kulturellen Äquivalenz des Instruments beschäftigen.	Deutsche Version über Maercker, A. & Schützwohl, M., 1998.

Inzwischen liegen einige Studien vor, die die unterschiedlichen Sprachversionen des Verfahrens jeweils hinsichtlich ihrer psychometrischen Güte in unterschiedlichen Stichproben analysiert haben. In der Arbeit von Mels et al. (2010), in der Daten von insgesamt 1.046 Probanden aus der Demokratischen Republik Kongo (eingesetzte Sprachversionen: Französisch und Swahili) ausgewertet wurden, konnten sowohl die faktorielle Struktur von IES-R als auch zufriedenstellenden Werte für interne Konsistenz sowie Konstruktvalidität ermittelt werden. Auch in der Arbeit von Warsini und Kollegen (2015) mit Überlebenden eines Vulkanausbruchs in Indonesien wurden zufriedenstellende bis hohe Validitäts- und Reliabilitätswerte für die übersetzte Version von IES-R berichtet. In einer gemischten

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Stichprobe (klinisch vs. non-klinisch) aus Korea konnten Lim und Kollegen (2009), neben hohen Werten für interne Konsistenz, Belege für die gute diskriminante Validität der koreanischen Version von IES-R zeigen. In allen erwähnten Studien wird eine ausdrückliche Empfehlung für den Einsatz der IES-R als Screening zur Erfassung der Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung sowohl im klinischen Setting als auch in der Forschung gegeben. In einer großangelegten Untersuchung von Feuerherd und Kollegen (2014) mit insgesamt 3.820 Probanden aus Spanien, Italien, der Türkei, Großbritannien, Tschechien, Schweden, Polen und Deutschland wurde das Verfahren auf Differential Item Functioning (DIF) untersucht. Bis auf jeweils zwei Items in der tschechischen, schwedischen und türkischen Fassung wurden keine substantiellen sprachbedingten Unterschiede zwischen den Versionen beobachtet, was für eine kulturelle Äquivalenz des Fragebogens spricht. Basierend auf der derzeitigen Befundlage ist grundsätzlich von einer hohen kulturellen Äquivalenz des Verfahrens auszugehen.

HTQ

Das von Mollica und Kollegen (1992) ursprünglich für vietnamesische, laotische und kambodschanische Geflüchtete entwickelte Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) (Tabelle 9.4) steht inzwischen in zahlreichen Sprachen mit jeweiliger kulturspezifischer Anpassung zur Verfügung. Eine deutsche Übersetzung wurde von Maercker (1995) vorgelegt. Das Verfahren besteht aus vier Abschnitten. Im ersten Teil wird den Probanden eine Liste mit potentiell traumatischen Lebensereignissen (z. B. Nahrungsmangel, Gefangenschaft, Vergewaltigung, Entführung, Folter) vorgelegt. Anschließend wird das gravierendste Ereignis näher erfragt (Zeitpunkt/Ort) und es werden die schmerzvollsten Ereignisse im momentanen Aufenthaltsland in einem offenen Antwortformat ermittelt. Im dritten Abschnitt wird nach möglichen Kopfverletzungen gefragt und im vierten Teil schließlich werden mit 30 Items posttraumatische Symptome (nach DSM-III-R) in den letzten sieben Tagen erfasst.

Tabelle 9.4: Kurzbeschreibung HTQ

Testverfahren:	Havard Trauma Questionnaire (HTQ)
Autoren:	R. F. Mollica, Y. Caspi-Yavin, P. Bollini, T. Truong, S. Tor & J. Lavelle, 1992 Deutsche Version von A. Maercker, 1995
Konzeption:	Der HTQ wurde entwickelt, um Foltererfahrungen, Traumatisierungen und Posttraumatischer Belastungsstörung bei Geflüchteten in Interview- oder Fragenbogenform zu erfassen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 9.4: Fortsetzung

Untertests:		Besteht aus 4 Teilen: Teil 1: Erfassung von insgesamt 17 traumatischen Lebensereignissen Teil 2: Beschreibung des gravierendsten Ereignisses und der schmerzvollsten Ereignisse im momentanen Aufenthaltsland. Teil 3: Erfassung möglicher Kopfverletzungen Teil 4: Erfassung der Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit 30 Items innerhalb der letzten sieben Tage				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Hohe Interraterreliabilität (r =.93), Stabilität (r_{tt} = .89) und interne Konsistenz (Cronbachs α = .90) bezüglich der traumatischen Ereignisse (Teil I). Ähnlich hohe Werte lassen sich in zahlreichen Validierungsstudien unterschiedlicher Sprachversionen finden.				
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
ab 18 Jahren		Interview- oder Fragebogenform	Bearbeitungsdauer: 15–20 Minuten Auswertungsdauer: 15–20 Minuten	Auswertung erfolgt in Anlehnung an ICD-10 bzw. DSM-5	Versionen in vielen Sprachen mit spezifischer Anpassung vorhanden. Abschließende Prüfung der kulturellen Äquivalenz steht noch aus.	Deutsche Version verfügbar unter Maercker & Bromberger, 2005.

Für die ursprüngliche Version wird die interne Konsistenz mit Cronbachs α von .90 angegeben. Ähnlich hohe Werte finden sich in zahlreichen Validierungsstudien unterschiedlicher Sprachversionen (de Fouchier, Blanchet, Hopkins, Bui, Ait-Aoudia & Jebel, 2012). Vermutlich aufgrund der Komplexität des Verfahrens sind die Studien, die sich explizit der Frage nach der kulturellen Äquivalenz des HTQ widmen, bislang sehr rar. In der Arbeit von Rasmussen und Kollegen (2015), in der das Verfahren mit insgesamt 878 Geflüchteten aus etwa 80 unterschiedlichen Herkunftsländern in 11 verschiedenen Aufnahmeländern im Hinblick auf die Messinvarianz untersucht wurde, wird von einer konfiguralen Invarianz, jedoch von fehlender metrischer und skalarer Invarianz berichtet. Die Autoren werfen die Frage auf, inwiefern die gängigen Cut-Off-Werte des HTQ über die kulturellen Gruppen hinweg valide sind. Eine erschöpfende Prüfung der kulturellen Äquivalenz des HTQ steht folglich noch aus.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

PHQ-15

Der PHQ-15 (Tabelle 9.5) ist ein Modul des Gesundheitsfragebogens für Patienten (PHQ), das zur Erfassung der häufigsten Körperbeschwerden eingesetzt wird (Kroenke, Spitzer & Williams, 2002; Kroenke, Spitzer & Swindle, 1998). Der Fragebogen stellt eine Liste von 13 somatischen Symptomen (z. B. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Verstopfung, nervöser Darm, Durchfall) und 2 Items aus dem PHQ-9 dar („Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten/vermehrter Schlaf", „Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben") (Abschnitt 9.6: PHQ-9). Es handelt sich um Beschwerden, die häufig von Patienten berichtet werden, jedoch nur selten auf eine organische Ursache zurückzuführen sind. Der PHQ-15 wird deshalb als Screeninginstrument für somatoforme Beschwerden eingesetzt. Auf einer Skala von 0 („nicht beeinträchtigt" bzw. „überhaupt nicht") bis 2 („stark beeinträchtigt" bzw. „an mehr als der Hälfte der Tage") wird der Schweregrad der Belastung in den letzten vier Wochen erfragt. Anhand des errechneten Summenwertes (Bandbreite: 0–30) wird zwischen der minimalen (0–4), milden (5–9), mittelgradigen (10–14) und schwer ausgeprägten (15–30) Symptomstärke bzw. Somatisierung unterschieden. Die interne Konsistenz der Originalskala wird mit Cronbachs $\alpha = .80$ angegeben. Es liegen zahlreiche Übersetzungs- und Normierungsstudien des PHQ-15 vor (z. B. spanische Version mit N = 3.362 [Montalbán, Comas Vives & Garcia-Garcia, 2010], chinesische Version mit N = 3.014 [Lee, Ma & Tsang, 2011], schwedische Version mit N = 3.406 [Nordin, Palmquist & Nordin, 2013]), die von ähnlich hohen Reliabilitätswerten (Cronbachs α zwischen .75 und .85) berichten.

Tabelle 9.5: Kurzbeschreibung PHQ-15

Testverfahren:	Modul somatische Symptome des Patient Health Questionnaire (PHQ-15)
Autoren:	K. Kroenke, R. L. Spitzer & R. Swindle, 1998; K. Kroenke, R. L. Spitzer & J. B. Williams, 2002
Konzeption:	Ein Modul des Gesundheitsfragebogens für Patienten (PHQ), das zur Erfassung des Schweregrads somatischer Beschwerden eingesetzt wird, um Patienten mit somatoformen Störungen zu identifizieren.
Untertests:	Liste mit 13 somatoformen Symptomen und 2 Items aus dem PHQ-9
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die Auswertung erfolgt nach dem Summenscore als Schweregrad der Somatisierungsstörung, in Anlehnung an ICD-10 bzw. DSM-IV

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 9.5: Fortsetzung

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungs-stich-probe	Ergänzende Informa-tionen	Bezug
Ab 18 Jahren	Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch	Papier-version	Bearbei-tungs-dauer: ca. 1 Minute Auswer-tungs-dauer: ca. 1 Mi-nute	Für die deutsche Allge-meinbe-völkerung liegen Norm-werte (*N* = 5.031) von Koca-levent, Hinz & Brähler (2013) vor.	Es fand eine Überprüfung der Mess-varianz im Rahmen einer bevöl-kerungs-repräsen-tativen Befragung bei in Deutschland lebenden Personen mit (*N* = 271) und ohne Migra-tionshinter-grund (*N* = 271) statt (Mewes et al., 2010)	Frei ver-fügbar unter: http:// www. phqscree-ners.com/

Für die deutsche Allgemeinbevölkerung liegen Normwerte (*N*=5 031) von Kocalevent, Hinz und Brähler (2013) mit sehr guten Reliabilitäts- und Validitätswerten vor. Darüber hinaus wurde in der Arbeit von Mewes et al. (2010) die Überprüfung der Messinvarianz von PHQ-15 in einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung bei in Deutschland lebenden Personen mit und ohne Migrationshintergrund vorgenommen. Die Autoren stellen fest, dass für die beiden Vergleichsgruppen von Messäquivalenz des Verfahrens auszugehen ist. So wurden die konfigurale, metrische und skalare Messinvarianz der Skala gezeigt, wodurch Mittelwertvergleiche zwischen der deutschen Allgemeinbevölkerung und der Bevölkerung mit Migrationshintergrund unter der Verwendung von PHQ-15 möglich sind. Die derzeitige Befundlage weist auf eine hohe kulturelle Äquivalenz des Verfahrens hin.

SF-36 Health Survey

Der SF-36 Health Survey (Tabelle 9.6) wurde ursprünglich im Rahmen einer Studie entwickelt, die die Leistung von Versicherungssystemen in den USA prüfte. Die Definition der gesundheitsbezogenen Lebensqualität basiert dabei auf den

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

geltenden Konzepten, die physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden umfassen. Bei der Itemformulierung wurde versucht, einer verhaltensnahen Beschreibung dieser Konstrukte gerecht zu werden. Es handelt sich um einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung, der ab dem Alter von 14 Jahren eingesetzt werden kann (deutsche Version von Bullinger & Kirchberger, 1998). Der Fragebogen liegt als Selbst- und Fremdbeurteilung, sowohl als schriftliche Befragung als auch in Interviewform vor. Das Antwortformat umfasst dichotome und Ratingskalen. Der SF-36 Fragebogen besteht aus acht Skalen der gesundheitsbezogen Lebensqualität, subsumiert zu den zwei Hauptskalen physische und psychische Lebensqualität, in insgesamt 36 Items. Die vier Skalen der psychischen Dimension sind Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden. Die physische Summenskala schließt körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Rollenfunktion, Schmerz und allgemeine Wahrnehmung ein. Darüber hinaus existieren die Kurzversionen SF-12 und SF-8 (Ellert, Lampert & Ravens-Sieberer, 2005). Die interne Konsistenz wird mit Cronbachs α zwischen 0.57 und 0.89 je nach Skala angegeben.

Tabelle 9.6: Kurzbeschreibung SF-36

Testverfahren:	SF-36 Health Survey
Autoren:	Der SF-36 wurde von der RAND Corporation im Rahmen der so genannten Medical Outcomes Study (MOS) entwickelt. A. R. Tarlov, J. E. Ware, S. Greenfield, E. C. Nelson, E. Perrin & M. Zubkoff, 1989 Deutsche Version von M. Morfeld, I. Kirchberger, M. Bullinger, 2011.
Konzeption:	Krankheitsunspezifisches Messinstrument zur Erhebung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Er kann den individuellen Gesundheitszustand von Patienten beschreiben und krankheitsbedingte Belastungen im Verlauf messen und vergleichen.
Untertests:	Der SF-36 Fragebogen besteht aus acht Skalen der gesundheitsbezogen Lebensqualität, subsumiert zu zwei Hauptskalen – physische und psychische Lebensqualität – in insgesamt 36 Items. Die vier Skalen der psychischen Dimension sind Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden. Die physische Summenskala schließt körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Rollenfunktion, Schmerz und allgemeine Wahrnehmung ein.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Interne Konsistenzen (Cronbachs α) der Originalskala liegen bei α = .92 für physische Komponenten und bei α = .91 für die psychische Komponente. In der deutschen Fassung liegen die internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) der Subskalen in verschiedenen Stichproben mehrheitlich deutlich über .70.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungs-stichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
Ab 14 Jahre	Über 40 verschiedene Sprachversionen	Fragebogen liegt als Selbst- und Fremdbeurteilung, sowohl in schriftlicher als auch in Interviewform vor.	Bearbeitungsdauer: ca. 10 Minuten Auswertungsdauer: ca. 15–20 Minuten	Es liegen Normdaten für Deutschland aus der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von 1994 (*N* = 2.914) und aus dem Bundesgesundheitssurvey von 1998 (*N* = 6.967) vor.	In mehreren Ländern validiert und als kulturübergreifendes Verfahren entwickelt z.B. in Argentinien, Bangladesch, Brasilien, China, Estland, Finnland, Griechenland, Indien, Iran, Israel, Kosovo, Kroatien, Polen, Russland, Südafrika, Tanzania, Türkei, Ukraine u.a.	Deutsche Version über Testzentrale Göttingen

Der SF-36 gilt als ein Standardverfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und wurde bereits in 40 Sprachen übersetzt. So berichten Thumboo und Kollegen (2001) von vergleichbaren faktoriellen Strukturen und entsprechenden Faktorladungen der einzelnen Items des Fragebogens in englischer und chinesischer Version bei Befragten aus einem multikulturellen Kontext in Singapur. In der Arbeit von Bjorner, Kreiner, Ware, Damsgaard & Bech (1998), in der die dänische Übersetzung des SF-36 einer statistischen Prüfung unterzogen wurde, berichten die Autoren von einzelnen Items, die unterschiedlich interpretiert und bewertet werden, jedoch von grundsätzlicher Äquivalenz der beiden Sprachversionen auf der Skalenebene. Ähnliche Berichte finden sich für die spanische Version (Arocho, McMillan & Sutton-Wallace, 1998), sowie für die russische (Hoffmann et al., 2005) und die chinesische (Lam, Lam, Fong & Huang, 2013) Kurzversion SF-12 Health Survey. In der Arbeit von Ngo-Metzger und Kollegen (2008) wird dagegen auf die Unterschiede bei den Antworttendenzen zwischen älteren vietnamesischer Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu Einheimischen hingewiesen. Die Autoren fanden höhere Ladungen der Skala „körperlicher Schmerz“ auf der mentalen Komponente des Fragebogens, was bereits in den Arbeiten von Fukuhara, Ware, Kosinski Wada & Gandek (1998) mit japanischen und Fuh, Wang, Lu, Juang & Lee (2000) mit taiwanesischen Probanden gezeigt wurde. Alles in

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

allem spricht die derzeitige Befundlage aus den Arbeiten, die sich mit den psychometrischen Charakteristika des Fragebogens beschäftigt haben, für eine befriedigende bis gute kulturelle Äquivalenz von SF-36 Health Survey.

9.7 Das Cultural-Formulation-Interview (CIF) nach DSM-5

Für die diagnostische Arbeit, insbesondere im klinischen Setting, ist es unerlässlich, den intraindividuellen Kontext einer Erkrankung oder Störung aufzudecken und zu verstehen. Unabhängig vom Migrationshintergrund der Klientinnen und Klienten spielt dabei das, was als Kultur bzw. kulturelle Prägung bezeichnet wird, eine große Rolle. Es gibt zahlreiche Ansätze, dem Begriff Kultur eine Definition zu geben. So wird aus anthropologischer Sicht auf die Inhalte verwiesen, die eine Kultur ausmachen, die Kohäsion innerhalb einer Gruppe stärken und die eine Kultur von einer anderen unterscheiden. Behavioristische Ansätze dagegen definieren eine Gemeinschaft aufgrund ihrer Verhaltensweisen und Leistungen bzw. unterscheiden sie so von anderen (Zick 2010). Hierbei wird Kultur als eine gemeinschaftliche/gesellschaftliche Verhaltensprägung beschrieben, die einerseits die Wahrnehmung der Lebenswelt und andererseits die Anpassung an die Umwelt bestimmt (Chiu, Leung & Hong, 2010). Eine Synthese dieser beiden Ansätze findet sich im Teil III des DSM-5 (American Psychiatric Association/Falkai et al., 2015) im Kapitel „Kulturell gebundene Ausdrucksformen". Es wird ausdrücklich auf die Bedeutung des kulturellen Kontextes bei der diagnostischen Arbeit hingewiesen, wobei Kultur als ein offenes System beschrieben wird, welches Sprache, Religion und Spiritualität, Familienstrukturen, Abschnitte des Lebenszyklus, zeremonielle Rituale genauso wie moralische Überzeugungen in dem jeweiligen sozialen und rechtlichen Lebensraum einschließt. Auf dieser Grundlage wird im DSM-5 die Empfehlung ausgesprochen, sich bei der Diagnosestellung auf spezifische Konzepte bzw. Wissenssysteme der Klientinnen und Klienten zu beziehen, die in Form von Gebräuchen sowie kulturell gebundenen Einstellungen erlernt und über Generationen hinweg weitergegeben werden. Dabei wird insbesondere auf folgende vier Aspekte verwiesen:

- *Kulturelle Identität einer Person*: Bei diesem Aspekt handelt es sich um eine genaue Beschreibung der ethnischen und/oder kulturellen Referenzgruppe einer Person. Dabei spielt bei Menschen mit Migrationshintergrund die Anbindung an die Kultur des Herkunftslandes ebenso eine wichtige Rolle wie die Auseinandersetzung mit den Gepflogenheiten und Bräuchen des Aufnahmelandes. So werden beispielsweise Sprachfähigkeiten und -präferenzen als bedeutsame Indikatoren für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen angesehen. Aber auch andere Aspekte der Identität wie Alter, Geschlecht, Religiosität, sozioökonomischer und/oder rechtlicher Status, erlernter/ausgeübter Beruf oder

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sexuelle Orientierung können je nach kulturellem Hintergrund unterschiedlich starke klinische Relevanz in sich bergen.

- *Kulturell gebundene Leidenskonzepte*: Ist die Erfassung der kulturellen Referenzgruppe erfolgt, so sind kulturell bedingte Beschreibungen des Symptomerlebens und -verstehens in der jeweiligen kulturellen Gruppe von Interesse. Dazu gehören neben den klassischen kulturellen Syndromen (z. B. „Windattacke" bei den Kambodschanern in den USA und in Kambodscha mit den typischen Symptomen einer Panikattacke, die im Rahmen einer Panikstörung, Generalisierten Angststörung, Posttraumatischen Belastungsstörung oder Krankheitsangststörung auftreten kann) Leidensnarrative und Erklärungsmodelle bzw. wahrgenommene Ursachen eines Krankheitsbildes. Wichtig hierbei sei bei der Bestimmung des Schweregrades der geschilderten Symptome, auf die Relation zu den Normen der jeweiligen kulturellen Referenzgruppe zu achten.
- *Psychosoziale Stressoren und kulturelle Besonderheiten von Vulnerabilität und Resilienz*: Vor allem für die postdiagnostische Arbeit ist es von großer Bedeutung, detaillierte Informationen über vorhandene Schlüsselstressoren aus dem sozialen Umfeld (z. B. wahrgenommene Ausgrenzung aufgrund der religiösen Zugehörigkeit) zu erfragen. Zugleich bieten unterschiedliche kulturelle Umwelten einer Person vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, die bei der Krankheitsverarbeitung und/oder -bewältigung eine wichtige Rolle spielen können. Auch hier sollten die Gepflogenheiten der jeweiligen kulturellen Referenzgruppe Berücksichtigung finden.
- *Kulturelle Eigenschaften der Beziehungen zwischen dem/der Betroffenen und dem/der Behandler/in*: Ein besonderes Augenmerk sollte aufseiten der klinischen Expertinnen und Experten auf die kulturellen Unterschiede bzw. gegebenenfalls Diskrepanzen zwischen den eigenen Vorstellungen von Krankheitsursache, -verlauf und -behandlung sowie den Sichtweisen der Klientinnen und Klienten aus anderen Kulturräumen gerichtet sein. Hierbei tragen das rechtzeitige Erkennen sowie das anschließende Besprechen möglicher Missverständnisse aufgrund kultureller Eigenheiten zu einer erforderlichen Arbeitsbeziehung zwischen den Beteiligten bei und wirken sich längerfristig positiv im Sinne einer effektiven klinischen Allianz auf den Therapieprozess aus.

Gerade im Hinblick auf den letztgenannten Aspekt ist aus der nationalen (Morina, Maier & Schmidt Mast, 2010) und internationalen (Green, Ngo-Metzger, Legedza, Massagli, Phillips & Iezzoni, 2005) Literatur zur Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund und unzureichenden Sprachkenntnissen des Aufnahmelandes bekannt, dass der Einsatz professioneller Sprachmittlung nicht nur die Verständigung erleichtert, sondern sich auch positiv auf die Behandler/in-Patient/in-Beziehung auswirkt. Dabei setzt die Sprachmittlung neben der reinen Übersetzungstätigkeit vertiefte medizinische Kenntnisse, das Wissen um Werte und Normen der jeweiligen Kulturkreise sowie eine neutrale Vermittlungsrolle in der Triade Behandler/in-Sprachmittler/in-Patient/in voraus. Trotz des

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

positiven Zusammenhangs zwischen der Zufriedenheit mit der Behandlung seitens der Patientinnen und Patienten mit unzureichenden Sprachkenntnissen des Aufnahmelandes und dem Grad der Professionalität der Sprachmittlung (Green et al., 2005), ist der Einsatz sogenannter „Laiendolmetscher" im ambulanten wie stationären Bereich häufig an der Tagesordnung. Gerade beim Hinzuziehen nicht-professioneller Kultur- und Sprachmittler gilt es eine Reihe an Besonderheiten während der Diagnostik bzw. Therapie von Patienten mit unzureichenden Sprachkenntnissen, insbesondere bei Geflüchteten, zu berücksichtigen. Detaillierte Information zur Arbeit mit Sprachmittlern im interkulturellen, psychotherapeutischen Kontext finden sich in den Beiträgen von Morina, Maier und Schmidt Mast (2010) sowie Kluge (2011).

Aufbauend auf den vier oben beschriebenen Aspekten einer kultursensiblen diagnostischen Arbeit bietet das DSM-5 ein kurzes, halbstrukturiertes Interview zur besseren Einschätzung möglicher kultureller Kontexte einer psychischen Störung. Das Cultural-Formulation-Interview (CFI) besteht aus einem Set von 16 Fragen, die den folgenden vier Bereichen zugeordnet werden: kulturelle Definition des Problems (Fragen 1 bis 3), kulturelle Wahrnehmung der Ursachen, des Kontextes und der Unterstützung (Fragen 4 bis 10), kulturelle Einflussfaktoren auf Selbstbewältigung und früheres Hilfesuchverhalten (Fragen 11 bis 13) und kulturelle Einflussfaktoren auf aktuelles Hilfesuchverhalten (Fragen 14 bis 16). Das Interview ist frei zugänglich (z. B. online unter www.psychiatry.org/dsm5) und wird zum Einsatz in Kombination mit den demografischen Informationen empfohlen.

Im Folgenden werden zwei Fälle aus der Praxis vorgestellt, die die in diesem Buchbeitrag thematisierten Aspekte adressieren und anhand derer eine abschließende Diskussion der kultursensiblen psychodiagnostischen Arbeit im Erwachsenenbereich erfolgen soll.

9.8 Fallbeispiele klinischer Begutachtung Geflüchteter

Fallbeispiel 1: Frau A., geboren 1975 in der Republik Tschetschenien (Russische Föderation)

Frau A. sei 1975 in einem Dorf in Tschetschenien geboren und dort mit ihren Eltern sowie mehreren Geschwistern aufgewachsen. Sie habe 11 Jahre die Schule besucht und habe Ärztin werden wollen. So habe sie zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und in diesem Beruf danach gearbeitet. Im Krieg habe sie als Krankenschwester Verwundete versorgt. Während ihrer Berufsausbildung habe sie ihren ersten Mann kennengelernt, der jedoch zwei Monate nach der Heirat im ersten Tschetschenienkrieg gefallen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sei. Sie selbst sei im Krieg durch eine Explosion verletzt worden und habe schwere Verbrennungen erlitten. Kurze Zeit später sei sie mit dem Sohn einer einflussreichen Familie aus ihrem Dorf zunächst nach muslimischer Tradition, später auch standesamtlich verheiratet worden. Sie habe den zweiten Ehemann nicht näher gekannt und habe ihn nicht selbst ausgesucht. Nach der Eheschließung sei sie zur Familie des Mannes gezogen. Dort sei sie von Anfang an sehr schlecht behandelt worden. Sie sei weiter berufstätig gewesen, habe aber zusätzlich vor und nach der Arbeit im Haushalt sowie auf dem Hof schwer arbeiten müssen. Ihre Herkunftsfamilie habe sie nur mit Erlaubnis ihres Mannes sehen dürfen. Nach dem Tod des Schwiegervaters habe ihre Schwiegermutter ihren Sohn – d. h. den Ehemann von Frau A. – gedrängt, sich von Frau A. zu trennen. Sie sei dann mehr oder weniger hinausgeworfen worden und habe gemäß der Tradition ihre beiden Söhne nicht mitnehmen dürfen. Sie sei dann wieder zu ihren Eltern gezogen, einige Familienmitglieder hätten ihr die Schuld an der Trennung gegeben. Sie habe eine sehr schwere Zeit durchgemacht und sich emotional wie betäubt gefühlt.

Nach drei Monaten sei es ihr gelungen, ihre Kinder zu sehen. Einer ihrer Söhne – damals ca. anderthalb Jahre alt – sei in einem sehr schlechten körperlichen Zustand gewesen. Alles habe auf Vernachlässigung der Kinder im Haushalt ihres Mannes hingewiesen. Sie habe die Kinder dann eine Woche bei sich gehabt, und diese hätten sich erholt; dann sei sie jedoch gezwungen worden, die Kinder wieder zum Mann zu geben. In der Folgezeit sei es ihr möglich gewesen, die Kinder ca. einmal im Monat zu sehen. Es seien deutliche Entwicklungsrückstände und Mangelversorgung der Kinder erkennbar gewesen. Ihr Mann habe dann erneut geheiratet, diese Beziehung habe jedoch nur wenige Monate gehalten. Danach habe ihr Mann sie gebeten zurückzukehren, sie habe wegen der Kinder eingewilligt. Danach habe sie mit ihrem Mann eine Tochter bekommen. Ihr Mann habe sie nach ihrer Rückkehr noch schlechter behandelt, sei reizbar und gewalttätig gewesen. Es sei zu körperlichen und sexuellen Übergriffen gekommen. Die Kinder seien oft Zeugen gewesen und seien auch selbst misshandelt worden. Ihr Mann habe Waffen im Haus gehabt und habe gedroht, dass es ihm nicht schwer fallen würde, sie umzubringen. Da ihr Mann sein Einkommen nicht für die Versorgung der Familie zur Verfügung gestellt habe, sei sie recht schnell wieder als Krankenschwester arbeiten gegangen, um die Kinder zu ernähren. Die Situation im Haushalt habe sich weiter zugespitzt; aus Angst um die Kinder sei sie jedoch geblieben. Von ihrer Schwiegerfamilie sei sie dann bezichtigt worden, eine außereheliche Beziehung zu haben, was aber nicht der Wahrheit entsprach.

Mit Vermittlung des Dorfältesten sei es schließlich gelungen, dass sie mit ihren Kindern habe gehen dürfen. Sie habe sich eine Wohnung im Ort gesucht und dort mit den Kindern gelebt. Ihr Mann habe ihr nachgestellt, sei gegen ihren Willen in die Wohnung eingedrungen, habe ihr schließlich aufgelauert

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

und gedroht, sie am Ende des Ramadan (muslimischer Fastenmonat) umzubringen. Da er selbst bei der Polizei tätig war, habe sie keine Chance gesehen, Unterstützung durch die Behörden zu bekommen. Sie habe dann entschieden, mit den Kindern zu fliehen. Sie sei inzwischen in Deutschland angekommen, mache sich große Sorgen um ihre Familie und habe gehört, dass ihr Mann sie angezeigt habe. Aufgrund seiner Kontakte zu Polizei und Geheimdienst habe sie große Angst, dass er ihren Aufenthaltsort herausfinden und sie auch hier verfolgen lassen könne. Inzwischen gingen ihre Söhne in Deutschland zu Schule, ihre Tochter in den Kindergarten. Frau A. leidet unter Alpträumen und könne sich kaum konzentrieren. Sie habe oft „Aussetzer" und könne sich an bestimmte Zeiträume nicht mehr erinnern. Es falle ihr schwer dem Sprachkurs zu folgen, obwohl sie hoch motiviert sei. Sie sagt, ihre Kinder hielten sie am Leben, obwohl sie sich oft sehr kraftlos fühle und es ihr schwerfalle, den Alltag zu bewältigen. Frau A. befindet sich zum Zeitpunkt des Gesprächs in ambulanter psychiatrischer Behandlung.

Das diagnostische Gespräch mit Frau A. wurde auf Russisch mit Hilfe einer Sprachmittlerin geführt. Es wurden die HSCL-25 zur Erfassung der Angst- und Depressionssymptomatik sowie die Traumaliste des HTQ und PCL-5 zur Erfassung der posttraumatischen Symptomatik in russischer Übersetzung genutzt. Die Fragebögen wurden von Frau A. selbständig beantwortet, Unklarheiten wurden besprochen. In der Traumaliste berichtet Frau A. über verschiedene Traumatisierungen (körperliche und sexuelle Gewalt, Kriegserleben, körperliche Verletzungen). Das A-Kriterium der Posttraumatischen Belastungsstörung ist damit erfüllt. Die PCL-5 erfasst die vier Symptomcluster der Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-5. Alle vier Cluster liegen bei Frau A. in einem klinisch relevanten Ausmaß vor. Auf der Angst- und Depressionsskala der HSCL-25 erreicht Frau A. jeweils einen Skalenmittelwert von 3,6. Der Grenzwert von 1,75 wird damit deutlich überschritten, was für eine klinisch hoch relevante Angst- und Depressionssymptomatik spricht.

Die von Frau A. berichteten Symptome und die Befunde aus der Testdiagnostik rechtfertigen die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (F43.1). Frau A. zeigt zudem ein deutliches dissoziatives Geschehen, was die Schwere der posttraumatischen Symptomatik unterstreicht. Darüber liegt eine mittelgradige depressive Episode vor (F32.1). Die Schwere der Symptomatik spricht für einen dringenden Behandlungsbedarf, wobei eine Kombination aus Psychopharmakotherapie und Psychotherapie unbedingt angezeigt ist.

Fallbeispiel 2: Herr C., geboren 1982 in Eritrea

Herr C. sei 1982 als fünftes und letztes Kind der Eltern in Eritrea geboren worden. Die Eltern seien verstorben, als er noch klein gewesen sei. Daraufhin sei er von den älteren Geschwistern getrennt in einer Pflegefamilie aufgewachsen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Er habe fünf Jahre die Schule besucht und diese dann verlassen, um in der Landwirtschaft zu arbeiten. Um nicht in die Armee zu müssen, habe er sich ab seinem 18. Lebensjahr immer wieder versteckt. Mit 23 sei er dann von der Armeepolizei aufgegriffen und zum Wehrdienst gezwungen worden. Er habe nicht als Soldat kämpfen, sondern schwer arbeiten müssen. Nach einem Fluchtversuch sei er in ein Armeegefängnis gekommen und dort sehr schlecht behandelt worden (z. B. Zelle unter der Erde ohne Licht, Mangel an Nahrung und Wasser, körperliche Misshandlungen). 2010 sei ihm die Flucht aus dem Gefängnis über die Grenze in den Sudan gelungen, wo er bis 2013 gelebt und gearbeitet habe. Als Christ sei er im Sudan oft schlecht behandelt und erniedrigt worden. 2014 sei er durch die Wüste nach Libyen geflohen; dabei sei er fast verhungert und verdurstet, weil er drei Tage ohne Nahrung und Wasser verbracht habe. In Libyen habe er in einem Flüchtlingscamp gelebt, habe dort manchmal nicht ausreichend Wasser und Nahrung erhalten, sei auch von den Bewachern misshandelt worden. Nach einigen Wochen sei er dann mit einem Boot nach Italien (Insel Lampedusa) übergesetzt worden. Das Boot sei drei Tage unterwegs gewesen, auch auf dem Boot habe es kaum Nahrung und Wasser gegeben. Ein Kind sei vor seinen Augen gestorben.

Nach seiner Ankunft in Italien sei er nach Rom überstellt worden und habe auf der Straße geschlafen. Ihm sei lediglich eine Karte mit seinem Foto ausgehändigt worden, für die er Wasser und Brot erhalten habe. Es sei ihm klar geworden, dass er in Italien keine Perspektive habe, und er sei zunächst in die Schweiz weitergezogen. Da er von dort nach Italien abgeschoben werden sollte, sei er nach Deutschland weitergereist. 2014 habe er in Deutschland einen Asylantrag gestellt, der als unzulässig abgelehnt wurde, weil Italien für ihn zuständig sei. Er sei nach Italien geflogen worden; die dortige Polizei habe ihn zwingen wollen, seine Fingerabdrücke abzugeben. Weil er sich geweigert habe, habe er einen Tag keine Nahrung erhalten, er sei getreten und am Toilettenbesuch gehindert worden. Schließlich habe man ihn auf die Straße gesetzt; er habe sich von einem Eritreer Geld geben lassen und sei mit dem Bus wieder nach Deutschland gereist. Zum Zeitpunkt des Gesprächs lebt Herr C. in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Er habe keinen Kontakt zu seinen Geschwistern, aber gute soziale Kontakte zu Landsleuten in der Einrichtung.

Das etwa 90minütige diagnostische Gespräch wurde mithilfe einer Sprachmittlerin in Tigrinya geführt. Es standen keine übersetzten diagnostischen Instrumente zur Verfügung.

Wie im biographischen Hintergrund beschrieben, hat Herr C. bereits in der Kindheit seine Eltern verloren und ist unter schwierigen Bedingungen in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Er erlebte seit der Kindheit wiederholte Traumatisierungen und vor allem Entbehrungen – während seiner Zeit als Soldat und auf der Flucht. Aktuell lebt er in ständiger Angst vor der Rückführung

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

nach Italien. Die beschriebenen Erlebnisse sind als sequenzielle Traumatisierungen (vor und während der Flucht) zu verstehen, die oft mit schwerwiegenden psychischen Folgen einhergehen. Herr C. leidet unter Ein- und Durchschlafstörungen, da er einerseits nicht zur Ruhe kommt (Hyperarousal), anderseits aber Angstzustände und Alpträume hat. Oft wird er auch tagsüber von sich plötzlich aufdrängenden Erinnerungen (Flashbacks) gequält. Er hat ausgeprägte Konzentrationsschwierigkeiten, die es ihm sehr schwer machen, dem Deutschkurs zu folgen. Gedanken und Hinweisreize, die ihn an seine Traumatisierungen erinnern, vermeidet er, weil sie sonst sehr unangenehme Erinnerungen auslösen. Die von ihm berichteten Symptome sprechen für eine Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1). Darüber hinaus leidet er unter Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit. Oft zieht er sich sozial zurück und sitzt grübelnd in der Ecke. Er berichtet über häufige Suizidgedanken, aber nicht über konkrete Pläne. Neben der Posttraumatischen Belastungsstörung liegt eine depressive Episode mittleren Schweregrades vor (F32.1). Die identifizierten psychischen Störungen sind so ausgeprägt, dass sie einer psychotherapeutisch-psychopharmakologischen Behandlung bedürfen.

Diagnostische und therapeutische Schlussfolgerungen aus beiden Fällen

Aus beiden Fallbeschreibungen wird die Tragweite der im Cultural-Formulation-Interview (CFI) beschriebenen Aspekte auf die diagnostische und die darauf aufbauend therapeutische Arbeit sichtbar. Sowohl bei Frau A. als auch bei Herrn C. spielt die kulturelle Identität mit den daraus resultierenden sozialen Erwartungen eine nicht unerhebliche Rolle für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Symptomatik. Einen wichtigen Aspekt stellt dabei die religiöse Prägung der Klienten dar. Während bei Frau A. der stark patriarchal geprägte muslimische Hintergrund ihre Funktion als „gute“ Ehefrau und Mutter (hierbei sowohl intrinsisch ausgelebt als auch von der Umwelt aufdiktiert) bestimmt, erlebte Herr C. Anfeindungen aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Christentum. In beiden Fällen ist die gelebte Religiosität an die jeweiligen Geschlechterrollen und folglich die Erwartungen seitens der Referenzgruppe geknüpft. Für beide Klienten waren der sozioökonomische Status der jeweiligen Ursprungsfamilie sowie der rechtliche Status in dem Aufnahmeland, bei Herrn C. im besonders tragischen Ausmaß, mit erheblichen Hindernissen für einen gesundheitsfördernden Umgang mit widrigen Lebensumständen und letztendlich für die Linderung der Symptomatik verbunden. In Hinblick auf die Schilderung der Symptome wurden vor allem bei Frau A. differentialdiagnostisch Auffälligkeiten beobachtet. So stellte sich die Frage, ob die beschriebenen Ängste (die Patientin hört nachts Schritte in der Wohnung und hat dann Angst, dass ihr Ehemann in der Wohnung sein könnte), als psychotisches

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Erleben oder im Kontext des Erlebten und der Posttraumatischen Belastungsstörung zu verstehen sind. Bei Herrn C. fiel auf, dass er oft sehr einfache Worte wählte und weniger in der Lage war, zusammenhängend zu berichten. Dies stellte eine große Herausforderung dar, da während der Arbeit mit Herrn C. aufgrund des Fehlens standardisierter Testverfahren in Tigrinya ausschließlich auf die Befragung des Klienten zurückgegriffen werden konnte. Bezüglich der kulturellen Eigenheiten von Vulnerabilität und Resilienz wurde bei beiden Klienten eine Reihe von Schlüsselstressoren aufgedeckt.

In beiden Fällen ist die prekäre Struktur der Lebensverhältnisse zu nennen, die bei Herrn C. schlicht mit Abwesenheit von nahen verwandtschaftlichen Bezugspersonen zu charakterisieren wäre und bei Frau A. von lang andauernder häuslicher Gewalt gekennzeichnet war. Auch die bereits erwähnte Diskriminierung, der Herr C. ausgesetzt war, spielt hierbei eine Rolle. Abgesehen von der geschilderten Symptomatik wurden zusätzliche Stressoren bei den Klienten eruiert, die von einer typischen Lebenssituation Geflüchteter zeugen. Für beide Klienten stellte das auslaufende Asylverfahren und eine damit einhergehende Unsicherheit in Bezug auf einen weiteren Verbleib in Deutschland eine große Belastung dar. In beiden Fällen handelt es sich um Geflüchtete, die nur über wenige soziale Kontakte verfügen. Das isolierte Leben, mit einem Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, stellt ein Risiko für eine Chronifizierung der ohnehin labilen psychischen Verfassung und eine Komplexitätserhöhung des klinischen Bildes dar, was in der psychotherapeutischen Arbeit mit den Klienten entsprechend Berücksichtigung finden sollte. Letztendlich sind die Beziehungsgestaltung zwischen den Klienten und der Diagnostikerin sowie das Hinzuziehen von Sprachmittlung während des diagnostischen Prozesses als wichtige Einflussfaktoren zu nennen. Für die abschließende Diagnosestellung waren zum einem das Hintergrundwissen über die soziale und politische Lage in den beiden Herkunftsländern sowie in den angrenzenden Regionen von großer Bedeutung, zum anderen musste die eigene Rolle bzw. „Machtposition" als Diagnostiker im aufenthaltsrechtlichen Verfahren stets einer kritischen Reflexion unterzogen werden. Dabei wurde die Zusammenarbeit mit sprach- und kulturmittelnden Personen als sehr unterstützend erlebt.

9.9 Diskussion und Ausblick

Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung in Deutschland liegt inzwischen bei 21 %, wobei etwa Zweidrittel der ersten Generation angehören, d. h. selbst migriert sind (Statistisches Bundesamt, 2016). Die derzeit geführten politischen und medialen Debatten um das Thema Migration werden jedoch von den seit etwa drei Jahren stark steigenden Zahlen an Geflüchteten bzw. Asylsuchenden in Deutschland bzw. in Europa dominiert. Dabei wird die Anzahl der in letzten drei Jahren gestellten Erstanträge auf Asyl mit 173.072

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Anträgen in 2014, 441.899 in 2015 und 722.370 in 2016 (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2017), auch ohne die Zahl der erfolgten Abschiebungen, kaum ins Verhältnis zu allen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland (etwa 17,1 Mio.) gesetzt.

An dieser Stelle ist es den Autoren ein Anliegen, explizit darauf hinzuweisen, dass es einen großen Unterschied zwischen Migrantinnen und Migranten mit und ohne Fluchthintergrund gibt. Dieser Unterschied äußert sich besonders stark auf der Ebene der psychischen Gesundheit. Während bei Geflüchteten aus Konflikt- und Postkonfliktregionen mit deutlich höheren Prävalenzraten für die gängigen psychischen Störungen im Vergleich zur einheimischen deutschen Bevölkerung zu rechnen ist, gilt dies, nach derzeitiger nationaler und internationaler Befundlage, nicht für Migrantinnen und Migranten ohne Fluchterfahrung. Die Frage nach dem subjektiven und objektiven Versorgungsbedarf beim Vorliegen einer psychischen Störung bleibt jedoch nach wie vor das, was die beiden Gruppen eint, wie auch die daraus resultierenden Herausforderungen aufseiten des Gesundheitssystems, kultursensible und entsprechend evaluierte Präventions- und Interventionsangebote für verschiedene kulturelle Gruppen anzubieten.

Auf Basis der zurzeit verfügbaren Arbeiten zur psychischen Gesundheit von Migrantinnen und Migranten bzw. insbesondere von Geflüchteten in den westlichen Industriestaaten wurden in diesem Buchbeitrag die Aspekte einer kultursensiblen diagnostischen Arbeit bei Erwachsenen besprochen. Dabei wurde aus der Literatur abgeleitet, dass gesundheitsbezogene Nachteile sowohl mit dem Blick auf den diagnostischen Prozess als auch die Behandlungsmöglichkeiten unmittelbar mit der Migrationsbiographie der Klientinnen und Klienten in Beziehung gesetzt werden müssten. Je nach kultureller Prägung und dem Grad der im Zuge der Migration stattfindenden Anpassung aufseiten der Migrierten sowie den strukturellen, rechtlichen und nicht zuletzt personellen Möglichkeiten bzw. Einschränkungen des Gesundheitssystems aufseiten der Aufnahmegesellschaft, kommt es zu unterschiedlichsten Ausdrucksformen bzw. Verarbeitungsstrategien von psychischen Belastungen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Da es sich bei den in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund um eine sehr heterogene Gruppe handelt, ist eine nach kultureller Prägung der Klientinnen und Klienten differenzierende Diagnostik unerlässlich.

Der klinischen Individualdiagnostik steht neben dem klassischen Interview eine Reihe von Testverfahren zur Verfügung, deren Einsatz aus kultursensibler Perspektive empfohlen werden kann. Aus wissenschaftlicher Sicht wird hierbei zwischen der Kultursensitivität und der kulturellen Äquivalenz eines Verfahrens unterschieden. Während ein kultursensitives Verfahren explizit die sprachlich und kulturell gefärbten Charakteristika des zu messenden Phänomens so präzise wie möglich abzubilden versucht (z. B. unter Rückgriff auf einprägsame Idiomatik der kulturellen Referenzgruppe), beschreibt die kulturelle Äquivalenz eines Verfah-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

rens die Vergleichbarkeit dessen, was gemessen wird, über verschiedene Kulturen bzw. Sprachen hinweg. Da die Kriterien für die gängigen psychischen Störungen im ICD-10 sowie im DSM-5 mit dem Anspruch einer möglichst breiten Anwendung auch für den internationalen Vergleich entwickelt und formuliert worden sind, steht die Überprüfung der kulturellen Äquivalenz der besonders häufig eingesetzten Testverfahren stärker im Fokus der Forschung. Zur besseren Einschätzung der Symptomatik eines Klienten bzw. einer Klientin mit Migrationshintergrund stehen dem praktisch tätigen Diagnostiker Referenznormen aus verschiedenen Ländern zur Verfügung.

Die darauf basierende abschließende Interpretation der erhobenen Werte im Sinne der Kultursensitivität der Diagnosestellung sollte vertieft mithilfe des Cultural Formulation Interviews oder ähnlicher Ansätze erfolgen. Die im Zuge der diagnostischen Arbeit gestellte Diagnose sollte daher als ein Balanceakt zwischen Forschung und Praxis verstanden werden, der von dem Diagnostiker eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigensetzten Verfahren, aber auch eine individuelle Kontextualisierung verlangt. Sowohl die nationale als auch die internationale Befundlage zur kulturellen Äquivalenz von Testverfahren im klinischen Bereich ist bislang lückenhaft. Den praktisch tätigen Kollegen und Kolleginnen möchten wir dennoch empfehlen, auf den Einsatz der vorgestellten Verfahren in Sinne eines Screenings zurückzugreifen. Beim Einsatz von in diesem Buchbeitrag nicht besprochener Verfahren sollten Angaben zur kulturellen Äquivalenz des Verfahrens sorgfältig einer kritischen Analyse unterzogen werden.

Literatur

Al-Turkait, F.A. & Ohaeri, J.U. (2010). Dimensional and hierarchical models of depression using the Beck Depression Inventory-II in an Arab college student sample. *BMC Psychiatry, 10*, 60. http://doi.org/10.1186/1471-244X-10-60

American Psychiatric Association/Falkai, P. et al. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.

Arocho, R., McMillan, C.A. & Sutton-Wallace, P. (1998). Construct validation of the USA-Spanish version of the SF-36 health survey in a Cuban-American population with benign prostatic hyperplasia. *Quality of Life Research, 7*, 121–126. http://doi.org/10.1023/A:1008801308886

Assion, H., Bransi, A. & Koussemou, J. (2011). Migration und Posttraumatische Belastungsstörung. In G.H. Seidler, H. J Freyberger & A. Maercker (Hrsg.), *Handbuch der Psychotraumatologie* (S. 528–536). Stuttgart: Klett-Cotta.

Baas, K.D., Cramer, A.O.J., Koeter, M.W.J., van de Lisdonk, E.H., van Weert, H.C. & Schene, A.H. (2011). Measurement invariance with respect to ethnicity of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). *Journal of Affective Disorders, 129*, 229–235. http://doi.org/10.1016/j.jad.2010.08.026

Bean, T., Derluyn, I., Eurelings-Bontekoe, E., Broekaert, E. & Spinhoven, P. (2007). Validation of the multiple language versions of the Hopkins Symptom Checklist-37 for refugee adolescents. *Adolescents, 42,* 51–71.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Bermejo, I., Mayninger, E., Kriston, L. & Härter, M. (2010). Psychische Störungen bei Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur deutschen Allgemeinbevölkerung. *Psychiatrische Praxis, 37*, 225–232. http://doi.org/10.1055/s-0029-1223513

Bjorner, J.B., Kreiner, S., Ware, J.E., Damsgaard, M.T. & Bech, P. (1998). Differential item functioning in the Danish translation of the SF-36. *Journal of clinical epidemiology, 51*, 1189–1202. http://doi.org/10.1016/S0895-4356(98)00111-5

Böttche, M., Heeke, C. & Knaevelsrud, C. (2016). Sequenzielle Traumatisierungen, Traumafolgestörungen und psychotherapeutische Behandlungsansätze bei kriegstraumatisierten erwachsenen Flüchtlingen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 59,* 621–626.

Brooks, R., Rabin, R. & de Charro, F. (2003). *The measurement and valuation of health status using EQ-5D: A European perspective*. Dordrecht: Kluwer Academic Press. http://doi.org/10.1007/978-94-017-0233-1

Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998). *Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36)*. Göttingen: Hogrefe.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017). *Aktuelle Zahlen zu Asyl*. Zugriff am: 07.02.2017 Verfügbar unter http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2016.pdf?__blob=publicationFile

Chen, F.F. (2008). What happens if we compare chopsticks with forks? The impact of making inappropriate comparisons in cross-cultural research. *Journal of personality and social psychology, 95*, 1005. http://doi.org/10.1037/a0013193

Chiu, C.-Y., Leung, A.K.-Y. & Hong, Y.-Y. (2010). Cultural processes: An overview. In A.K.-Y. Leung, C.-Y. Chiu & Y.-Y. Hong (Eds.), *Cultural processes: A social psychological perspective* (pp. 3–22*)*. New York: Cambridge University Press.

de Fouchier, C., Blanchet, A., Hopkins, W., Bui, E., Ait-Aoudia, M. & Jehel, L. (2012). Validation of a French adaptation of the Harvard Trauma Questionnaire among torture survivors from sub-Saharan African countries. *European Journal of Psychotraumatology, 3*, 3402–19225.

Derogatis, L.R., Lipman, R.S., Rickels, K., Uhlenhuth, E.H. & Covi, L. (1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self-report symptom inventory. *Behavioral science, 19* (1), 1–15. http://doi.org/10.1002/bs.3830190102

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien* (10., überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Ellert, U., Lampert, T. & Ravens-Sieberer, U. (2005). Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem SF-8. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 48*, 1330–1337. http://doi.org/10.1007/s00103-005-1168-5

Feuerherd, M., Knuth, D., Muehlan, H. & Schmidt, S. (2014). Differential Item Functioning (DIF) Analysis of the Impact of Event-Scale-Revised (IES-R): Results From a Large European Study on People With Disaster Experiences. *Traumatology, 20*, 313–320. http://doi.org/10.1037/h0099858

Fuh, J.L., Wang, S.J., Lu, S.R., Juang, K.D. & Lee, S.J. (2000). Psychometric evaluation of a Chinese (Taiwanese) version of the SF-36 health survey amongst middle-aged women from a rural community. *Quality of Life Research, 9*, 675–683. http://doi.org/10.1023/A:1008993821633

Fukuhara, S., Ware, J.E., Kosinski, M., Wada, S. & Gandek, B. (1998). Psychometric and clinical tests of validity of the Japanese SF-36 Health Survey. *Journal of Clinical Epidemiology, 51*, 1045–1053. http://doi.org/10.1016/S0895-4356(98)00096-1

Gäbel, U., Ruf, M., Schauer, M., Odenwald, M. & Neuner, F. (2006). Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35,* 12–20. http://doi.org/10.1026/1616-3443.35.1.12

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Glaesmer, H., Brähler, E., Grande, G., Hinz, A., Petermann, F. & Romppel, M. (2014). The German Version of the Hopkins Symptoms Checklist-25 (HSCL-25) – factorial structure, psychometric properties, and population-based norms. *Comprehensive Psychiatry, 55*, 396–403.

Glaesmer, H., Wittig, U., Brähler, E., Martin, A., Mewes, R. & Rief, W. (2009). Sind Migranten häufiger von psychischen Störungen betroffen? Eine Untersuchung an einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Allgemeinbevölkerung. *Psychiatrische Praxis, 36*, 16–22.

Green, A.R., Ngo-Metzger, Q., Legedza, A.T., Massagli, M.P., Phillips, R.S. & Iezzoni, L.I. (2005). Interpreter services, language concordance, and health care quality. *Journal of General Internal Medicine, 20* (11), 1050–1056. http://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.0223.x

Hargasser, B. (2015). *Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sequentielle Traumatisierungsprozesse und die Aufgaben der Jugendhilfe*. Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel.

Hepner, K.A., Morales, L.S., Hays, R.D., Edelen, M.O. & Miranda, J. (2008). Evaluating differential item functioning of the PRIME-MD mood module among impoverished black and white women in primary care. *Womens Health Issues, 18*, 53–61. http://doi.org/10.1016/j.whi.2007.10.001

Hoffmann, C., McFarland, B.H., Kinzie, J.D., Bresler, L., Rakhlin, D., Wolf, S. & Kovas, A.E. (2005). Psychometric properties of a Russian version of the SF-12 Health Survey in a refugee population. *Comprehensive Psychiatry, 46*, 390–397. http://doi.org/10.1016/j.comppsych.2004.12.002

Horowitz, M., Wilner, N. & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: a measure of subjective stress. *Psychosomatic Medicine, 41*, 209–218. http://doi.org/10.1097/00006842-197905000-00004

Horowitz, M. (1976). *Stress response syndromes*. New York: Jason Aronson.

Huang, F.Y., Chung, H., Kroenke, K., Delucchi, K.L. & Spitzer, R.L. (2006). Using the patient health questionnaire-9 to measure depression among racially and ethnically diverse primary care patients. *Journal of General Internal Medicine, 21*, 547–552. http://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00409.x

Jakobsen, M., Thoresen, S. & Johansen, L.E.E. (2011). The validity of screening for post-traumatic stress disorder and other mental health problems among asylum seekers from different countries. *Journal of Refugee Studies, 24*, 171–186. http://doi.org/10.1093/jrs/feq053

Kao, D.T. (2009). Generational Cohorts, Age at Arrival, and Access to Health Services among Asian and Latino Immigrant Adults. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 20,* 395–414.

Kluge, U. (2011). Sprach- und Kulturmittler im interkulturellen psychotherapeutischen Setting. In W. Machleidt & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie* (S. 145–154). München: Urban & Fischer.

Kocalevent, R.D., Hinz, A. & Brähler, E. (2013). Standardization of a screening instrument (PHQ-15) for somatization syndromes in the general population. *BMC Psychiatry, 13*, 91. http://doi.org/10.1186/1471-244X-13-91

Koch, U. & Brähler, E. (2008). „Migration und Gesundheit" – ein Thema mit hoher Priorität. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 58,* 105–106. http://doi.org/10.1055/s-2008-1067370

Koch, E., Staudt, J. & Gary, A. (2015). Medizinische Versorgung von Migranten. Interkulturelle Öffnung. *Führen und Wirtschaften im Krankenhaus, 10*, 808–813.

Kroenke, K., Spitzer, R.L. & Swindle, R. (1998). A symptom checklist to screen for somatoform disorders in primary care. *Psychosomatics, 39*, 263–272. http://doi.org/10.1016/S0033-3182(98)71343-X

Kroenke, K., Spitzer, R.L. & Williams, J.B.W. (2001). The PHQ-9 – Validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine, 16* (9), 606–613. http://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Kroenke, K., Spitzer, R. L. & Williams, J. B. W. (2002). The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. *Psychosomatic Medicine, 64*, 258–266. http://doi.org/10.1097/00006842-200203000-00008

Kröger, C., Frantz, I., Friel, P. & Heinrichs, N. (2016). Posttraumatische und depressive Symptomatik bei Asylsuchenden. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 66*, 377–384. http://doi.org/10.1055/s-0042-114045

Lam, E. T., Lam, C. L., Fong, D. Y. & Huang, W. W. (2013). Is the SF-12 version 2 Health Survey a valid and equivalent substitute for the SF-36 version 2 Health Survey for the Chinese? *Journal of Evaluation in Clinical Practice, 19*, 200–208.

Lamkaddem, M., Stronks, K., Deville, W. D., Olff, M., Gerritsen, A. A. M. & Essink-Bot, M. (2014). Course of post-traumatic stress disorder and health care utilization among resettled refugees in the Netherlands. *BMC Psychiatry, 14*, 90. http://doi.org/10.1186/1471-244X-14-90

Lee, B., Kaaya, S. F., Mbwambo, J. K., Smith-Fawzi, M. C. & Leshabari, M. T. (2008). Detecting depressive disorder with the Hopkins Symptom Checklist-25 in Tanzania. *International Journal of Social Psychiatry, 54*, 7–20. http://doi.org/10.1177/0020764006074995

Lee, S., Ma, Y. L. & Tsang, A. (2011). Psychometric properties of the Chinese 15-item Patient Health Questionnaire in the general population of Hong Kong. *Journal of Psychosomatic Research, 71*, 69–73. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2011.01.016

Lim, H. K., Woo, J. M., Kim, T. S., Kim, T. H., Choi, K. S., Chung, S. K. et al. (2009). Reliability and validity of the Korean version of the Impact of Event Scale-Revised. *Comprehensive Psychiatry, 50*, 385–390. http://doi.org/10.1016/j.comppsych.2008.09.011

Löwe, B., Spitzer, R. L., Zipfel, S. & Herzog, W. (2002). *Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D). Manual und Testunterlagen*. Karlsruhe: Pfizer.

Maercker, A. (1995). *Harvard Trauma Questionnaire – deutsche Übersetzung*. Unveröffentlichtes Manuskript, Technische Universität Dresden.

Maercker, A. & Bromberger, F. (2005). Checklisten und Fragebogen zur Erfassung traumatischer Ereignisse in deutscher Sprache. *Trierer Psychologische Berichte, 32, Heft 2*.

Maercker, A., Gäbler, I., O'Neil, J., Schützwohl, M. & Müller, M. (2013). Long-term trajectories of PTSD or resilience in former East German political prisoners. *Torture, 23,* 15–27.

Maercker, A. & Schützwohl, M. (1998). Erfassung von psychischen Belastungsfolgen: Die Impact of Event Skala-revidierte Version (IES-R). *Diagnostica, 44*, 130–141.

Mall, V. & Henningsen, P. (2015, 1. September). *Medizinische Versorgung minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland: Eine neue große Herausforderung für die Kinder- und Jugendmedizin*. Pressegespräch, Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e. V. Zugriff am: 07. 02. 2017. Verfügbar unter http://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/images/Presse/Jahrestagung_2015/1509_DGSPJ.pdf

Mels, C., Derluyn, I., Broekaert, E. & Rosseel, Y. (2010). Community-based cross-cultural adaptation of mental health measures in emergency settings: validating the IES-R and HSCL-37A in Eastern Democratic Republic of Congo. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45*, 899–910.

Merbach, M., Wittig, U. & Brähler, E. (2008). Angst und Depression polnischer und vietnamesischer MigrantInnen in Leipzig unter besonderer Berücksichtigung ihres Eingliederungsprozesses. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 58,* 146–154. http://doi.org/10.1055/s-2008-1067351

Mewes, R., Christ, O., Rief, W., Brähler, E., Martin, A. & Glaesmer, H. (2010). Sind Vergleiche im Depressions- und Somatisierungsausmaß zwischen Migranten und Deutschen möglich? Eine Überprüfung der Messinvarianz für den PHQ-9 und PHQ-15. *Diagnostica, 56*, 230–239.

Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S. & Lavelle, J. (1992). The Harvard Trauma Questionnaire: validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma,

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

and posttraumatic stress disorder in Indochinese refugees. *Journal of Nervous and Mental Disease, 180*, 111–116.

Mollica, R. F., Wyshak, G., de Marneffe, D. K., Khuon, F. K. & Lavelle, J. (1987). Indochinese versions of the Hopkins Symptom Checklist-25: a screening instrument for the psychiatric care of refugees. *American Journal of Psychiatry, 144*, 497–500. http://doi.org/10.1176/ajp.144.4.497

Montalbán, S. R., Comas Vives, A. & Garcia-Garcia, M. (2010).Validación de la Versión Española del Cuestionario PHQ-15 para la evaluación de síntomas físicos en pacientes con trastornos de depresión y/o ansiedad: estudio DEPRE-SOMA. *Actas españolas de psiquiatría, 38*, 345–357.

Morfeld, M., Kirchberger, I. & Bullinger, M. (2011). *SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand*. Göttingen: Hogrefe.

Morina, N., Maier, T. & Schmidt Mast, M. (2010). Lost in Translation? – Psychotherapie unter Einsatz von Dolmetschern. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 60*, 104–110. http://doi.org/10.1055/s-0029-1202271

Nesterko, Y. & Glaesmer, H. (2016). Migration und Flucht als Prozess. Theoretische Konzepte und deren klinisch-praktische Bedeutung für die Versorgung traumatisierter Geflüchteter. *Trauma & Gewalt, 4*, 270–286. http://doi.org/10.21706/tg-10-4-270

Nesterko, Y., Kaiser, M. & Glaesmer, H. (2017). Kultursensible Aspekte während der Diagnostik von psychischen Belastungen bei Flüchtlingen – Zwei kommentierte Fallberichte. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 67*, 109–118.

Ngo-Metzger, Q., Sorkin, D. H., Mangione, C. M., Gandek, B. & Hays, R. D. (2008). Evaluating the SF-36 health survey (version 2) in older Vietnamese Americans. *Journal of Aging and Health, 20*, 420–436. http://doi.org/10.1177/0898264308315855

Nordin, S., Palmquist, E. & Nordin, M. (2013). Psychometric evaluation and normative data for a Swedish version of the Patient Health Questionnaire 15-Item Somatic Symptom Severity Scale. *Scandinavian Journal of Psychology, 54*, 112–117. http://doi.org/10.1111/sjop.12029

Petermann, F. & Brähler, E. (2013). *Hopkins-Symptom-Checkliste-25 – Deutsche Version*. Göttingen: Hogrefe.

Power, M., Kuyken, W., Orley, J., Herrman, H., Schofield, H., Murphy, B. et al. (1998). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. *Social Science & Medicine, 46*, 1569–1585. http://doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00009-4

Rasmussen, A., Verkuilen, J., Ho, E. & Fan, Y. (2015). Posttraumatic stress disorder among refugees: Measurement invariance of Harvard Trauma Questionnaire scores across global regions and response patterns. *Psychological Assessment, 27*, 1160. http://doi.org/10.1037/pas0000115

Razum, O., Geiger, I., Zeeb, H. & Ronellenfitsch, U. (2004). Gesundheitsversorgung von Migranten. *Deutsches Ärzteblatt, 101,* 2882–2887.

Razum, O. & Rohrmann, S. (2002). Der Healthy-Migrant-Effekt: Bedeutung von Auswahlprozessen bei der Migration und Late-Entry-Bias. *Gesundheitswesen, 64,* 82–88. http://doi.org/10.1055/s-2002-20271

Razum, O. & Twardella, D. (2004). Niedrige Sterblichkeit unter Migranten – wirklich ein Paradox? Ein Gedankenexperiment. In A. Krämer & L. Prüfer-Krämer (Hrsg.), *Gesundheit von Migranten. Internationale Bestandsaufnahme und Perspektiven* (S. 61–75). Weinheim und München: Juventa.

Renner, W., Salem, I. & Ottomeyer, K. (2006). Cross-cultural validation of measures of traumatic symptoms in groups of asylum seekers from Chechnya, Afghanistan, and West Africa. *Social Behavior and Personality, 34,* 1101–1114. http://doi.org/10.2224/sbp.2006.34.9.1101

Richter, K., Lehfeld, H. & Niklewski, G. (2015). Warten auf Asyl: Psychiatrische Diagnosen in der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Bayern. *Das Gesundheitswesen, 77*, 834–838. http://doi.org/10.1055/s-0035-1564075

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Rommel, A., Saß, A. C., Born, S. & Ellert, U. (2015). Die gesundheitliche Lage von Menschen mit Migrationshintergrund und die Bedeutung des sozioökonomischen Status. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 58* (6), 543–552. http://doi.org/10.1007/s00103-015-2145-2

Schenk, L. (2007). Migration und Gesundheit – Entwicklung eines Erklärungs- und Analysemodells für epidemiologische Studien. *International Journal of Public Health, 52,* 87–96. http://doi.org/10.1007/s00038-007-6002-4

Schouler-Ocak, M., Bretz, H. J., Penka, S., Koch, E., Hartkamp, N., Siefen, R. G. et al. (2008). Patients of immigrant origin in inpatient psychiatric facilities. *European Psychiatry, 23,* 21–27. http://doi.org/10.1016/S0924-9338(08)70058-0

Selmo, P., Koch, T., Brand, J., Wagner, B. & Knaevelsrud, C. (2016). Psychometric Properties of the Online Arabic Versions of BDI-II, HSCL-25, and PDS. *European Journal of Psychological Assessment*. http://doi.org/10.1027/1015-5759/a000367

Siefen, R. G., Glaesmer, H. & Brähler, E. (2011). Interkulturelle psychologische Testdiagnostik. In W. Machleidt & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie* (S. 199–208). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Smith Fawzi, M. C., Murphy, E., Pham, T., Lin, L., Poole, C. & Mollica, R. F. (1997). The validity of screening for post-traumatic stress disorder and major depression among Vietnamese former political prisoners. *Acta Psychiatrica Scandinavica, 95*, 87–93. http://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1997.tb00379.x

Spallek, J. & Razum, O. (2008). Erklärungsmodelle für die gesundheitliche Situation von Migrantinnen und Migranten. Health Inequalities. *Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher Ungleichheit, 1*, 271–290.

Statistisches Bundesamt (2016). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf Rekordniveau*. Pressemitteilung Nr. 327 vom 16. 09. 2016. Zugriff am 07. 02. 2017. Verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/09/PD16_327_122.html

Swinnen, S. & Selten, J. P. (2007). Mood disorders and migration. *British Journal of Psychiatry, 190,* 6–10. http://doi.org/10.1192/bjp.bp.105.020800

Tagay, S., Zararsiz, R., Erim, Y., Düllmann, S., Schlegl, S., Brähler, E. & Senf, W. (2008). Traumatische Ereignisse und Posttraumatische Belastungsstörung bei türkischsprachigen Patienten in der Primärversorgung. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 58,* 155–161.

Tarlov, A. R., Ware, J. E., Greenfield, S., Nelson, E. C., Perrin, E. & Zubkoff, M. (1989). The Medical Outcomes Study: an application of methods for monitoring the results of medical care. *Jama, 262* (7), 925–930. http://doi.org/10.1001/jama.1989.03430070073033

ter Heide, F. J. J., Mooren, T. M. & Kleber, R. J. (2016). Complex PTSD and phased treatment in refugees: a debate piece. *European Journal of Psychotraumatology, 7,* 28687. http://doi.org/10.3402/ejpt.v7.28687

Thumboo, J., Fong, K. Y., Machin, D., Chan, S. P., Leong, K. H., Feng, P. H. & Boe, M. L. (2001). A community-based study of scaling assumptions and construct validity of the English (UK) and Chinese (HK) SF-36 in Singapore. *Quality of Life Research, 10*, 175–188. http://doi.org/10.1023/A:1016701514299

Tinghög, P. & Carstensen, J. (2010). Cross-cultural equivalence of HSCL-25 and WHO (ten) Wellbeing index: findings from a population-based survey of immigrants and non-immigrants in Sweden. *Community Mental Health Journal, 46*, 65–76. http://doi.org/10.1007/s10597-009-9227-2

UNHCR (1951). *Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951*. Zugriff am: 07. 02. 2017. Verfügbar unter http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Utzon-Frank, N., Breinegaard, N., Bertelsen, M., Borritz, M., Eller, N.H., Nordentoft, M. et al. (2014). Occurrence of delayed-onset post-traumatic stress disorder: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 40,* 215–229.

Ventevogel, P., De Vries, G., Scholte, W.F., Shinwari, N.R., Faiz, H., Nassery, R. et al. (2007). Properties of the Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) and the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) as screening instruments used in primary care in Afghanistan. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 42*, 328–335.

Walter, U., Krauth, C., Kurtz, V., Salman, R. & Machleidt, W. (2007). Gesundheit und gesundheitliche Versorgung von Migranten unter besonderer Berücksichtigung von Sucht. *Der Nervenarzt, 78* (9), 1058–1061. http://doi.org/10.1007/s00115-007-2295-z

Ware, J.E. & Sherbourne, C.D. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. *Medical Care, 30,* 473–483. http://doi.org/10.1097/00005650-199206000-00002

Warsini, S., Buettner, P., Mills, J., West, C. & Usher, K. (2015). Psychometric evaluation of the Indonesian version of the Impact of Event Scale-Revised. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22*, 251–259. http://doi.org/10.1111/jpm.12194

Weiss, D.S. & Marmar, C.R. (1997). The Impact of Event Scale – Revised. In J.P. Wilson & T.M. Keanse (Eds.), *Assessing psychological trauma and PTSD* (pp. 399–411). New York: Guilford

Welch, A.E., Caramanica, K., Maslow, C.B., Brackbill, R.M., Stellman, S.D. & Farfel, M.R. (2016). Trajectories of PTSD Among Lower Manhattan Residents and Area Workers Following the 2001 World Trade Center Disaster, 2003–2012. *Journal of Traumatic Stress, 29,* 158–166.

Wittig, U., Lindert, J., Merbach, M. & Brähler, E. (2008). Mental health of patients from different cultures in Germany. *European Psychiatry, 23,* 28–35. http://doi.org/10.1016/S0924-9338(08)70059-2

Zick, A. (2010). *Psychologie der Akkulturation: Neufassung eines Forschungsbereiches*. Berlin: Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-531-92183-9

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.